منظمة
الصحة العالمية

إجراءات التشغيل الموحدة لإدارة سلسلة الإمداد بالمنتجات الصحية اللازمة لعلاج **الأمراض المدارية المهملة** القابلة للعلاج الكيميائي الوقائي



منظمة
الصحة العالمية

إجراءات التشغيل الموحدة لإدارة سلسلة الإمداد بالمنتجات الصحية اللازمة لعلاج **الأمراض المدارية المهملة** القابلة للعلاج الكيميائي الوقائي

إجراءات التشغيل الموحدة لإدارة سلسلة الإمداد بالمنتجات الصحية اللازمة لعلاج الأمراض المدارية المهملة القابلة للعلاج الكيميائي الوقائي
[Standard operating procedures for supply chain management of health products for neglected tropical diseases amenable to preventive chemotherapy]

(نسخة إلكترونية) ISBN 978-92-4-008204-5
(نسخة مطبوعة) ISBN 978-92-4-008205-2

© منظمة الصحة العالمية 2023

بعض الحقوق محفوظة. هذا المصنف متاح بمقتضى ترخيص المشاع الإبداعي "نسب المصنف – غير تجاري – المشاركة بالمثل ٣,٠ لفائدة المنظمات الحكومية الدولية"
(CC BY-NC-SA 3.0 IGO; https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/deed.ar).

وبمقتضى هذا الترخيص يجوز لكم نسخ المصنف وإعادة توزيعه وتحويره للأغراض غير التجارية، شريطة أن يتم اقتباس المصنف على النحو الملائم، كما هو مبيّن أدناه. ولا ينبغي في أي استخدام لهذا المصنف الإيحاء بأن المنظمة (WHO) تعتمد أي منظمة أو منتجات أو خدمات محددة. ولا يُسمح باستخدام شعار المنظمة (WHO). وإذا قمتم بتحوير هذا المصنف، فيجب عندئذٍ الحصول على ترخيص لمصنفكم بمقتضى نفس ترخيص المشاع الإبداعي ((Creative Commons licence أو ما يعادله. وإذا قمتم بترجمة المصنف، فينبغي إدراج بيان إخلاء المسؤولية التالي مع الاقتباس المقترح: "هذه الترجمة ليست من إعداد منظمة الصحة العالمية (المنظمة (WHO)). والمنظمة غير مسؤولة عن محتوى هذه الترجمة أو دقتها. والإصدار الأصلي بالإنكليزية هو الإصدار الملزم وذو الحجية."

ويجب أن تتم أية وساطة فيما يتعلق بالمنازعات التي تنشأ في إطار هذا الترخيص وفقاً لقواعد الوساطة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية(https://www.wipo.int/amc/en/mediation/rules).

الاقتباس المقترح. إجراءات التشغيل الموحدة لإدارة سلسلة الإمداد بالمنتجات الصحية اللازمة لعلاج الأمراض المدارية المهملة القابلة للعلاج الكيميائي الوقائي
[Standard operating procedures for supply chain management of health products for neglected tropical diseases amenable to preventive chemotherapy]

جنيف: منظمة الصحة العالمية: 2023. الترخيص: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
بيانات الفهرسة أثناء النشر. بيانات الفهرسة أثناء النشر متاحة على الرابط
https://iris.who.int/?locale-attribute=ar&.

المبيعات والحقوق والترخيص. لشراء مطبوعات المنظمة (WHO) انظر الرابط https://www.who.int/publications/book-orders. ولتقديم طلبات الاستخدام التجاري والاستفسارات بشأن الحقوق والترخيص، انظر الرابط http://www.who.int/ar/copyright.

مواد الطرف الثالث. إذا رغبتم في إعادة استخدام مواد واردة في هذا المصنف ومنسوبة إلى طرف ثالث، مثل الجداول أو الأشكال أو الصور، فعليكم مسؤولية تحديد ما إذا كان يلزم الحصول على إذن لإعادة الاستخدام، والحصول على إذن من صاحب حقوق المؤلف. ويتحمل المستخدم وحده مخاطر أي مطالبات تنشأ نتيجة انتهاك أي عنصر في المصنف تعود ملكيته لطرف ثالث.

بيانات عامة لإخلاء المسؤولية. لا تنطوي التسميات المستخدمة في هذا المطبوع وطريقة عرض المواد الواردة فيه، على أي رأي كان من جانب المنظمة (WHO) بشأن الوضع القانوني لأي بلد أو أرض أو مدينة أو منطقة أو لسلطات أي منها أو بشأن تحديد حدودها أو تخومها. وتشكل الخطوط المنقوطة والخطوط المتقطعة على الخرائط خطوطاً حدودية تقريبية قد لا يوجد بعد اتفاق كامل بشأنها.

كما أن ذكر شركات محددة أو منتجات جهات صانعة معينة لا يعني أن هذه الشركات والمنتجات معتمدة أو موصى بها من جانب المنظمة (WHO)، تفضيلاً لها على سواها مما يماثلها في الطابع ولم يرد ذكره. وفيما عدا الخطأ والسهو، تُميّز أسماء المنتجات المسجلة الملكية بالأحرف الاستهلالية (في النص الإنكليزي).

وقد اتخذت المنظمة (WHO) كل الاحتياطات المعقولة للتحقق من المعلومات الواردة في هذا المطبوع. ومع ذلك، فإن المواد المنشورة تُوزع دون تقديم أي نوع من أنواع الضمانات، صريحةً كانت أم ضمنية. ويتحمّل القارئ وحده المسؤولية عن تفسير هذه المواد واستعمالها. ولا تتحمل المنظمة (WHO) بأي حال من الأحوال المسؤولية عن الأضرار التي قد تترتب على استعمالها.

الرسم التوضيحي للغلاف: منظمة الصحة العالمية / سام براد Sam Bradd

المحتويات

شكر وتقدير	vi
لمحة عامة	viii
مقدمة	١
١. حزمة الطلبات المشتركة	**٣**
١,١ الغرض من إجراء التشغيل الموحد هذا ونطاقه	٣
٢,١ الاعتبارات الرئيسية	٨
٣,١ إجراء التشغيل الموحد	٩
٤,١ عملية طلب أزيثروميسين	١١
٥,١ إجراء التشغيل الموحد	١٤
المراجع	١٥
٢. إخطار الشحن والضوء الأخضر	**١٧**
١,٢ الغرض من إجراء التشغيل الموحد هذا ونطاقه	١٧
٢,٢ الاعتبارات الرئيسية	١٧
٣,٢ إجراء التشغيل الموحد	١٩
المراجع	٢٤
٣. التخليص الجمركي والتسليم	**٢٥**
١,٣ الغرض من إجراء التشغيل الموحد هذا ونطاقه	٢٥
٢,٣ الاعتبارات الرئيسية	٢٥
٣,٣ إجراء التشغيل الموحد	٢٦
١,٣ معلومات تكميلية	٢٩
المراجع	٢٩
٤. النقل	**٣١**
١,٤ الغرض من إجراء التشغيل الموحد هذا ونطاقه	٣١
٢,٤ الاعتبارات الرئيسية	٣١
٣,٤ إجراء التشغيل الموحد	٣٣
٣,٤ النقل من المقاطعات إلى نقاط تقديم الرعاية	٣٨
٥. إدارة المخزون	**٤١**
١,٥ الغرض من إجراء التشغيل الموحد هذا ونطاقه	٤١
٢,٥ الاعتبارات الرئيسية	٤١
٣,٥ إجراء التشغيل الموحد	٤٢
٦. التخزين	**٤٧**
١,٦ الغرض من إجراء التشغيل الموحد هذا ونطاقه	٤٧
٢,٦ الاعتبارات الرئيسية	٤٧
٣,٦ إجراء التشغيل الموحد	٤٩

٧. ما تنتهي صلاحيته أولاً يُصرف أولاً **٥٧**
١,٧ الغرض من إجراء التشغيل الموحد هذا ونطاقه ٥٧
٢,٧ الاعتبارات الرئيسية ٥٧
٣,٧ إجراء التشغيل الموحد ٥٩
٨. الدورة العكسية للخدمات اللوجستية **٦١**
١,٨ الغرض من إجراء التشغيل الموحد هذا ونطاقه ٦١
٢,٨ الاعتبارات الرئيسية ٦٢
٣,٨ إجراء التشغيل الموحد ٦٢
المرجع ٦٤
٩. إزالة الأدوية المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستعمال **٦٥**
١,٩ الغرض من إجراء التشغيل الموحد هذا ونطاقه ٦٥
٢,٩ الاعتبارات الرئيسية ٦٥
٣,٩ إجراء التشغيل الموحد ٦٦
١٠. إدارة النفايات **٦٩**
١,١٠ الغرض من إجراء التشغيل الموحد هذا ونطاقه ٦٩
٢,١٠ الاعتبارات الرئيسية ٧٠
٣,١٠ إجراء التشغيل الموحد ٧٠
١١. التنبؤ والتقدير الكمي **٧٧**
١,١١ الغرض من إجراء التشغيل الموحد هذا ونطاقه ٧٧
٢,١١ الاعتبارات الرئيسية ٧٧
٣,١١ إجراء التشغيل الموحد ٧٩

الملحق **٨١**
الملحق ١. فهرس المصطلحات والمختصرات الرئيسية ٨١
الملحق ٢. نموذج قائمة الاتصال ٨٥
الملحق ٣. القائمة التفقدية (المرجعية) لبنود الإجراءات والضوء الأخضر ٨٦
الملحق ٤. نموذج تحويل (نقل) المخزون ٨٧
الملحق ٥. نموذج بطاقة المخزون ٨٨
الملحق ٦. نموذج استمارة جرد المخزون الفعلي ٨٩
الملحق ٧. نموذج بطاقة دفتر الموازنة الخاص بالمخزون ٩٠
الملحق ٨. نموذج استمارة إعادة / نقل الأدوية ٩١
الملحق ٩. الأدوات المساعدة على استكمال نموذج إعادة / نقل الأدوية ٩٣
الملحق ١٠. تقرير / سجل الجرد ٩٥
الملحق ١١. نموذج طلب تعديل المخزون ٩٦
الملحق ١٢. أمثلة وثائق النفايات الصيدلانية وتدمير هذه النفايات ٩٨

الجدول

الجدول ١,١	نماذج طلب أدوية العلاج الكيميائي الوقائي وتفاصيل التدبير العلاجي	٤
الجدول ٢,١	الأدوية المتبرع بها لغرض العلاج الكيميائي الوقائي، بحسب شركات الأدوية	٦
الجدول ٣,١	قرارات لجنة خبراء التراخوما بشأن زيثروماكس	١٣
الجدول ٤,١	الجدول الزمني لتقديم طلبات الحصول على زيثروماكس	١٣
الجدول ١,٦	ملخص المعلومات اللوجستية للأدوية المتبرع بها لغرض العلاج الكيميائي الوقائي	٤٨
الجدول ١,١٠	وثائق إدارة النفايات العادية وتدمير هذه النفايات	٧٥
الجدول ٢,١٠	وثائق إدارة النفايات الصيدلانية العادية وتدمير هذه النفايات	٧٦
الجدول ١,١١	معايير التنبؤ بالتقدير الكمي للأدوية المتبرع بها للعلاج الكيميائي الوقائي	٧٨

الشكل

الشكل ١.	مجالات التركيز الرئيسية لإدارة سلسلة الإمداد	ix
الشكل ٢.	إجراءات التشغيل الموحدة بحسب الرقم والجدول الزمني للمعالجة الجموعية	x
الشكل ١,١	عملية تقديم حزمة الطلبات المشتركة	٧
الشكل ٢,١	عملية تقديم طلبات الحصول على أدوية العلاج الكيميائي المتبرع بها	٩
الشكل ١,٢	مثال لمخطط مسار إخطار الشحن الجوي وإجراء الضوء الأخضر	١٩
الشكل ١,٤	الخطوات الرئيسية لنقل الأدوية إلى الميدان	٣٢
الشكل ٢,٤	مثال لمخطط تدفق النقل	٣٣
الشكل ١,٦	التخزين المناسب في علب الكرتون، مع تدوين الوصف وأرقام التشغيلات وتواريخ انتهاء الصلاحية على الواجهة	٥١
الشكل ١,٧	تسجيل تاريخ (تواريخ) انتهاء الصلاحية على كل كرتونة أدوية واردة	٥٨
الشكل ١,١٠	تدمير المخزون	٧٣

شكر وتقدير

توجه منظمة الصحة العالمية الشكر لمنتدى سلسلة الإمداد بأدوية الأمراض المدارية المهملة ولجميع المساهمين في إعداد إجراءات التشغيل الموحدة هذه.

لجنة الكتابة

السيدة كاساندرا هولوواي، برنامج أطفال بلا ديدان، فرقة العمل المعنية بالصحة العالمية، ديكاتور (جورجيا)، الولايات المتحدة الأمريكية.

السيدة كارلا جونسون، المبادرة الدولية لمكافحة التراخوما، فرقة العمل العالمية المعنية بالصحة العالمية، ديكاتور (جورجيا)، الولايات المتحدة الأمريكية.

السيدة بني سميث، وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة، واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة الأمريكية.

الدكتور أفيورك تيكل، إدارة مكافحة الأمراض المدارية المهملة التابعة لمنظمة الصحة العالمية، جنيف، سويسرا.

السيد موديست تزيمبونغ، المشروع الخاص الموسع لمنظمة الصحة العالمية للقضاء على الأمراض المدارية المهملة، برازفيل، الكونغو.

السيد مومين يارو، المبادرة الدولية لمكافحة التراخوما، فرقة العمل العالمية المعنية بالصحة العالمية، ديكاتور (جورجيا)، الولايات المتحدة الأمريكية.

المراجعون[1]

السيدة أبيمبولا أيولا، شركة فايزر Pfizer، لاجوس، نيجيريا.

الدكتورة كريستلي باديلا، مؤسسة هيلين كيلر الدولية، كوناكري، غينيا.

السيدة كاتي كراولي، معهد آر تي آي إنترناشيونال RTI International، واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة الأمريكية.

الدكتور لامين دياوارا، مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي لأفريقيا، برازفيل، الكونغو.

السيد تيم غارنر، مركز الأمراض المدارية المهملة، كلية ليفربول لطب المناطق المدارية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.

الدكتور ماوو فال، معهد آر تي آي انترناشيونال RTI International، مابوتو، موزامبيق.

السيدة شانتيل جينو فيزوس، منظمة سايت سيفرز Sight Savers، بوسطن (ماساشوستس)، الولايات المتحدة الأمريكية.

السيدة مليكة العيدودي، شركة غلاكسو سميث كلاين GlaxoSmithKline، برنتفورد، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.

السيد أليكس جونز، معهد آر تي آي انترناشيونال RTI International، واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة الأمريكية.

الدكتور توان لو آنه، إدارة مكافحة الأمراض المدارية التابعة لمنظمة الصحة العالمية، جنيف، سويسرا.

السيدة لين ليونارد، شركة جونسون آند جونسون Johnson & Johnson، نيوبرانزويك، نيوجيرسي، الولايات المتحدة الأمريكية.

السيدة هيلس ليزيت رويز، شركة Merck S.A de C.V، بلدية Naucalpan de Juárez، المكسيك.

[1] استعرض المراجعون مختلف أجزاء الوثيقة للتأكد من توافقها مع مجال الخبرة وضمان جودتها، ثم عُرضت هذه الأجزاء على لجنة الكتابة للنظر فيها عند وضع الوثيقة في صيغتها النهائية. ولم يكن المراجعون جزءاً من عملية الموافقة النهائية على الوثيقة.

السيد أندرو ماجوسكي، مركز دعم مكافحة الأمراض المدارية المهملة، فرقة العمل المعنية بالصحة العالمية، ديكاتور (جورجيا)، الولايات المتحدة الأمريكية.

السيدة سالاي ماناه، برنامج أطفال بلا ديدان، الفرقة العاملة المعنية بالصحة العالمية، ديكاتور (جورجيا)، الولايات المتحدة الأمريكية.

السيد ت. ج. ويلمان، شركة ستاندرد Standard Co.، أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية.

الدكتور كيسيتو أوغوسان، منظمة FHI 360، واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة الأمريكية.

السيد بنجامين أونجيري، شركة Crown Agents، لندن، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.

السيدة تينا باتيل، شركة Crown Agents، نيروبي، كينيا.

الدكتورة ماريا ريبولو بولو، المشروع الخاص الموسع لمنظمة الصحة العالمية للقضاء على الأمراض المدارية المهملة، برازفيل، الكونغو.

الدكتور كريستيان شروتر، شركة Merck HealthCare KGaA، مدينة دارمشتادت، ألمانيا.

الدكتور غريغوري سيمون، منظمة العلوم الصحية من أجل الصحة، واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة الأمريكية.

السيد هوارد سكارستن، شركة Eisai Manufacturing Ltd ، مدينة هاتفيلد، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.

الدكتورة أيساتو سوغو، مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي لأفريقيا، برازفيل، الكونغو.

السيدة أشلي سورزا، مركز دعم مكافحة الأمراض المدارية المهملة، فرقة العمل المعنية بالصحة العالمية، ديكاتور (جورجيا)، الولايات المتحدة الأمريكية.

السيدة ماريانا ستيفنز، برنامج أطفال بلا ديدان، فرقة العمل المعنية بالصحة العالمية، ديكاتور (جورجيا)، الولايات المتحدة الأمريكية.

السيدة فالنتين تيندي، هيئة الإمدادات الطبية في كينيا، نيروبي، كينيا.

السيدة روسيو فيلاكورتا لينازا، مركز مكافحة الأمراض المدارية المهملة، كلية ليفربول لطب المناطق المدارية، ليفربول، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.

الدكتور يوهانز والتز، شركة Merck HealthCare KGaA ، مدينة دارمشتادت، ألمانيا.

السيد يوهان ويلمز، منظمة سي بي إم الدولية CBM International، هيوستن (تكساس)، الولايات المتحدة الأمريكية.

السيدة تيجانا ويليامز، شركة غلاسكو سميث كلاين، برنتفورد، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.

الدكتورة منى عثمان، إدارة مكافحة الأمراض المدارية المهملة التابعة للمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، القاهرة، مصر

السيدة بسمة محمد صالح، إدارة مكافحة الأمراض المدارية المهملة التابعة للمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، القاهرة، مصر

لمحة عامة

تؤدي منظمة الصحة العالمية دوراً رئيسياً في حلقة إدارة سلسلة الإمداد بالمنتجات الصحية المتبرع بها و/ أو المشتراة لعلاج الأمراض المدارية المهملة القابلة للعلاج الكيميائي الوقائي وللتدبير العلاجي للحالات الفردية.

وتبين هذا الاصدار الاول إجراءات التشغيل الموحدة للمنتجات الصحية اللازمة لعلاج الأمراض المدارية المهملة القابلة للعلاج الكيميائي الوقائي، والأدوية المتبرع بها لعلاج هذه الأمراض. وتشمل هذه الأدوية كلاً من ألبيندازول لعلاج داء الفيلاريات اللمفية ومكافحة الديدان الطفيلية المنقولة بالتربة؛ وأزيثروميسين للتراخوما والداء العليقي؛ وسترات ثنائي ايثيل كاربامازين لداء الفيلاريات اللمفية؛ وإيفرمكتين لداء كلابية الذنب وداء الفيلاريات اللمفية؛ وميبيندازول للديدان الطفيلية المنقولة بالتربة؛ وبرازيكوانتيل لداء البلهارسيات؛ وتريكلابيندازول للديدان المثقوبة المنقولة بالأغذية.

وستغطي الطبعات اللاحقة إجراءات التشغيل الموحدة للأمراض القابلة للتدبير العلاجي للحالات الفردية، بما في ذلك عملية تقديم طلبات الحصول على الأدوية (الفصل ١). وفي الوقت نفسه، تنطبق الإجراءات المبينة في بقية الوثيقة على كلٍ من التدبير العلاجي للحالات الفردية والمنتجات الصحية اللازمة للعلاج الكيميائي الوقائي للأمراض المدارية المهملة.

وقد أعدت منظمة الصحة العالمية ومنتدى سلسلة الإمداد بأدوية الأمراض المدارية المهملة هذه المجموعة من إجراءات التشغيل الموحدة من أجل بيان الخصائص الرئيسية في سياق إدارة سلسلة الإمداد بالمنتجات الصحية، بما في ذلك الأدوية المتبرع بها للاستخدام في المعالجة الدوائية الجموعية (المعالجة الجموعية) على المستوى القطري. وتُشجع وزارات الصحة والبرامج الوطنية لمكافحة الأمراض المدارية المهملة على مواءمة وتكييف هذه الإجراءات بما يناسب سياقها الوطني.

دور سلسلة الإمداد في المعالجة الجموعية

تؤدي المعالجة الجموعية دوراً في الوقاية الأولية من الأمراض المدارية المهملة القابلة للعلاج الكيميائي الوقائي، وذلك بخفض معدلات انتقال العدوى لدى الفئات السكانية المعرضة للخطر. وتتوقف فعالية استراتيجية المعالجة الجموعية على نسبة التغطية الوبائية، التي تُعرَّف في الأهداف المُوصى بها من منظمة الصحة العالمية بأنها نسبة السكان الذين تلقوا الأدوية في سياق المعالجة الجموعية.

ولتحقيق أهداف التغطية، يجب إدارة سلسلة الإمداد، بدايةً من التخطيط والتقدير الكمي للاحتياجات، مروراً بنقل المخزون من مواقع الإنتاج إلى المرضى في نقطة تقديم الخدمات إلى المجتمعات المحلية والمدارس والمستشفيات، وغير ذلك، وانتهاءً باستعادة وحساب المخزون المتبقي، بما يشمل جميع الخطوات في الفترة البينية، على النحو المبين في الشكل ١.

أغراض إجراءات التشغيل الموحدة هذه

الغرض من إجراءات التشغيل الموحدة هذه هو المساعدة على تعزيز قدرة وزارات الصحة والبرامج الوطنية لمكافحة الأمراض المدارية المهملة على تعميم وترسيخ الإدارة الفعالة لسلسلة الإمداد بأدوية الأمراض المدارية المهملة. وتحدد هذه الإجراءات مهام ومسؤوليات سلسلة الإمداد قبل المعالجة الجموعية وأثناءها وبعدها. وتعرض هذه الإجراءات أيضاً الاعتبارات الرئيسية الرامية إلى تخطيط وتنفيذ أنشطة سلسلة الإمداد على النحو الأمثل في البلد.

وتدعم هذه الإجراءات تحقيق الهدف المحدد في خارطة طريق منظمة الصحة العالمية لعام ٢٠٣٠ المتعلقة بالأمراض المدارية المهملة، وهو: وجود سلسلة إمداد فعالة تضمن إتاحة وتوافر الأدوية والمنتجات والإمدادات الصيدلانية المضمونة الجودة في الوقت المناسب على جميع المستويات، وتجنب نفاد المخزون والهدر وفقدان الأقراص (١).

الجمهور المستهدف

الغرض من الإجراءات هو أن تكون وثيقة مرجعية يستخدمها الأشخاص المسؤولون والجهات الرئيسية صاحبة المصلحة في سلسلة الإمداد بأدوية الأمراض المدارية المهملة، على النحو المبين أدناه.

ويشمل الأشخاص المسؤولون والجهات الرئيسية صاحبة المصلحة كلاً من المنظمات والأفراد.

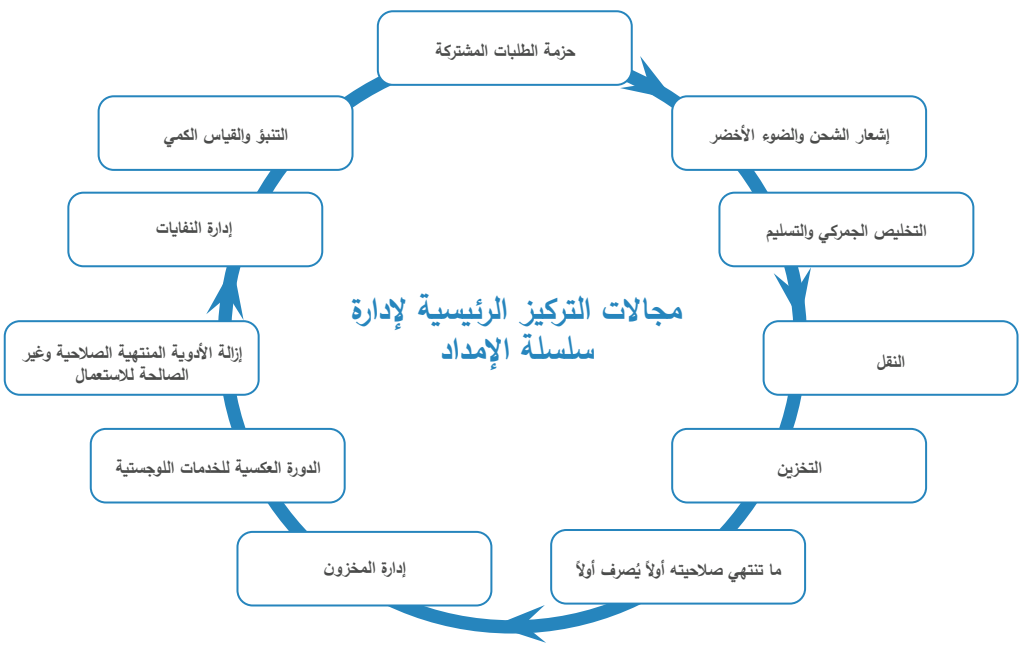
المنظمات

وزارات الصحة، والبرامج الوطنية لمكافحة الأمراض المدارية المهملة، والمخازن الطبية المركزية، والوكالات الوطنية للمشتريات والخدمات اللوجستية، والمخازن الطبية في الأقاليم والمقاطعات، والمرافق الصحية في الخطوط الأمامية، والمدارس، والمؤسسات التعليمية الوطنية.

الأفراد

موظفو البرامج الوطنية لمكافحة الأمراض المدارية المهملة والجهات صاحبة المصلحة، وموظفو المخازن الطبية على جميع المستويات – الصيادلة ومديرو المستودعات، ومسؤولو الاتصال المعنيون بالأمراض المدارية المهملة والمشرفون على المعالجة الجموعية، والعاملون في صحة المجتمع، وموزعو الأدوية في المجتمع.

الشكل ١. مجالات التركيز الرئيسية لإدارة سلسلة الإمداد



إجراءات التشغيل الموحدة بحسب الرقم والجدول الزمني للمعالجة الجموعية

يعرض الشكل ٢ الـ ١١ إجراءً بترتيبها قبل المعالجة الجموعية وأثناءها وبعدها.

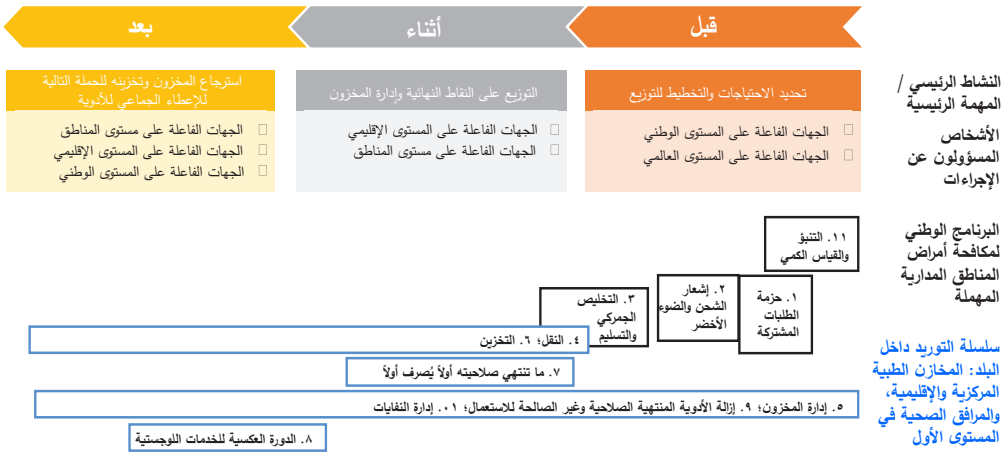
نموذج لإجراءات التشغيل الموحدة

يُستخدم النموذج التالي لكل إجراء من الـ ١١ إجراءً

المهمة	التعليمات	المسؤولية	المراجع
الإطار الزمني المحدد للمهام في هذا الجزء من العملية	الدور (الأدوار) الوظيفية الرئيسية للمسؤولين عن المهام المحددة في هذا الجزء من العملية	النقاط الرئيسية للمهام المحددة في هذا الجزء من العملية	التعليمات الرئيسية في هذا الجزء من العملية، بحسب ترتيب النشاط و/ أو على النحو المدرج في الجدول

والمواقف والأدوار المحددة تحت عنوان **المسؤولية** وعنوان **التعليمات** لكل **مهمة** هي أمثلة توضيحية وينبغي تعديلها بحسب السياق المحلي. وترد تحت عنوان **المراجع** أرقام الفصول للإجراءات ذات الصلة والتوجيهات الأخرى ذات الصلة. ويرد فهرس للمصطلحات في **الملحق ١**. وترد نماذج للاستمارات وأمثلة للوثائق في **الملاحق من ٢ إلى ١٢**. وفي حالة الحاجة إلى المساعدة في إعداد النماذج، يُرجى الاتصال بالمنظمة لتلقي المساعدة (PC_JointForms@who.int).

الشكل ٢. إجراءات التشغيل الموحدة بحسب الرقم والجدول الزمني للمعالجة الجموعية



المهمة	التعليمات	المسؤولية	المراجع
١.	التعليمات موضحة في عبارة واحدة ١,١. الخطوات المفصلة المطلوبة لتنفيذ التعليمات ٢,١ ٣,١	الدور (الأدوار) الرئيسية للمسؤول عن التعليمات المحددة	الفصول الخاصة بالإجراءات والتوجيهات والملاحق ذات الصلة

النشر والتنفيذ

يمكن استخدام إجراءات التشغيل الموحدة هذه لتوجيه أو تكميل الإجراءات الوطنية القائمة المتعلقة بإدارة سلسلة الإمداد بالسلع الصحية الأساسية. وحيثما لا توجد إجراءات من هذا القبيل أو كانت لا تتناول أدوية مكافحة الأمراض المدارية المهملة، يمكن مواءمة الإجراءات الواردة في هذه الوثيقة بما يلائم السياق القطري والبرنامج الوطني. وستضيف منظمة الصحة العالمية إجراءات إضافية بحسب الحاجة بناءً على ما يرد من تعقيب من البلدان. وللحصول على المعلومات والمساعدة، يُرجى الاتصال بالمنظمة على البريد الالكتروني التالي: (PC_JointForms@who.int).

المرجع

١. وضع حد للتهاون في السعي لبلوغ أهداف التنمية المستدامة: خارطة طريق خاصة بأمراض المناطق المدارية المهملة، ٢٠٢١ – ٢٠٣٠. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ ٢٠٢٠ (https://apps.who.int/iris/handle/10665/338565)، اطُلع عليه في ١٨ آذار / مارس ٢٠٢٢).



الرسم التوضيحي: منظمة الصحة العالمية / سام براد Sam Bradd

مقدمة

يُعد العلاج الكيميائي الوقائي والتدبير العلاجي للحالات الفردية من الاستراتيجيات الأساسية لمكافحة الأمراض المدارية المهملة أو التخلص منها أو استئصالها. وتشكل المنتجات الصحية (الأدوية وأدوات التشخيص وغير ذلك من الإمدادات) المتبرع بها لهذا الغرض الأساس لنجاح برامج مكافحة الأمراض المدارية المهملة. ويكفل التنسيق العالمي الذي تقوده منظمة الصحة العالمية توفير الأدوية للبلدان التي تتوطنها الأمراض المدارية المهملة لضمان الاستخدام الرشيد لهذه الأدوية والإبلاغ عنها ورصدها وتقييمها والمساءلة عنها. ويسهم هذا التنسيق العالمي أيضاً في تحقيق النتيجة ١–٣ من برنامج العمل العام الثالث عشر للمنظمة للفترة ٢٠١٩ – ٢٠٢٣ (تحسين إتاحة الأدوية الأساسية واللقاحات ووسائل التشخيص والأجهزة اللازمة للرعاية الصحية الأولية)، وأهداف خارطة الطريق المتعلقة بالأمراض المدارية المهملة لعام ٢٠٣٠ (١)، والغاية ٣–٨ من أهداف التنمية المستدامة (تحقيق التغطية الصحية الشاملة، بما في ذلك حصول الجميع على الأدوية واللقاحات الأساسية المأمونة والفعالة والجيدة والميسورة التكلفة).

وتتولى منظمة الصحة العالمية إدارة معظم المنتجات الصحية اللازمة للأمراض المدارية المهملة، وهي المنتجات التي تتبرع بها شركات الأدوية أو تشتريها المنظمة لكي تستخدمها الدول الأعضاء. وتتمثل الأدوار الرئيسية للمنظمة في التنسيق مع البلدان التي تتوطنها الأمراض والجهات المتبرعة بالأدوية والتواصل فيما بينها، وضمان أن تكون كميات الأدوية المطلوبة مناسبة وأن تُوزع توزيعاً فعالاً ورشيداً.

وتؤدي المنظمة دوراً رئيسياً في حلقة إدارة سلسلة الإمداد بالمنتجات الصحية المتبرع بها لعلاج الأمراض المدارية المهملة القابلة للعلاج الكيميائي الوقائي والتدبير العلاجي للحالات. وتيسّر المنظمة التقدير الكمي للأدوية والتنبؤ بها، فضلاً عن مراجعة ومعالجة طلبات الحصول على الأدوية في الوقت المناسب. وتنسق المنظمة أيضاً الترتيبات اللوجستية مع شركات الأدوية ووكلاء الشحن العالميين لضمان إتاحة المنتجات الصحية المأمونة والمضمونة الجودة بسهولة وإنصاف ويسر مجاناً للفئات السكانية المحتاجة إليها. وتقدم المنظمة المساعدة التقنية للدول الأعضاء في إدارة ورصد أرصدة المخزونات، والتقليل إلى أقل حد من النفايات، وتجنب انتهاء صلاحية الأدوية. وعموماً، تعمل المنظمة على تحسين سبل حصول المتضررين من الأمراض المدارية المهملة على التغطية الصحية الشاملة، وتدعم المجتمع العالمي المعني بالأمراض المدارية المهملة في التشغيل السلس لدورة إدارة سلسلة الإمداد.

ويواجه مجتمع الأمراض المدارية المهملة العالمي، مثله مثل العديد من القطاعات الصحية الأخرى، العديد من التحديات والعوائق التي تعترض دورة إدارة سلسلة الإمداد. وتشمل هذه التحديات والعوائق اختيار المنتجات الصحية، والتقدير الكمي لها والتنبؤ بها، وتخطيط الإمدادات وشراءها حتى التسليم والاستهلاك النهائيين، والإبلاغ من وحدات الرعاية الصحية الأولية إلى المستويات الوطنية، والامتثال لمتطلبات المساءلة والشفافية كضمان لاستدامة سلسلة الإمداد بالمنتجات الصحية المتبرع بها. وكما هو الحال في العديد من مجالات الصحة، ترتبط معظم المسائل بالقدرات، والموارد المالية، والهياكل الأساسية، والموارد البشرية، ونقص الأدوات والوعي في سياق إدارة المنتجات الصحية الأساسية.

ويفرض طابع الحملات الذي تتسم به برامج مكافحة الأمراض المدارية المهملة ضغطاً خاصاً على نظم إدارة سلسلة الإمداد في البلدان التي تتوطنها هذه الأمراض، حيث تتطلب هذه البرامج إمدادات ضخمة من الأدوية ووسائل التشخيص والمنتجات الطبية الأخرى في أُطُر زمنية ضيقة نسبياً لأغراض المعالجة الجموعية أو الدراسات الاستقصائية أو الأحداث الأخرى التي تأخذ طابع الحملات.

وعقب عملية تقييم تشاورية مع الدول الأعضاء، تم تحديد ١١ مجالاً رئيسياً لسلاسل الإمداد وترتيب أولوياتها، ووضع الأعضاء في منتدى سلسلة الإمداد بأدوية الأمراض المدارية المهملة مجموعة من إجراءات التشغيل الموحدة المحددة.

وتهدف هذه الإجراءات إلى المساعدة في تعزيز قدرات وزارات الصحة وبرامج مكافحة الأمراض المدارية المهملة على تعميم وترسيخ الإدارة الفعالة لسلسلة الإمداد بالمنتجات الصحية اللازمة لمكافحة هذه الأمراض، بما في ذلك توفير الأدوية المتبرع بها. وتحدد هذه الإجراءات مهام ومسؤوليات سلسلة الإمداد بالأدوية قبل المعالجة الجموعية وأثناءها وبعدها، وتعرض الاعتبارات الرئيسية المتعلقة بتخطيط وتنفيذ الأنشطة ذات الصلة داخل البلدان. والغرض من الإجراءات أن تكون بمثابة نماذج تكيفها البلدان بما يناسب سياقاتها الخاصة، بداية من المستوى الوطني إلى مستوى وحدات الرعاية الصحية الأولية. والقصد من ذلك هو مساعدة العاملين الصحيين على تحسين مهاراتهم في التعامل مع السلع الصحية الأساسية ذات الصلة بالأمراض المدارية المهملة وتسليمها وإدارتها، وأن توفر نقطة انطلاق لإدارة المنتجات الصحية الأساسية اللازمة للبرامج الصحية لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية.

المرجع

١. وضع حد للتهاون في السعي لبلوغ أهداف التنمية المستدامة: خارطة طريق خاصة بأمراض المناطق المدارية المهملة، ٢٠٢١ – ٢٠٣٠. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ ٢٠٢٠ (https://apps.who.int/iris/handle/10665/338565، اطُلع عليه في ١٨ آذار / مارس ٢٠٢٢).

١. حزمة الطلبات المشتركة

تنسق برامج منظمة الصحة العالمية المتعلقة بالأمراض المدارية المهملة عمليات التبرع بالمنتجات الصحية اللازمة لمكافحة الأمراض القابلة لكل من العلاج الكيميائي الوقائي والتدبير العلاجي للحالات و/ أو شراء هذه المنتجات. ويبين هذا الفصل إجراءات طلب الأدوية اللازمة للعلاج الكيميائي الوقائي للأمراض. تُجمع معظم الطلبات معاً وتُقدم من خلال حزمة الطلبات المشتركة؛ وتُستخدم نماذج منفصلة لطلب أدوية علاج الديدان المثقوبة المنقولة بالأغذية، وداء الشريطيات، وداء الكيسات المذنَّبة، والتراخوما، والداء العليقي. وتُدرج بعد ذلك معظم هذه الاستمارات في حزمة الطلبات المشتركة في الوقت المناسب (انظر **الجدول** ١,١ للاطلاع على التفاصيل). أما الأمراض التي تتطلب تدبيراً علاجياً للحالات فلها نماذج خاصة لطلب الأدوية وعمليات خاصة لإدارة التبرع، وهي أمور تتجاوز نطاق هذا الفصل. وفي نهاية المطاف، ستُدمج جميع طلبات الحصول على الأدوية وستُدرج في الطبعات اللاحقة من هذه الوثيقة.

١,١ الغرض من إجراء التشغيل الموحد هذا ونطاقه

يوفر هذا الإجراء توجيهات تقنية للبرامج الوطنية لمكافحة الأمراض المدارية المهملة وللشركاء المنفذين بشأن إعداد وتقديم حزمة الطلبات المشتركة للحصول على أدوية العلاج الكيميائي الوقائي

وتتألف حزمة الطلبات المشتركة من مجموعة من أربعة نماذج، هي:

- الطلب المشترك للحصول على أدوية مختارة؛
- نموذج الإبلاغ المشترك؛
- نموذج الإبلاغ الوبائي؛
- خطة العمل السنوية (اختيارية).

ينبغي أن يُقدم كلّ من الطلب المشترك للحصول على أدوية مختارة، وخطة العمل السنوية، قبل تسعة أشهر على الأقل من الموعد المقرر للمعالجة الدوائية الجموعية. وينبغي أن يُقدم نموذج الإبلاغ المشترك في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر بعد استكمال جولة التنفيذ الأخيرة في عام الإبلاغ. وتشكل هذه المرحلة المبكرة من التخطيط للمعالجة الجموعية خطوة لازمة للبلدان لكي تتلقى مخصصاتها من الأدوية

الجدول ١,١. نماذج طلب أدوية العلاج الكيميائي الوقائي وتفاصيل التدبير العلاجي

الدواء	المرض	نموذج طلب الدواء	عملية الاستعراض	منسق التبرع
سترات ثنائي ايثيل كارباميازين (مغم ١٠٠ أقراص)	الفيلاريات اللمفية	طلب مشترك لأدوية مختارة	الفريق الإقليمي لاستعراض البرامج	منظمة الصحة العالمية
ميبيندازول (مغم ٥٠٠ أقراص)	الديدان الطفيلية المنقولة بالتربة [١]	طلب مشترك لأدوية مختارة	الفريق الإقليمي لاستعراض البرامج	منظمة الصحة العالمية
ألبيندازول (مغم ٤٠٠ أقراص)	الفيلاريات اللمفية	طلب مشترك لأدوية مختارة	الفريق الإقليمي لاستعراض البرامج	منظمة الصحة العالمية
	الديدان الطفيلية المنقولة بالتربة	طلب مشترك لأدوية مختارة	الفريق الإقليمي لاستعراض البرامج	منظمة الصحة العالمية
برازيكوانتيل (مغم ٦٠٠ أقراص)	البلهارسيات	طلب مشترك لأدوية مختارة	الفريق الإقليمي لاستعراض البرامج	منظمة الصحة العالمية
إيفرمكتين (مغم ٣ أقراص)	كلابية الذنب	طلب مشترك لأدوية مختارة	لجنة خبراء مكتيزان	برنامج مكتيزان للتبرع
	الفيلاريات اللمفية في البلدان الموطونة بالمرض	طلب مشترك لأدوية مختارة	لجنة خبراء مكتيزان	برنامج مكتيزان للتبرع
	الفيلاريات اللمفية – المعالجة الدوائية الجموعية بثلاثة أدوية	طلب مشترك لأدوية مختارة	لجنة خبراء مكتيزان	برنامج مكتيزان للتبرع
أزيثروميسين (أقراص ٢٥٠ مغم أو ١٢٠٠ مغم في ٣٠ ملي لتر [٢٠٠ مغم / ٥ ملي لتر]) مسحوق لعمل مستعلق فموي	التراخوما	نموذج رصد التخلص من التراخوما	لجنة خبراء التراخوما	المبادرة الدولية لمكافحة التراخوما
أزيثروميسين (مغم ٥٠٠ أقراص)	الداء العليقي	نموذج طلب مستقل	منظمة الصحة العالمية	منظمة الصحة العالمية
تريكلابيندازول (مغم ٢٥٠ أقراص)	الديدان المثقوبة المنقولة بالأغذية	نموذج طلب مستقل	منظمة الصحة العالمية	منظمة الصحة العالمية
برازيكوانتيل (مغم ٦٠٠ أقراص) أو نيكلوزاميد (مغم ٤٠٠ أقراص)	داء الشريطيات وداء الكيسات المذنبة	نموذج طلب مستقل	منظمة الصحة العالمية	منظمة الصحة العالمية

JRSM: Joint Request for Selected Medicines; MDA: mass drug administration; MEC: Mectizan Expert Committee; RPRG: Regional Programme Review Group; TEC: Trachoma Expert Committee; TEMF: trachoma elimination monitoring form.

وتيسّر منظمة الصحة العالمية الإمداد بالعديد من الأدوية المتبرع بها لغرض العلاج الكيميائي الوقائي في إطار الجهود العالمية الرامية إلى الإسراع بتوسيع نطاق مكافحة داء الفيلاريات اللمفية وداء كلابية الذنب والديدان الطفيلية المنقولة بالتربة والتخلص منها. وفيما يلي الأدوية (بالترتيب الأبجدي):

- ألبيندازول للفيلاريات اللمفية والديدان الطفيلية المنقولة بالتربة؛
- أزيثروميسين للداء العليقي؛
- سترات ثنائي ايثيل كاربامازين للفيلاريات اللمفية؛
- إيفرمكتين لداء كلابية الذنب والفيلاريات اللمفية؛
- ميبيندازول للديدان الطفيلية المنقولة بالتربة؛
- نيكلوزاميد أو برازيكوانتيل لداء الشريطيات وداء الكيسات المذنبة؛
- برازيكوانتيل لداء البلهارسيات؛
- تريكلابيندازول للديدان المثقوبة المنقولة بالأغذية.

وتيسّر الآلية المشتركة ومجموعة من النماذج عملية تقديم الطلبات وتحسّن التنسيق والتكامل فيما بين برامج مكافحة الأمراض المدارية المهملة. وتهدف هذه الآلية المصممة بصيغة إكسل excel إلى مساعدة البلدان في تحديد عدد أقراص كل دواء مطلوب لبلوغ الفئة السكانية والمناطق المستهدفة في سنة الطلب. والناتج هو طلب مشترك للحصول على أدوية العلاج الكيميائي الوقائي، وهو طلب يمكن طباعته وتوقيعه وتقديمه إلى منظمة الصحة العالمية.

(تماثل عملية التبرع بأزيثروميسين، لغرض التخلص من التراخوما بوصفها مشكلة صحية عمومية، عملية التبرع بأدوية العلاج الكيميائي الوقائي؛ ويرد في القسم ١,٥,١ بيان لعملية تقديم الطلبات المستقلة والجدول الزمني. ويبين الجدول ٢,١ مزيداً من تفاصيل الأدوية التي تتبرع بها شركات الأدوية لغرض العلاج الكيميائي الوقائي).

١,١,١ تخطيط عملية تقديم الطلبات

- تيسّر مجموعة النماذج الأربعة عملية تقديم طلبات الحصول على الأدوية والإبلاغ عن استخدامها والتخطيط لتوزيعها أثناء المعالجة الجموعية.
- هذه النماذج "مشتركة" لأن من الممكن استخدامها لطلب الخمس أدوية الخاصه بالعلاج الكيميائى الوقائى والتى يتم التبرع بها من خلال المنظمة، وللإبلاغ عن هذه الأدوية والتخطيط لتوزيعها؛ وتشكل هذه النماذج حزمة طلبات مشتركة وينبغي تقديمها معاً (**الشكل** ١,١).
- لضمان تسليم الأدوية في الوقت المحدد، ينبغي تقديم طلبات الحصول على أدوية العلاج الكيميائي الوقائي قبل تسعة أشهر من التاريخ (التواريخ) المقررة للمعالجة الجموعية، بغض النظر عن الوقت المقرر لها.
- **يمكن وينبغي للبلدان تقديم طلباتها في أي وقت أثناء العام.**
  - مثلاً، إن كان البلد يخطط لتنفيذ المعالجة الجموعية في تشرين الأول / أكتوبر ٢٠٢١، ينبغي للبلد أن يقدم حزمة الطلبات المشتركة بحلول كانون الثاني / يناير ٢٠٢١ ودون انتظار أي موعد نهائي.
  - البلدان مسؤولة عن تخطيط حزم الطلبات المشتركة الخاصة بها، لضمان وصول الأدوية في الموعد المحدد للمعالجة الجموعية؛ وتحتاج أيضاً المنظمة وشركات الأدوية إلى مهلة مناسبة لضمان دقة الطلبات، ولتصنيع وشحن الأدوية، ثم للتخليص الجمركي على الأدوية في البلد. لهذا السبب يجب تقديم الطلب قبل تسعة أشهر من موعد المعالجة الجموعية.
- عند تقديم الطلب في عام ٢٠٢١، مثلاً، ينبغي أن يتضمن الطلب معلومات عن الأنشطة المخططة وطلباً للحصول على الأدوية التي ستُستخدم في العام س + ١ (أي عام ٢٠٢٢)، بالإضافة إلى تقرير عن تدخلات العلاج الكيميائي الوقائي التي جرت في العام س – ١ (أي عام ٢٠٢٠).

الجدول ٢,١ الأدوية المتبرع بها لغرض العلاج الكيميائي الوقائي، بحسب شركات الأدوية

الشركة (الموقع)	الدواء	الكمية المتبرع بها	المرض	الالتزام	منسق التبرع
Eisai (اليابان)	سترات ثنائي ايثيل كاربامازين (١٠٠ مغم)	٢ ٢٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ قرص إجمالاً	الفيلاريات اللمفية	إلى حين التخلص من المرض	منظمة الصحة العالمية
Johnson & Johnson (الولايات المتحدة)	ميبيندازول (٥٠٠ مغم)	٢٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ قرص سنوياً	الديدان الطفيلية المنقولة بالتربة [١]	حتى عام ٢٠٢٥	منظمة الصحة العالمية
GlaxoSmithKline (المملكة المتحدة)	ألبيندازول (أقراص ٤٠٠ مغم)	٦٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ قرص سنوياً	الفيلاريات اللمفية	إلى حين التخلص من المرض	منظمة الصحة العالمية
		٤٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ قرص سنوياً	الديدان الطفيلية المنقولة بالتربة [١]	إلى حين التخلص من المرض	منظمة الصحة العالمية
Merck KGaA (ألمانيا)	برازيكوانتيل (٦٠٠ مغم)	٢٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠ قرص سنوياً	داء البلهارسيات [١]	غير محدود	منظمة الصحة العالمية
Merck, Sharpe and Dorne (الولايات المتحدة)	إيفرمكتين (٣ مغم)	غير محدود	داء كلابية الذنب	إلى حين التخلص من المرض	برنامج مكتيزان للتبرع
		غير محدود	الفيلاريات اللمفية في البلدان الموطونة بالمرض	إلى حين التخلص من المرض [٢]	برنامج مكتيزان للتبرع
		حتى ١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ معالجة سنوياً	الفيلاريات اللمفية – المعالجة الجموعية بثلاثة أدوية	حتى عام ٢٠٢٥	برنامج مكتيزان للتبرع
Pfizer (الولايات المتحدة)	أزيثروميسين (أقراص ٢٥٠ مغم أو ١٢٠٠ مغم في ٣٠ ملي لتر (٢٠٠ مغم / ٥ ملي لتر) مسحوق لعمل مستعلق فموي)	غير محدود	التراخوما	١٩٩٨ – ٢٠٢٥	المبادرة الدولية لمكافحة التراخوما
Bayer (ألمانيا)	نيكلوزاميد (٤٠٠ مغم)	حتى ما مجموعه ٢ ٨٠٠ ٠٠٠ قرص	داء الشريطيات وداء الكيسات المذنبة	٢٠٢٠ – ٢٠٢٤	منظمة الصحة العالمية
	برازيكوانتيل (٦٠٠ مغم)	حتى ما مجموعه ١ ٣٣٩ ٠٠٠ قرص			
EMS SA Pharma (البرازيل)	أزيثروميسين (٥٠٠ مغم)	١٥٣ مليون قرص	الداء العليقي	٢٠١٩ – ٢٠٢٣	منظمة الصحة العالمية

المصدر: مقتبس من الشكل ١١ من المرجع (٢).

[١] لعلاج الأطفال في سن المدرسة.

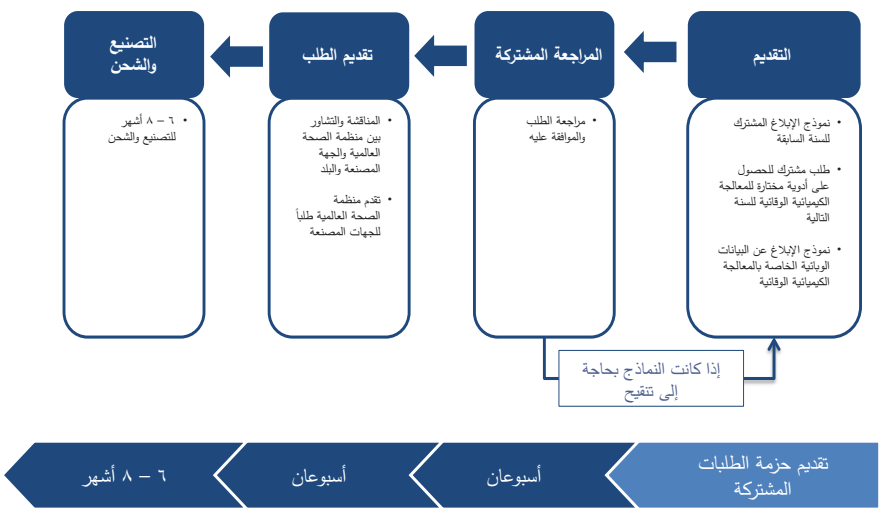
[٢] في اليمن والبلدان الأفريقية التي يتوطنها كل من الفيلاريات اللمفية وداء كلابية الذنب.

يرد أدناه توضيح للنماذج الأربعة واستعمالاتها.

- **الطلب المشترك للحصول على أدوية مختارة للعلاج الكيميائي الوقائي** (الإصدارة ١,٣). ينبغي استخدام هذا النموذج لطلب أدوية ألبيندازول، وسترات ثنائي ايثيل كاربامازين، وإيفرمكتين، وميبيندازول، وبرازيكوانتيل لاستخدامها في العام التالي لعام تقديم الطلب.
  - بالنسبة لدواء إيفرمكتين، تتشارك أيضاً المنظمة نسخة من هذا النموذج مع برنامج مكتيزان للتبرع، باستخدام نموذج الطلب المشترك لأدوية مختارة (انظر الجدول ١,١).
  - بالنسبة للعلاج الثلاثي بإيفرمكتين وسترات ثنائي ايثيل كاربامازين وألبيندازول، لا يلزم تقديم طلب مشترك مستقل أو نموذج الإبلاغ المشترك. ومع ذلك، يتطلب برنامج مكتيزان للتبرع وثائق إضافية للتبرع بإيفرمكتين. وتُلخص عملية تقديم الطلبات في القسم ٢,٣,١.
  - ينبغي للبلدان التي يتوطنها أيضاً داء اللوائيات أن تستخدم نسخة محددة من الطلب المشترك المتعلق بأدوية مختارة لطلب الحصول على ألبيندازول لغرض تدخلات علاج الفيلاريات اللمفية في المناطق التي لا يتوطنها داء كلابية الذنب ولكن يتوطنها داء اللوائيات.

    استثناء: لا يمكن استخدام نموذج الطلب المشترك لطلب الحصول على أزيثروميسين لعلاج التراخوما أو الحصول على تريكلابيندازول لعلاج داء المتورقات وداء جانبية المناسل؛ بل تُتبع عملية مستقلة لتقديم الطلب (انظر القسم ١,٥,١).
- **نموذج الإبلاغ المشترك**. الغرض من هذا النموذج هو مساعدة البلدان على الإبلاغ بشكل موحد عن التقدم السنوي المحرز في التوزيع المتكامل والمنسق للأدوية المخصصة لجميع الأمراض في عام الإبلاغ.
  - ينبغي للبلدان التي تتوطنها أيضاً دودة العين Loa Loa استخدام نسخة محددة من نموذج الإبلاغ المشترك لغرض الإبلاغ عن تدخلات علاج الفيلاريات اللمفية في المناطق التي لا يتوطنها داء كلابية الذنب ولكن يتوطنها داء اللوائيات.
- **نموذج الإبلاغ الوبائي**. الغرض من هذا النموذج هو توحيد عملية الإبلاغ الوطني للبيانات الوبائية المتعلقة بالفيلاريات اللمفية، وداء كلابية الذنب، وداء البلهارسيات، والديدان الطفيلية المنقولة بالتربة. وتُشجع السلطات الوطنية على استكمال هذا النموذج وتقديمه سنوياً إلى المنظمة، مرفقاً به نموذج الإبلاغ المشترك.

الشكل ١,١. عملية تقديم حزمة الطلبات المشتركة



PC: المعالجة الكيميائية الوقائية

- **خطة العمل السنوية**. يقدم هذا النموذج معلومات عن أنشطة العلاج الكيميائي الوقائي والأنشطة الجانبية الرئيسية التي تخططها وزارات الصحة لعلاج الفيلاريات اللمفية، وداء كلابية الذنب، وداء البلهارسيات، والديدان الطفيلية المنقولة بالتربة في العام الذي تُستخدم فيه الأدوية المطلوبة

ويرد في الموقع الشبكي للمنظمة مزيد من التفاصيل عن العلاج الكيميائي الوقائي وحزمة الطلبات المشتركة، مع إمكانية تنزيل أحداث إصدارات النماذج بلغات متعددة (١).

٢,١,١ استكمال النماذج

تضطلع وزارة الصحة وموظفها المختص بمسؤولية استكمال النماذج، التي ينبغي أن توقعها بشكل رسمي سلطة معينة مختصة بطلب الأدوية في البلد وأن تُقدم النماذج إلى المكتب القطري للمنظمة في البلد المعني. وعادة ما يكون المنسقون الوطنيون المعنيون بالأمراض المدارية المهملة، بالتعاون مع السلطة المسؤولة عن إدارة مشتريات الأدوية، هم أنسب الأشخاص لتجميع جميع المعلومات المطلوبة لحزمة الطلبات المشتركة. وفي حالة عدم وجود هؤلاء الأشخاص، ينبغي لمديري البرامج المتعلقة بكل مرض من الأمراض المستهدفة أن ينسقوا الأجزاء الخاصة بهم في النماذج المشتركة، وذلك بمساعدة من مخازن الصيدليات أو المخازن الطبية الوطنية، إن وُجدت، لضمان إدراج المخزون الموجود في البلد. وتُتاح أيضاً بسهولة المساعدة التقنية من قِبَل الشركاء المنفذين الذين يدعمون البرامج الوطنية، ويُشجع هؤلاء الشركاء على تقديم المساعدة في إعداد حزمة الطلبات المشتركة.

٣,١,١ عملية الموافقة

عملية الفريق الإقليمي لاستعراض البرامج

لدى تقديم البيانات إلى المنظمة، تتحقق أمانة المنظمة من صحة البيانات وتستعرضها بالاشتراك مع المكاتب القطرية والمقر الرئيسي للمنظمة، وتقدم تعقيبات للبلدان بشأن ما ينبغي تصحيحه. وهذه الفترة هي من أكثر الفترات استهلاكاً للوقت في العملية بكاملها، ويرجع ذلك أساساً إلى أنها تنطوي على تلقي تعقيبات من البلدان. ولدى استكمال حزمة الطلبات المشتركة على النحو السليم، تقدم المنظمة الحزمة المستكملة إلى الفريق الإقليمي لاستعراض البرامج لمراجعتها والموافقة عليها. ويقدم هذا الفريق التقني والاستشاري استعراضاً استراتيجياً وتشغيلياً للبرامج الوطنية والإقليمية لمكافحة الأمراض المدارية المهملة بهدف تسريع مكافحة الأمراض المدارية المهملة المستهدفة والتخلص منها. وتتمثل إحدى ولايات الفريق في مراجعة طلبات الحصول على الأدوية المقدمة من البلدان إلى المنظمة، بما في ذلك أدوية العلاج الكيميائي الوقائي التالية: ألبيندازول، وسترات ثنائي ايثيل كاربامازين، وإيفرمكتين، وميبيندازول، وبرازيكوانتيل. ويجتمع الفريق مرة واحدة سنوياً لمراجعة الطلبات، ويجتمع افتراضياً بحسب الظروف. ويُنظر في توصيات الفريق في سياق عملية التبرع. وبالنسبة لطلبات الحصول على إيفرمكتين لعلاج داء كلابية الذنب والفيلاريات اللمفية عن طريق العلاج الثلاثي الأدوية، تُجرى عملية المراجعة والموافقة من خلال لجنة خبراء مكتيزان خارج إطار المنظمة.

٤,١,١ مزايا النماذج المشتركة للبرامج الوطنية

الطلبات المشتركة للحصول على الأدوية المختارة تساعد البلدان على تحديد عدد أقراص الأدوية ذات الصلة اللازمة للفئات السكانية والمناطق المستهدفة المخطط لها بطريقة منسقة ومتكاملة لعلاج الأمراض المتعددة في عام الطلب. وتكون مخرجات هذه الأداة ورقة عمل موجزة من صحفتين، يمكن طباعتها وتوقيعها ومسحها ضوئياً وتقديمها إلى المنظمة مرفقاً بها النسخة الكاملة من النموذج من أجل طلب الأدوية. ولتسريع عملية تقديم الطلبات، ينبغي أن تُقدم ورقة العمل إلى المنظمة بالإضافة إلى نسخ الكترونية من نموذج الإبلاغ المشترك ونموذج الإبلاغ الوبائي. ويبين الشكل ٢,١ عملية تقديم الطلبات.

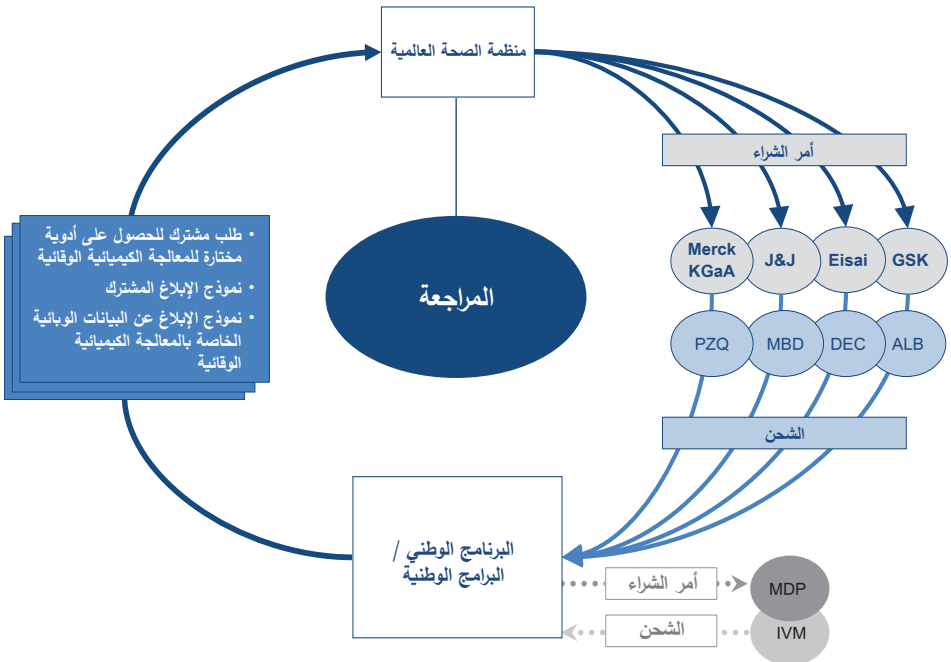
وسيجري الإبلاغ عن أي تغيرات تطرأ على هذه العملية، وستُحدَّث إجراءات التشغيل الموحدة بناءً على ذلك.

٢,١ الاعتبارات الرئيسية

تشمل متطلبات الطلب المشترك للحصول على أدوية مختارة للعلاج الكيميائي الوقائي ما يلي:

- تقديم التقرير المشترك المستكمل، مدرجاً به أحدث بيانات العلاج المتاحة لسنة تقويمية؛
- توافر رصيد من أدوية العلاج الكيميائي الوقائي في البلد؛
- توافر مصادر التمويل؛
- استكمال الطلب بمعلومات محدثة عن حالة توطن كل مرض استناداً إلى أحدث البيانات المتاحة المتعلقة بالانتشار التي قُدمت من خلال نموذج الأبلاغ الوبائي، إذا تم إجراء دراسات استقصائية.

الشكل ٢,١ عملية تقديم طلبات الحصول على أدوية العلاج الكيميائي المتبرع بها



ALB: ألبندازول؛ DEC: سترات ثنائي إيثيل كاربامازين؛ GSK: شركة GlaxoSmithKline؛ IVM: إيفرمكتين؛ J&J: شركة Johnson & Johnson؛ MBD: ميبيندازول؛ MDP: برنامج التبرع بدواء ©Mectizan؛ PC: المعالجة الكيميائية الوقائية؛ PZQ: دواء برازيكوانتيل.

تسمح البيانات التي جُمعت أثناء هذه العملية لبرنامج التبرع بتحديد الاحتياجات الطويلة الأجل من الأدوية في بلد معين وبتقييم التقدم المحرز نحو التخلص من المرض. ومن الممكن أن يؤدي التأخر في تقديم الطلبات السنوية، وعدم الالتزام بالجداول الزمنية، إلى التأثير على توافر الأدوية التي تلبي احتياجات البلد.

٣,١ إجراء التشغيل الموحد

الوظائف المحددة وأدوارها والخطوات التي يجب اتخاذها في هذا الإجراء هي أمثلة توضيحية وينبغي تعديلها بما يناسب السياق السائد في كل بلد.

١,٣,١ إعداد وتقديم حزمة الطلبات المشتركة (لكل من ألبيندازول، سترات ثنائي ايثيل كاربامازين، إيفرمكتين، ميبيندازول، براziكوانتيل)

متى	من	ماذا	كيف
ينبغي إعداد طلب الحصول على أدوية العلاج الكيميائي الوقائي، واستكماله وتقديمه للمراجعة قبل تسعة أشهر على الأقل من الموعد المخطط للمعالجة الجموعية نظراً لكمية الوثائق والبيانات المطلوبة لإعداد الطلب والوقت اللازم لتحديد وجمع البيانات، يُوصى بالبدء في إعداد الطلب قبل شهرين على الأقل من وقت التقديم، لضمان تقديمه إلى المنظمة وموافقتها عليه في الوقت المناسب.	▪ مدير البرنامج الوطني لمكافحة الأمراض المدارية المهملة / منسق البرنامج الوطني لمكافحة الأمراض المدارية المهملة ▪ الشركاء المنفذون ▪ مدير الرصد والتقييم ▪ مدير سلسلة الإمداد / الصيدلي أو مسؤول الخدمات اللوجستية المعني بالأمراض المدارية المهملة ▪ الصيدلي و / أو مسؤول الخدمات اللوجستية المعني بالأمراض المدارية المهملة	▪ تحديث خرائط الأمراض المدارية المهملة والمعلومات القطرية المتعلقة بها (مثلاً، السكان المحتاجون إلى العلاج الكيميائي الوقائي. يُحسب ذلك تلقائياً، ولكن ينبغي للبلدان تقديم بيانات سكانية عن البلد بأكمله بحسب الوحدة المنفذة)، وحالة توطن المرض، وعدد دورات العلاج المقررة والمنفذة، ومواعيد المعالجة الجموعية، وبيانات العلاج، ورصيد المخزون، وتوافر التمويل، وتقارير التقييم (مثلاً، الدراسة الاستقصائية لتقييم انتقال العدوى، ونموذج إبلاغ البيانات الوبائية) ▪ استكمال النماذج الأربعة ▪ المراجعة النهائية للنماذج المستكملة وتقديمها	١. استكمال النماذج الأربعة بمعلومات دقيقة وكاملة على النحو المبين في العمود الأيمن. ٢. التحقق من نتائج التقدير الكمي وتعديلها على أساس رصيد المخزون الحالي المتاح. ٣. التحقق من المصادر الأخرى لتمويل الإمداد في البلد.

المهمة	التعليمات	المسؤولية	المراجع
١.	**الالتقاء بأصحاب المصلحة لتحديد وجمع الوثائق والبيانات اللازمة** (قبل شهرين على الأقل من تقديمها) ١,١ مراجعة ملاحظات ما قبل الموافقة المقدمة في العام السابق لتحديد أسباب التأخر المستمر في الموافقة. ٢,١ وضع حلول لمنع تكرار التأخر. ٣,١ مناقشة وإسناد المسؤوليات عن جمع المكونات. ٤,١ تحديد موعد لاجتماع تحضيري يكون بمثابة موعد نهائي لجمع الوثائق المطلوبة.	▪ مدير برنامج مكافحة الأمراض المدارية المهملة ▪ الشركاء المنفذون ▪ مدير الرصد والتقييم ▪ مدير سلسلة الإمداد / الصيدلي أو مسؤول الخدمات اللوجستية المعني بالأمراض المدارية المهملة	*(١)* يُرجع إلى حزمة الطلبات المشتركة الخاصة بالعام السابق، وملاحظات المنظمة انظر الفصل ٨: الدورة العكسية للخدمات اللوجستية انظر الفصل ١١: التنبؤ والتقدير الكمي
٢.	**استكمال نموذج الإبلاغ المشترك عن العام السابق** (في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من الانتهاء من آخر دورة تنفيذ في عام الإبلاغ) **وينبغي تقديم البيانات الوبائية في نموذج الإبلاغ الوبائي كلما أجرى البلد استقصاءات وبائية واستُكملت نتائجها** ١,٢ عقد اجتماع مع أصحاب المصلحة لجمع جميع بيانات العلاج من الميدان. ٢,٢ استكمال نموذج الإبلاغ المشترك باستخدام البيانات الواردة من الميدان والمصادر الأخرى المتاحة. ٣,٢ مراجعة نموذج الإبلاغ المشترك وتقديمه للموافقة عليه.	▪ مدير برنامج مكافحة الأمراض المدارية المهملة ▪ الشركاء المنفذون ▪ مدير الرصد والتقييم	*(١)*
٣.	**استكمال الطلب المشترك للحصول على أدوية مختارة** (قبل تسعة أشهر على الأقل من الموعد المقرر للمعالجة الجموعية) ١,٣ عقد اجتماع مع أصحاب المصلحة لعرض جميع المعلومات القطرية المتعلقة بالأمراض المدارية المهملة اللازمة لاستكمال الطلب. ٢,٣ استكمال الطلب باستخدام المعلومات الدقيقة المتوافقة مع السياق المحلي للأمراض المدارية المهملة وحالتها. ٣,٣ مراجعة الطلب المستكمل وتقديمه إلى المكاتب القطرية والإقليمية للمنظمة لاستعراضه والموافقة عليه على الصعيد الإقليمي. وفي حالة طلب أدوية العلاج الثلاثي، ينبغي التحقق من المبادئ التوجيهية المتعلقة بالأهلية.	▪ مدير برنامج مكافحة الأمراض المدارية المهملة ▪ الشركاء المنفذون ▪ مدير الرصد والتقييم ▪ مدير سلسلة الإمداد / الصيدلي أو مسؤول الخدمات اللوجستية المعني بالأمراض المدارية المهملة	*انظر الفصل ٥: إدارة المخزون* *انظر الفصل ٦: التخزين* *انظر الفصل ٨: الدورة العكسية للخدمات اللوجستية* *(٢ ، ٣)* *انظر القسم ٢,١,٣: عملية تقديم الطلبات التكميلية لطلب الإيفرمكتين للعلاج الثلاثي*
٤.	**استكمال خطة العمل السنوية** (قبل تسعة أشهر على الأقل من الموعد المقرر للمعالجة الجموعية) ١,٤ قم بتنزيل خطة العمل السنوية من بوابة مشروع القضاء على الأمراض المدارية المهملة ESPEN أو الموقع الشبكي للمنظمة. ٢,٤ أكمل خطة العمل وشاركها لغرض المراجعة.	▪ مدير برنامج مكافحة الأمراض المدارية المهملة ▪ الشركاء المنفذون ▪ مدير الرصد والتقييم	*(١ ، ٤)*

٢,٣,١ عملية تقديم الطلبات التكميلية للحصول على إيفرمكتين لغرض العلاج الثلاثي

ينبغي للبلدان أن تستخدم نموذج الطلب المشترك الخاص بالحصول على أدوية مختارة لطلب إيفرمكتين *(١)*.

ينبغي أن يُقدم الطلب في غضون المهلة الزمنية الموصى بها من المنظمة إلى:

- إدارة الأمراض المدارية المهملة في المكتب الإقليمي للمنظمة، بالإضافة إلى الوثائق الداعمة؛
- برنامج مكتيزان للتبرع، بالإضافة إلى ما يلي:
  - الخطة الرئيسية المنقحة المدرج بها العلاج الثلاثي المعتمدة من وزارة الصحة كاستراتيجية للتخلص من الفيلاريات اللمفية؛
  - خطة العمل السنوية، متضمنة المناطق المستهدفة بالعلاج الثلاثي، واستراتيجية تنفيذ العلاج الثلاثي متضمنة التغطية الفعالة والرصد والتقييم التاليين للتدخلات؛
  - الأدلة الوبائية على الأهلية لتلقي العلاج الثلاثي لكل منطقة؛
  - الاتفاق الموقع مع برنامج مكتيزان للتبرع بشأن تلقي وتوزيع إيفرمكتين.

وتمتثل طلبات الحصول على إيفرمكتين لآلية المنظمة في استعراض حزمة الطلبات المشتركة على النحو المبين أعلاه. ومع ذلك فإن القرار النهائي بشأن عدد وحدات التنفيذ التي سيُوافق عليها تتخذه لجنة خبراء مكتيزان على أساس الأقراص البالغ عددها ٢٨٠ مليون قرص المخصصة سنوياً للعلاج الثلاثي حتى عام ٢٠٢٥. ويقدم أعضاء اللجنة توصيات للبرنامج. وبما أن التبرع الموسع لغرض العلاج الثلاثي هو حكم خاص يهدف إلى تيسير الحصول على إيفرمكتين وتسريع التخلص من الأمراض، فإن جميع الطلبات، سواء الطلبات الأولية أو المعاد تقديمها، تُناقش فيما بين أعضاء اللجنة الذين يقررون تقديم الأدوية من عدمه.

وتُولي أولوية للطلبات المعاد تقديمها للحصول على إيفرمكتين لإجراء دورة ثانية من العلاج الثلاثي. أما تنفيذ دورة ثالثة فهو رهن بما يلي:

- نجاح تنفيذ التبرعات السابقة مع تحقيق تغطية عالية؛
- وجود بيانات عن الرصد والتقييم تبرر الحاجة إلى تنفيذ دورات إضافية من المعالجة الجموعية بالأدوية الثلاثية.

وترد تفاصيل كاملة لعملية تقديم طلبات الحصول على إيفرمكتين لغرض العلاج بالأدوية الثلاثة في *دليل تبرعات مكتيزان لتسريع وتيرة القضاء على داء الفيلاريات اللمفية في البلدان التي لا يتوطنها داء كلابية الذنب إلى جانب الفيلاريات اللمفية (٤)*.

٤,١ عملية طلب أزيثروميسين

يجرى توفير أزيثروميسين لغرض القضاء على التراخوما بوصفها مشكلة صحية عمومية، وذلك بالتبرع به من شركة أدوية على غرار الأدوية الأخرى في سياق هذا الإجراء. وحددت شركة فايزر Pfizer، من خلال شريكتها المبادرة الدولية لمكافحة التراخوما، عملية سنوية مستقلة لتقديم الطلبات من قِبَل جميع البلدان للحصول على أزيثروميسين، مع متطلبات وجداول زمنية مستقلة.

وتقدم المبادرة الدولية لمكافحة التراخوما ITI معلومات عن جهود القضاء على التراخوما التي يبذلها البلد المقدم للطلب إلى لجنة خبراء التراخوما، وهي هيئة مستقلة من خبراء معترف بهم دولياً تجتمع مرتين في السنة لمراجعة طلبات البلدان وتحديد مخصصات الأدوية بطريقة متسقة وشفافة وقائمة على الأدلة. ويضطلع الموظف الطبي المعني بالتراخوما في منظمة الصحة العالمية بحكم منصبهم بدور المراقب في اجتماعات لجنة خبراء التراخوما.

ويلتمس الطلب المقدم للحصول على أزيثروميسين معلومات عن تفاصيل البرنامج، منها ما يلي:

- بيانات محدثة عن انتشار التراخوما على مستوى المقاطعة؛
- التقديرات السكانية الحالية بحسب المقاطعة؛
- بيانات توزيع العلاج من سنة البرنامج السابقة؛
- التزام البلد بالتنفيذ الكامل لاستراتيجية الجراحة والمضادات الحيوية وتنظيف الوجه وتحسين البيئة (SAFE) *(٥ ، ٦)*؛
- توافر التمويل المؤكد والشركاء في التنفيذ في كل مقاطعة مطلوب لها أزيثروميسين.

ويشكل الطلب جزءاً من نموذج رصد التخلص من التراخوما الذي أعده تحالف منظمة الصحة العالمية من أجل التخلص من التراخوما في العالم بحلول عام ٢٠٢٠، وهو النموذج الذي ييسر الإبلاغ المتزامن لكل من المنظمة والمبادرة الدولية لمكافحة التراخوما ITI عن أنشطة العام السابق (مثلاً، يتعلق نموذج عام ٢٠٢١ بأنشطة عام ٢٠٢٠). وفي المقاطعات التي لا يزال يوصى لها بأزيثروميسين، يتضمن النموذج علامة تبويب لطلب أزيثروميسين للعام التالي (مثلاً، يتعلق الطلب المقدم في عام ٢٠٢١ بأزيثروميسين المطلوب في عام ٢٠٢٢).

وترد *أمثلة للنماذج والعمليات في دليل التدبير العلاجي لزيثروماكس (٢)*

١,٤,١ الاعتبارات الرئيسية

- يجب على البلدان أن تقدم في كل عام، في إطار عملية تقديم الطلبات، طلباً لكل مقاطعة تخطط لتقديم العلاج فيها.
- يجب على كل مقاطعة يُطلب لها التبرع أن تستوفي معايير التبرع في أثناء كل دورة لتقديم الطلبات.
- ينبغي أن يعد مدير البرنامج الوطني الطلبات بالتعاون الوثيق مع فرقة العمل الوطنية المعنية بالتراخوما. وتعيّن المبادرة الدولية لمكافحة التراخوما لكل بلد موظف اتصال معنياً بالبرنامج الوطني وموظف اتصال معنياً بسلسلة الإمداد، يعملان بشكل وثيق مع البرنامج الوطني على ضمان تلبية احتياجات البلد.
- ويدافع موظف الاتصال المعني بالبرنامج، من خلال المعلومات التي يوفرها البرنامج الوطني، عن مصالح البلد في اجتماعات لجنة خبراء التراخوما.
- تقوم المبادرة الدولية لمكافحة التراخوما بالاستكمال المسبق لنموذج رصد التخلص من التراخوما (الذي يشمل طلب الحصول على زيثروماكس) بالأرقام المتوقعة لسكان المقاطعات، وتتولى المنظمة إرسال النموذج. وينبغي للبرنامج الوطني مراجعة النموذج وإدخال أي تصويبات عليه، مما يؤدي إلى تحديث علامة التبويب الخاصة بالطلبات. وتُدرج تعليمات في حزمة الطلبات لتيسير عملية تقديم طلبات الحصول على زيثروماكس.

٢,٤,١ عملية الموافقة

تقدم لجنة خبراء التراخوما توصيات على مستوى المقاطعات إلى المبادرة الدولية لمكافحة التراخوما بناءً على البيانات المقدمة عن كل مقاطعة، وهي:

- انتشار التراخوما؛
- السكان
- عدد دورات المعالجة الجموعية المنفذة بالفعل؛
- التغطية التي تحققت في كل دورة؛
- الجدول الزمني للدراسات الاستقصائية للانتشار بين السكان (خط الأساس، والتأثير، والترصد)؛
- توافر الدعم المالي والتنفيذي للمعالجة الجموعية.

واعتماداً على البيانات المقدمة عن كل مقاطعة، تطبق اللجنة قراراً من ثلاثة قرارات على كل طلب مقدم من كل مقاطعة للحصول على زيثروماكس (**الجدول ٣,١**). ولدى مراجعة اللجنة للطلب المتعلق بالعام التالي، تبلغ المبادرة الدولية لمكافحة التراخوما القرار لوزارة الصحة وشركائها.

٣,٤,١ مذكرة تفاهم

أُعدت مذكرة تفاهم لتحديد الالتزامات القانونية لوزارة الصحة والمبادرة الدولية لمكافحة التراخوما بشأن التبرع بأزيثروميسين وإداراته.

وتتضمن المذكرة ثلاثة عناصر، هي:

- الاتفاق الرئيسي الذي يفصّل الالتزامات القانونية التي تتقيد بها وزارة الصحة الوطنية والمبادرة الدولية لمكافحة التراخوما فيما يتعلق بالتبرع بأزيثروميسين وإدارته؛
- إضافة تفصّل القرارات المتعلقة بتخصيص أزيثروميسين للعام التالي؛
- إضافة تبين بالتفصيل ما ينبغي إبلاغه لشركة فايزر بشأن الشواغل المتعلقة بجودة منتج أزيثروميسين، والسيناريوهات التي تشوبها المخاطر، والأحداث السلبية، وكيفية الإبلاغ عن ذلك.

الجدول ٣,١ قرارات لجنة خبراء التراخوما بشأن زيثروماكس

١.	**الموافقة على تخصيص زيثروماكس للعام التالي**
٢.	**الموافقة على تخصيص زيثروماكس بشكل احتياطي:** ألف– إلى حين تأكيد التمويل المتاح، و / أو باء– إلى حين ورود نتائج من استقصاءات انتشار المرض بين السكان، و / أو جيم– إلى حين إيجاد حل لوضع خاص، إما: أ– يخرج عن سيطرة البرنامج الوطني ب– يتطلب تدخلاً من البرنامج الوطني
٣.	**لا يفي بالمعايير**

وتوقَّع مذكرة التفاهم من قِبَل المبادرة الدولية لمكافحة التراخوما ووزارة الصحة لمدة ثلاث سنوات. وفي السنوات اللاحقة، تُرسل إضافة ملحقة بمذكرة التفاهم الراهنة التي مدتها ثلاث سنوات إلى وزارة الصحة تبين بالتفصيل الحصة المخصصة من الدواء لذلك العام.

ولدى تخصيص العلاج اللازم لأي عام، تتخذ المبادرة الدولية لمكافحة التراخوما الخطوات اللازمة لضمان وصول الدواء إلى البلد قبل الوقت الموعد للمعالجة الجموعية.

وقد يؤدي عدم الامتثال للشروط الواردة في مذكرة التفاهم إلى وقف عملية التبرع بأزيثروميسين.

ويبين **الجدول** ٤,١ الجدول الزمني لتقديم طلبات الحصول على زيثروماكس بحسب الشهر والنشاط.

ورغم أن لجنة خبراء التراخوما تراجع الطلبات في وقت محدد مرتين في العام (في حزيران / يونيه وتشرين الثاني / نوفمبر)، تقبل المبادرة الدولية لمكافحة التراخوما ولجنة خبراء التراخوما، في ظروف معينة، الطلبات على مدار العام كلما توفرت بيانات جديدة أو تمويل جديد.

وترد في دليل إدارة زيثروماكس تفاصيل كاملة لنماذج وعملية تقديم الطلبات (٢).

الجدول ٤,١ الجدول الزمني لتقديم طلبات الحصول على زيثروماكس

الشهر	النشاط
كانون الثاني / يناير	ترسل منظمة الصحة العالمية طلب الحصول على زيثروماكس للعام التالي إلى البرنامج الوطني للتراخوما (أو إلى منسق التراخوما في البرنامج الوطني لمكافحة الأمراض المدارية المهملة في إطار برنامج متكامل)
آذار / مارس	يقدم البرنامج الوطني للتراخوما الطلب إلى المنظمة والمبادرة الدولية لمكافحة التراخوما
حزيران / يونيه إلى تشرين الثاني / نوفمبر	تتخذ لجنة خبراء التراخوما قراراً بشأن تخصيص زيثروماكس توجّه المبادرة الدولية لمكافحة التراخوما إخطاراً لوزارة الصحة بشأن قرارات اللجنة (انظر **الجدول** ٣,١)، وإما أن توقع مذكرة تفاهم جديدة أو تحدّث المذكرة الراهنة التي مدتها ثلاث سنوات بإلحاق إضافة بها
من شهر إلى شهرين قبل المعالجة الجموعية	تشحن المبادرة الدولية لمكافحة التراخوما زيثروماكس إلى البلدان (يتوقف توقيت الشحن على الجدول الزمني للمعالجة الجموعية في البلد)
آذار / مارس (العام التالي)	تُقدم التقارير القطرية إلى منظمة الصحة العالمية والمبادرة الدولية لمكافحة التراخوما عن أدوية العلاج الموزعة في العام السابق، وذلك في نموذج رصد التخلص من التراخوما الذي يتضمن طلب الحصول على زيثروماكس
قبل الشحن	تقدم البلدان تقارير إلى المبادرة الدولية لمكافحة التراخوما عن المخزون المتبقي من العام السابق

٥,١ إجراء التشغيل الموحد

الوظائف المحددة وأدوارها والخطوات التي يجب اتخاذها في هذا الإجراء هي أمثلة توضيحية وينبغي تعديلها بما يناسب السياق السائد في كل بلد.

١,٥,١ إعداد وتقديم نموذج رصد التخلص من التراخوما

متى	من	ماذا	كيف
يُتلقى الطلب في كانون الثاني / يناير ويُقدم في آذار / مارس للعام القادم (أي أن طلب المعالجة الجموعية في عام ٢٠٢٢ يُقدم في آذار / مارس ٢٠٢١)، ويُقدم تقرير عن تنفيذ استراتيجية الجراحة والمضادات الحيوية وتنظيف الوجه وتحسين البيئة في العام السابق	▪ مدير البرنامج الوطني للتراخوما ▪ منسق التراخوما في برنامج مكافحة الأمراض المدارية المهملة ▪ الشركاء المنفذون ▪ موظف الاتصال في المبادرة الدولية لمكافحة التراخوما	▪ تحديث بيانات انتشار التراخوما ▪ تقديم التقديرات الحالية للسكان بحسب المقاطعات ▪ تقديم بيانات توزيع العلاج من العام السابق للبرنامج ▪ التحقق من التزام البلد بالتنفيذ الكامل لاستراتيجية الجراحة والمضادات الحيوية وتنظيف الوجه وتحسين البيئة ▪ تأكيد توافر التمويل والشركاء في التنفيذ في كل مقاطعة تتلقى أزيثروميسين	١. كانون الثاني / يناير: تلقي طلبات الحصول على زيثروماكس من المنظمة. ٢. آذار / مارس: يقدم البرنامج الوطني للتراخوما الطلب إلى المنظمة والمبادرة الدولية لمكافحة التراخوما. ٣. حزيران / يونيه إلى تشرين الثاني / نوفمبر: تلقي قرارات تخصيص أزيثروميسين من لجنة خبراء التراخوما، وإما توقيع مذكرة تفاهم جديدة أو تحديث المذكرة الراهنة التي مدتها ثلاث سنوات بإلحاق إضافة بها.

المهمة	التعليمات	المسؤولية	المراجع
١.	**يناير (كانون الثاني): تلقي طلبات زيثروماكس** ١,١ ترسل المنظمة طلب زيثروماكس المستكمل مسبقاً إلى مدير البرنامج الوطني للتراخوما (أو منسق التراخوما في البرنامج الوطني لمكافحة الأمراض المدارية المهملة في إطار برنامج متكامل) للعام المقبل.	▪ موظف الاتصال في برنامج المبادرة الدولية لمكافحة التراخوما، والمنظمة	*(٧)*
٢.	**آذار / مارس: يقدم مدير البرنامج الوطني للتراخوما / منسق التراخوما في برنامج الأمراض المدارية المهملة طلب الحصول على زيثروماكس** ١,٢ يحدّث مدير البرنامج الوطني للتراخوما / مدير برنامج الأمراض المدارية المهملة البيانات المتعلقة بانتشار التراخوما. – تحديث الخطوات بمشاركة الموظفين أو الإدارة المسؤولين عن استكمال العملية. ٢,٢ يحصل مدير البرنامج الوطني للتراخوما / منسق التراخوما في برنامج الأمراض المدارية المهملة على التقديرات السكانية الحالية بحسب المناطق. – تحديث الخطوات بمشاركة الموظفين أو الإدارة المسؤولين عن استكمال العملية. ٣,٢ يقدم مدير البرنامج الوطني للتراخوما / منسق التراخوما في برنامج الأمراض المدارية المهملة نموذج رصد التخلص من التراخوما المدرج به بيانات توزيع العلاج في العام السابق. – تحديث الخطوات بمشاركة الموظفين أو الإدارة المسؤولين عن استكمال العملية. ٤,٢ التحقق من التزام البلد بالتنفيذ الكامل لاستراتيجية الجراحة والمضادات الحيوية وتنظيف الوجه وتحسين البيئة. – تحديث الخطوات بمشاركة الموظفين أو الإدارة المسؤولين عن استكمال العملية. ٥,٢ تأكيد توافر التمويل والشركاء في التنفيذ في كل مقاطعة تتلقى أزيثروميسين. – تحديث الخطوات بمشاركة الموظفين أو الإدارة المسؤولين عن استكمال العملية.	▪ مدير البرنامج الوطني للتراخوما / منسق التراخوما في برنامج الأمراض المدارية المهملة ▪ الشركاء المنفذون ▪ موظف الاتصال في برنامج المبادرة الدولية لمكافحة التراخوما	

المهمة	التعليمات	المسؤولية	المراجع
٣.	**حزيران / يونيه إلى تشرين الثاني / نوفمبر: تلقي قرارات تخصيص أزيثروميسين من لجنة خبراء تراخوما** ١,٣ يتلقى مدير البرنامج الوطني للتراخوما / منسق التراخوما في برنامج الأمراض المدارية المهملة الموافقة على تخصيص أزيثروماكس. ٢,٣ يوقّع مدير البرنامج الوطني للتراخوما / منسق التراخوما في برنامج الأمراض المدارية المهملة مذكرة التفاهم التي مدتها ثلاث سنوات مع المبادرة الدولية لمكافحة التراخوما، أو يوقع على إضافة تُلحق بالمذكرة القائمة تبين بالتفصيل مخصصات الدواء للعام القادم. – تُحدث الخطوات بمشاركة الموظفين أو الإدارة المسؤولين عن استكمال العملية.	▪ مدير البرنامج الوطني للتراخوما / منسق التراخوما في برنامج الأمراض المدارية المهملة ▪ الشركاء المنفذون	

المراجع

١. حزمة الطلبات المشتركة – التخطيط وطلب الأدوية والإبلاغ. في صفحة الأمراض المدارية المهملة للموقع الشبكي للمنظمة. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ ٢٠٢١ (https://www.who.int/teams/control-of-neglected-tropical-diseases/interventions/strategies/preventive-chemotherapy/joint-application-package/version4 ، تم الاطلاع عليه في ١٨ آذار / مارس ٢٠٢٢). [بالإنكليزية فقط].

٢. دليل إدارة زيثروماكس. ديكاتور (جورجيا): المبادرة الدولية لمكافحة التراخوما؛ ٢٠١٩ (https://www.trachoma.org/zithromax-management-guide ، تم الاطلاع عليه في ١٨ آذار / مارس ٢٠٢٢).

٣. الموقع الالكترونى لطلب مكتيزان. In: Mectizan® Donation Program/How the program works [website]. Decatur (GA): Mectizan Donation Program: 2021 (https://mectizan.org/how/application-process/#, accessed 18 March 2022).

٤. دليل التبرعات بمكتيزان لتسريع عملية القضاء على داء الفيلاريات اللمفاوية في البلدان التي لا يتوطن فيها داء كلابية الذنب [version 1]. Decatur (GA): Mectizan® Donation Program; 2017 (https://mectizan.org/wp-content/uploads/2018/07/Guide-Mectizan-Application-for-IDA-countries_V1.pdf, accessed 18 March 2022).

٥. تقرير الاجتماع الثالث لتحالف منظمة الصحة العالمية من أجل التخلص من التراخوما في العالم، ورزازات، المغرب، ١٩ – ٢٠ تشرين الأول / أكتوبر ١٩٩٨. جنيف، منظمة الصحة العالمية، ١٩٩٩ (متاح في الموقع https://iris.who.int/handle/10665/65933 ، تم الاطلاع عليه في ١٨ آذار / مارس ٢٠٢٢). [بالإنكليزية فقط].

٦. Francis V و Turner V ، برنامج منظمة الصحة العالمية للوقاية من العمى. تحقيق دعم المجتمع لمكافحة التراخوما: دليل للعمل الصحي في المناطق. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ ١٩٩٥ (https://iris.who.int/handle/10665/59567، تم الاطلاع عليه في ١٨ آذار / مارس ٢٠٢٢) [بالإنكليزية فقط].

٧. المشروع الخاص الموسع للقضاء على الأمراض المدارية المهملة. صفحة المشروع في الموقع الشبكي لمنظمة الصحة العالمية (البوابة الشبكية). برازفيل: المكتب الإقليمي للمنظمة لأفريقيا؛ ٢٠٢١ (https://espen.afro.who.int/، تم الاطلاع عليه في ١٨ آذار / مارس ٢٠٢٢). [بالإنكليزية فقط].

٢. إخطار الشحن والضوء الأخضر

١,٢ الغرض من إجراء التشغيل الموحد هذا ونطاقه

يعد إخطار الشحن وإجراء الضوء الأخضر، إلى جانب قائمة جهات الاتصال الرئيسية، الخطوة الأولى في البلد المتلقي للأدوية المتبرع بها وجانباً بالغ الأهمية في إدارة سلسلة الإمداد.

ويبين هذا الإجراء عملية الإخطار من جانب المتبرع بشحن الأدوية إلى البلد، بداية من مصنع الانتاج أو المستودع التابع للمتبرع إلى نقطة دخول البلد أو إلى المخزن / المستودع الطبي المركزي. ويحدد هذا الإجراء قائمة الاتصال المطلوبة لجميع وثائق الشحن و «موافقة الضوء الأخضر» لشحن الأدوية، وهي موافقة لا يشترطها إلا عدد قليل من البلدان. والبلد الذي يشترط الضوء الأخضر هو البلد الذي يطلب تصريح استيراد أو تفتيش الحاويات أو مهلة إضافية للتحضير للشحن. ويمكن الاطلاع على مثال لمخطط مسار العملية في **الشكل** ١,٢.

٢,٢ الاعتبارات الرئيسية

تؤدي عملية التحضير قبل وصول شحنة الأدوية إلى تقليص وقت تسليمها في المخزن / المستودع الطبي المركزي. ويُيسّر توافر الوثيقة أو الوثائق المجازة في البلد عند وصول الشحنة عملية التخليص الجمركي؛ ويُعد أيضاً توافر المساحة والموظفين لتفريغ الشحنة أمراً ضرورياً لاستلام الأدوية في الوقت المحدد في المخزن / المستودع الطبي المركزي. انظر الفصل ٣ لمزيد من المعلومات.

وينبغي اتباع هذا الإجراء من أجل:

- تبسيط الجدول الزمني للنقل، بتسليم الأدوية في نقطة دخول البلد أو في المخزن / المستودع الطبي المركزي لضمان توزيع أدوية المعالجة الجموعية في الوقت المناسب؛
- منع التكدس في المخزن / المستودع الطبي المركزي؛
- منع التأخر الناجم عن عدم توافر العدد الكافي من الموظفين لتفريغ الأدوية التي تصل إلى المخزن / المستودع الطبي المركزي؛
- خفض التكلفة الناجمة عن التأخر التي تتكبدها الجهة المانحة والبلد (انظر الفهرس (**الملحق** ١) للاطلاع على تعريف المصطلحات):
  - الشحن البحري – غرامات تأخير خط الشحن / رسوم التخزين في الميناء وغرامات التأخير / رسوم شركة الشحن البحري / رسوم الناقل الداخلي للحاويات الفارغة (استخدام الشحن البحري مقابل الشحن عبر المحيطات).
  - الشحن الجوي – رسوم التخزين في المطار / الناقل الداخلي للحاويات الفارغة
  - *(مثال للتكاليف التي تتكبدها الجهة المانحة بسبب تأخر كل من الشحن عبر المحيط والشحن الجوي (رسوم التخزين قبل المغادرة).*

الوظائف المحددة وأدوارها والخطوات التي يجب اتخاذها في هذا الإجراء هي أمثلة توضيحية وينبغي تعديلها بما يناسب السياق السائد في كل بلد.

التخطيط. تشمل عملية الضوء الأخضر الناجحة لشحن الأدوية المتبرع بها إلى البلدان المتلقية العوامل الآتية.

خطة التوزيع

- تحدد أية خطة توزيع الوقت الذي تبدأ فيه الجهة المانحة عملية الشحن، وفقاً للشهر المقرر للمعالجة الجموعية. ويجب على منسق البرنامج الوطني أو منظمة الصحة العالمية الإبلاغ عن الموعد المتوقع لتسليم الأدوية في البلد، مع الأخذ في الحسبان الوقت الذي تستغرقه عملية التخليص على الأدوية ونقلها إلى المجتمعات المحلية.

الميزانية

- التمويل اللازم للتخليص الجمركي على الشحنات وتأمين تأجير الشاحنات لنقلها إلى المخزن الطبي المركزي، وأية رسوم ترتبط بالشحن، ما لم تكن متاحة بالفعل، وذلك من خلال أنظمة الإمدادات الطبية القائمة التابعة للمنظمة أو للحكومات.
  - مثال: يجب تخصيص تمويل لتخليص ونقل وتخزين أزيثروميسين المتبرع به، وهو التمويل الذي لا يندرج تحت آلية سلسلة الإمداد التابعة للمنظمة.

السلطة المسؤولة

- حدّد الجهة التي تتخذ القرارات المتعلقة بتصاريح استيراد الأدوية أو الاعفاء من الجمارك، وبخاصة عندما تصل الأدوية إلى البلد في أوقات مختلفة. تحقق من أن للسلطة المشار إليها صلاحية تحديد الأولويات.
- حدد السلطة التي لها صلاحية التوقيع في وزارة المالية، وزارة الصحة، وهيئة الأدوية، ومكتب الجمارك، وغيرها.

الأمن

- لبعض الأدوية قيمة عالية في تلبية احتياجات أخرى (الثروة الحيوانية، ومجالات مستهدفة أخرى)؛ ومن الأهمية البالغة ضمان التخزين الآمن لهذه الأدوية في مخازن الجمارك وأثناء النقل والتخزين في المخزن / المستودع الطبي المركزي دون التعرض للتلف أو السرقة، وذلك لتنفيذ حملات المعالجة الجموعية بتغطية جيدة وتحقيق أهداف التخلص من الأمراض ومكافحتها. ويجب ضمان سلامة الأدوية على جميع المستويات، بداية من استلامها في البلد إلى توزيعها في المجتمع.

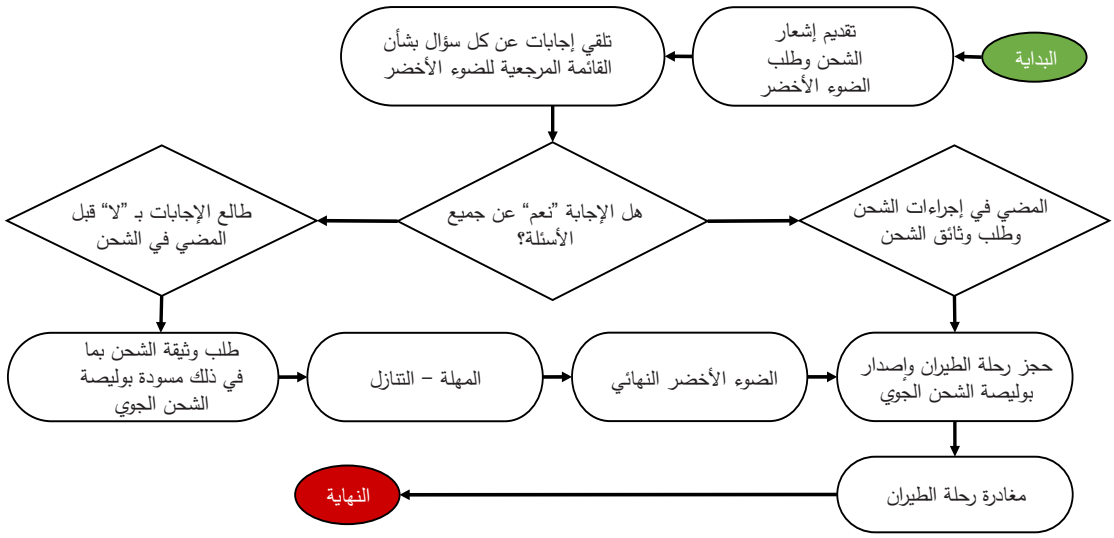
الوثائق

- التعرف مسبقاً على جميع الإجراءات الإدارية لاستلام وتخليص الأدوية المتبرع بها.
- إبلاغ المتبرع مسبقاً بمتطلبات البلد والوثائق المطلوبة.
- التأكد من وجود أنظمة لمراقبة عملية الشحن في كل خطوة – وينبغي أن تصاحب الشحنة وثائق مستكملة وتم التحقق من صحتها.

الأوضاع البيئية

- نقل الأدوية من مستودع الجمارك إلى المخزن الطبي المركزي في طقس لا يمكن التنبؤ به (مثلاً، الموسم الدافئ أو الجاف مقابل الموسم الرطب). ومن الضروري التأكد من أن آليات النقل المستخدمة كافية لمنع تلف أو تدهور المخزون، والتأكد من وصول المخزون في حالة تعتبر سليمة وغير تالفة.

الشكل ١,٢ مثال لمخطط مسار إخطار الشحن الجوي وإجراء الضوء الأخضر



المصدر: المبادرة الدولية لمكافحة التراخوما

٣,٢ إجراء التشغيل الموحد

١,٣,٢ إخطار الشحن

متى	من	ماذا	كيف
▪ لدى استلام الطلب؛ وقد يشمل شحنات متعددة في نفس العام. ▪ يأخذ في الحسبان المواعيد المقررة للمعالجة الجموعية، والمهلة المحددة، والعبور، والتخليص الجمركي، والنقل داخل البلد، ووقت إرسال الأدوية إلى المستلم الأخير.	▪ البرنامج الوطني للأمراض المدارية المهملة، والمانح، والمنظمة، ومنسق البرنامج الوطني، ومدير سلسلة الإمداد في المخزن / المستودع الطبي المركزي ▪ ترسل الجهات المانحة إخطار الشحن إلى البلدان، بما في ذلك برنامج الأمراض المدارية المهملة التابع لوزارة الصحة، والجهة المانحة، والمنظمة، ومنسق البرنامج الوطني، ومدير سلسلة الإمداد في المخزن / المستودع الطبي المركزي.	▪ الإخطار بنقل الشحنة، والخطوات المتخذة لتبسيط استلامها. ▪ السماح للبلدان بالتحضير لاستلام الأدوية داخل البلد. ▪ تبدأ الجهة المانحة العملية بارسال بريد الكتروني إلى المرسل إليه الشحنة يفيد بأن الشحنة معبأة. ▪ يجب على المرسل إليه تأكيد إمكانية المضي قدماً في إجراءات الحجز لنقل الشحنة.	١. ترسل الجهة المانحة إخطار الشحن إلى المنظمة / منسق البرنامج الوطني، والمرسل إليه. ٢. تؤكد المنظمة / منسق البرنامج الوطني قائمة الاتصال. ٣. تصدر المنظمة / منسق البرنامج الوطني الضوء الأخضر للمضي في إجراءات الحجز.

المهمة	التعليمات	المسؤولية	المراجع
١.	**إرسال إخطار الشحن إلى البلدان** ١,١ إرسال إخطار الشحن في الإطار الزمني المحدد في برنامج وزارة الصحة لمكافحة الأمراض المدارية المهملة.	▪ يرسل المانحون إخطاراً بالبريد الإلكتروني إلى البلدان المتلقية، ووزارة الصحة، والمنظمة / منسق البرنامج الوطني لإفادتهم عن الشحنة القادمة من الأدوية.	▪ الرجوع إلى قائمة الاتصال القطرية (وزارة الصحة، منسق البرنامج الوطني / المنظمة). الرجوع إلى الطلب المقدم من البلدان للحصول على الأدوية المتبرع بها لعلاج: – الفيلاريات اللمفية، داء البلهارسيات، الديدان الطفيلية المنقولة بالتربة، داء كلابية الذنب (١)؛ – التراخوما (٢).
٢.	**التحضير لمغادرة الشحنة من مواقع الإنتاج / مركز الخدمات اللوجستية** ١,٢ تجهيز الشحنة. ٢,٢ تخطيط وتنفيذ الحجز.	▪ يوجه المانح رسالة بالبريد الإلكتروني إلى منسق البرنامج الوطني / المنظمة يفيدهم فيها بالشحنة الوشيكة المذكورة في إخطار الشحن المرسل بالبريد الإلكتروني مع معلومات مفصلة عن الكميات	الرجوع إلى نوع الإخطار، الذي قد يتضمن: ▪ الوثائق التنبيهية / النهائية – إتاحة وثائق الشحن المحدودة، وإتمام إجراءات الحجز لإرسال الشحنة أو يجري اتخاذ اجراءات الحجز. ▪ إخطار الشحن – إتاحة وثائق الشحن المحدودة، ويجرى الحجز لإرسال الشحنة. ▪ إشعار الشحن – إتاحة جميع وثائق الشحن، وإتمام الحجز لإرسال الشحنة. ▪ أخرى – الرجوع إلى وثائق الشحن المقدمة من الجهة المانحة، التي قد تتضمن: ١. الفواتير ٢. بوليصة الشحن أو بوليصة الشحن الجوي (إن وُجدت) ٣. بوليصة الشحن (تُتاح بعد إبحار السفينة من ميناء المنشأ). ٤. قائمة التعبئة ٥. شهادة المنشأ ٦. شهادة التحليل ٧. شهادة الإعفاء من الرسوم الجمركية (منظمة الصحة العالمية) ٨. شهادة التبرع
٣.	**التحضير لوصول الشحنة**	▪ المنظمة / منسق البرنامج الوطني ▪ مدير سلسلة الإمداد في المخزن / المستودع الطبي المركزي	▪ المنظمة / منسق البرنامج الوطني للتحقق مع المانح من أن الجداول الزمنية مناسبة لكل من الشحن البحري والجوي. ▪ المنظمة / منسق البرنامج الوطني للتأكد من أن الأعمال الورقية جاهزة لاستلام الشحنة وتخليصها من الجمارك. ▪ مدير سلسلة الإمداد للتأكد من أن المخزن الطبي المركزي قد خطط لوصول الشحنة ووفر جميع الموارد: الشاحنات، وعمال تفريغ الشاحنات، ومساحة التخزين.

المهمة	التعليمات	المسؤولية	المراجع
٤.	**طلب الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية** يمكن للمنظمة / منسق البرنامج الوطني الذين يطلبون وثائق غير ضرورية إضافية أن يؤخروا استلام الشحنة. وقد يتطلب إعداد الوثائق التي تخرج عن نطاق حزمة وثائق الشحن القياسية ثلاثة أشهر. ومن الممكن أن يساعد تزويد الجهة المانحة مسبقاً بمعلومات عن المتطلبات الخاصة بكل بلد وجدولها الزمني هذه الجهات المانحة على تحسين تنسيق وصول الشحنة بعد استلام وثائق التخليص داخل البلد. ويشكل منع تأخر الشحنة في مرحلة التخليص أمراً حيوياً للتسليم في الوقت المقرر. ١,٤ تطلب المنظمة / منسق البرنامج الوطني إصدار إعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية من وزارة المالية أو الهيئة الحكومية المختصة الأخرى. ٢,٤ [ينبغي أن يدرج هذا القسم بوضوح أدناه متطلبات البلد من الوثائق لأغراض التخليص على الأدوية في الجمارك، وعملية الحصول على هذه الوثائق]. وقد تشمل الأمثلة ما يلي: – موافقة من وزارة المالية. – نسخ من وثائق الشحن الأصلية المقدمة من الجهة المانحة مختومة من وزارة الصحة: – الفواتير – قائمة التعبئة – شهادة المنشأ – شهادة التبرع – شهادة التحليل	▪ المنظمة / منسق البرنامج الوطني. ▪ **[يحدد البلد الشروط المسبقة للحصول على جميع الوثائق الإدارية لتخليص الشحنة.]** ▪ تحدد وزارة الصحة / منسق البرنامج الوطني / المنظمة الجدول الزمني للحصول على كل وثيقة وعلى الموارد اللازم تخصيصها.	
٥.	**إخطار مدير سلسلة الإمداد** يُدرج في الإخطار ما يلي: ▪ عدد العلاجات؛ ▪ أبعاد الشحنة (الحجم، وعدد الواح التحميل والصناديق)؛ ▪ التاريخ المتوقع للشحن في الميناء؛ ▪ التاريخ والموعد المتوقعان للتسليم في المخزن الطبي المركزي.	▪ موظف الخدمات اللوجستية المعني بالأمراض المدارية المهملة ▪ المنظمة / منسق البرنامج الوطني ▪ يمكن لخبراء سلسلة الإمداد في المخزن الطبي المركزي أداء دور حيوي في تحديد الاختناقات داخل سلسلة الإمداد بالأدوية المتبرع بها. وتشكل الاستفادة من معارف الخبراء أمراً أساسياً عند تحديث إجراء التشغيل الموحد هذا.	
٦.	**تجهيز المستودع / المخزن الطبي المركزي** ١,٦ التحقق من سعة المخزن. ٢,٦ تنسيق الموظفين لاستلام الشحنة.	▪ يجهز مدير سلسلة الإمداد المستودع / المخزن الطبي المركزي لاستلام الأدوية. ▪ تكون خطوات التحقق من المساحة متاحة لدى وصول الشحنة. ▪ خطوات تنسيق الموظفين لتفريغ الشحنة. والعاملون الذين يتقاضون أجراً أو الموظفون الحاليون، والمعدات المستأجرة للتفريغ، وغير ذلك.	▪ انظر الفصل ٥: إدارة المخزون ▪ انظر الفصل ٦: التخزين ▪ قد تُحصل رسوم كبيرة من الناقل الداخلي في حالة عدم توفر مساحة للأدوية لدى وصولها. ▪ يُتاح التتبع لأدوية مختارة: – موجز قطري على الانترنت *(٣)* – نموذج الاشتراك في صفحة البلد *(٤)* – تتبع زيثروماكس في البلد *(٥)*.

٢,٣,٢ قائمة جهات الاتصال

متى	من	ماذا	كيف
لدى استلام الطلب؛ وقد يشمل شحنات متعددة في نفس العام. تقدم وزارة الصحة / منسق البرنامج الوطني / المنظمة إلى الجهة المانحة قائمة جهات الاتصال قبل تعبئة الشحنة.	▪ برنامج الأمراض المدارية المهملة في وزارة الصحة ▪ الجهة المانحة ▪ المنظمة، ومنسق البرنامج الوطني ▪ مدير سلسلة الإمداد في المخزن / المستودع الطبي المركزي	قائمة جهات الاتصال هي الخطوة الأولى في ترتيب الأمور مع خدمة الشحن الخاصة بالمانح والحصول على الفاتورة المبدئية. ▪ تزود الجهة المانحة برنامج الأمراض المدارية المهملة التابع لوزارة الصحة، والمنظمة، ومنسق البرنامج الوطني بقائمة مبدئية لجهات الاتصال استناداً إلى قائمة الشحنة السابقة التي يُرجى منهم إدخال تغييرات أو إضافات عليها، إذا لزم الأمر. ▪ تتيح هذه العملية للبلد المتلقي للشحنة تقديم قائمة بالأشخاص الواجب إبلاغهم عن تطور الشحنة أو مسارها. ▪ تقدم المنظمة / منسق البرنامج الوطني قائمة جهات الاتصال المحدثة لغرض شحن الأدوية.	تطلب الجهة المانحة، قبل كل شحنة، معلومات محدثة عن جهات الاتصال. ▪ ترسل الجهة المانحة القائمة المبدئية لجهات الاتصال إلى البلد المتلقي لتحديث القائمة. ▪ يستخدم منسقو البرامج الوطنية مسودة قائمة جهات الاتصال المبدئية لتحديث قائمة الأشخاص الواجب إبلاغهم عن الشحنة القادمة. ▪ المراسلات الواضحة بشأن تاريخ تلقي الملاحظات أمر أساسي لتجنب الحاجة إلى توجيه طلبات متكررة بالبريد الإلكتروني لتحديث القائمة. انظر الفصل ٣: التخليص الجمركي والتسليم

المهمة	التعليمات	المسؤولية	المراجع
١.	**ترسل الجهة المانحة قائمة الاتصال المبدئية الأولى لتحديثها** ١,١ تطلب الجهة المانحة، في البريد الالكتروني الأولي الذي تعلن فيه عن الشحنة، إلى المنظمة / منسق البرنامج الوطني تحديث قائمة جهات الاتصال	▪ تحدّث المنظمة / منسق البرنامج الوطني قائمة جهات الاتصال وتعيد الملف المحدَّث إلى الجهة المانحة لإعداد الطلب. ▪ تتيح هذه العملية للبلد المتلقي تقديم قائمة بالأشخاص الواجب إبلاغهم عن تطور الشحنة أو مسارها.	▪ تُصاغ قائمة جهات الاتصال المبدئية استناداً إلى قائمة الاتصال الخاصة بالشحنات السابقة (انظر النموذج في **الملحق ٢**).
٢.	**تتلقى المنظمة / منسق البرنامج الوطني قائمة جهات الاتصال ويقومان بتحديثها**	▪ تضمن المنظمة / منسق البرنامج الوطني إدراج وتحديث قائمة اتصال جميع أصحاب المصلحة. ▪ تتلقى المنظمة / منسق البرنامج الوطني قائمة جهات الاتصال الخاصة بالشحنة الوشيكة، ويتخذان الإجراءات المناسبة لتقديم الموافقة.	▪ تستخدم المنظمة / منسق البرنامج الوطني قائمة جهات الاتصال الواردة من الجهة المانحة لتحديثها.
٣.	**تلبي المنظمة / منسق البرنامج الوطني الطلب المتعلق بقائمة جهات الاتصال** ١,٣ تعيد المنظمة / منسق البرنامج الوطني، بالبريد الالكتروني، قائمة الاتصال المحدثة إلى الجهة المانحة.	▪ تتأكد المنظمة / منسق البرنامج الوطني من دقة معلومات الاتصال قبل تقديمها للجهة المانحة. ▪ تلبي المنظمة / منسق البرنامج الوطني الطلب المتعلق بقائمة جهات الاتصال في غضون أسبوعين من تلقي الطلب. ▪ إذا لم يتسن للمنظمة / منسق البرنامج الوطني، لسبب ما، إعادة قائمة الاتصال المحدثة، يجب عليهما بيان أسباب التأخر وتقديم موعد متوقع للموافقة.	▪ تتصل المنظمة / منسق البرنامج الوطني بجميع أصحاب المصلحة لتحديث بيانات الاتصال التي ينبغي إبلاغها قبل الشحن. ▪ قد تشمل قائمة الاتصال ما يلي: ١. المتبرع له المسجل ٢. المرسل إليه (المنظمة أو الشخص المرسل إليه أو الذي سيُسلم المنتج رسمياً. ٣. مرسل إلى / تُسلم إلى ٤. منسق البرنامج الوطني ٥. المستورد المسجل ٦. المسار / الإخطار ٧. نقطة الاتصال في عنوان "التسليم" (العنوان المادي الذي ستسلم فيه الشحنة) ٨. الشخص المسؤول عن التخليص الجمركي ٩. أي شخص آخر ينبغي إخطاره بالشحنة القادمة.

٣,٣,٢ الضوء الأخضر

متى	من	ماذا	متى
لدى استلام الطلب؛ وقد يشمل شحنات متعددة في نفس العام. ويمكن للجهة المانحة أن ترسل قائمة الضوء الأخضر المرجعية إلى المرسل إليه / المنظمة / منسق البرنامج الوطني قبل البدء في عملية الطلب وقبل الحجز لإرسال الشحنة. قد تشترط الجهة المانحة طلب الضوء الأخضر في نفس وقت إرسال إخطار الشحن وطلب قائمة الاتصال. يقدم منسق البرنامج الوطني / المنظمة الضوء الأخضر قبل أن تمضي الجهة المانحة في عملية الحجز لإرسال الشحنة.	▪ برنامج وزارة الصحة للأمراض المدارية المهملة، والجهة المانحة، والمنظمة، ومنسق البرنامج الوطني، ومدير سلسلة الإمداد في المخزن / المستودع الطبي المركزي. ▪ تطلب الجهة المانحة الضوء الأخضر من المرسل إليه الشحنة، أو برنامج وزارة الصحة لمكافحة الأمراض المدارية المهملة، أو المنظمة / منسق البرنامج الوطني.	▪ يقدم المرسل إليه الشحنة، والمنظمة / منسق البرنامج الوطني الموافقة على شحن الأدوية إلى الجهة المانحة، وتُسمى هذه الموافقة "الضوء الأخضر".	▪ تتيح هذه العملية للبلد المتلقي للشحنة تقديم الوثائق المطلوبة أو إجراء التفتيش أو اتخاذ إجراءات أخرى لاستلام الأدوية في البلد.

المهمة	التعليمات	المسؤولية	المراجع
٤.	**تقييم متطلبات الضوء الأخضر** ١,٤ تجري برامج تقديم طلبات الحصول على أدوية الأمراض المدارية المهملة تقييماً لمتطلبات الضوء الأخضر استناداً إلى المبادئ التوجيهية للبرامج. ٢,٤ ينبغي لمنسقي البرامج الوطنية إرسال بريد الكتروني إلى مدير برنامج مكتيزان للتبرع (ysodahl–on@taskforce.org) لطلب معلومات إضافية عن متطلبات الضوء الأخضر في بلدهم.	▪ برامج تقديم طلبات الحصول على أدوية الأمراض المدارية المهملة، والمنظمة / منسق البرنامج الوطني.	▪ بالنسبة للفيلاريات اللمفية، وداء البلهارسيات، والديدان الطفيلية المنقولة بالتربة، يرجى الاتصال بالمنظمة: PC_JointForms@who.int ▪ بالنسبة لداء كلابية الذنب، يرجى الاتصال ببرنامج مكتيزان للتبرع (حالياً الدكتور Yao Sodahlon: ysodahlon@taskforce.org) أو mectizan@mectizan.org ▪ بالنسبة للتراخوما، يرجى الاتصال بالمبادرة الدولية لمكافحة التراخوما www.trachoma.org/contact–us
٥.	**طلب الضوء الأخضر** ١,٥ تطلب الجهة المانحة بالبريد الالكتروني الضوء الأخضر من المنظمة / منسق البرنامج الوطني. ويمكن أن يتضمن الإخطار الوثائق التالية: ١. الفواتير ٢. مسودة بوليصة الشحن الجوي (إن وُجدت) * ٣. قائمة التعبئة ٤. شهادة المنشأ ٥. شهادة التحليل ٦. شهادة الإعفاء من الرسوم الجمركية (المنظمة) ٧. شهادة التبرع * لا تتوفر بوليصة الشحن إلا بعد مغادرة السفينة ميناء المنشأ.	▪ برامج تقديم طلبات الحصول على أدوية الأمراض المدارية المهملة، المنظمة / منسق البرنامج الوطني. ▪ الضوء الأخضر هو رسالة تأكيد من منسق البرنامج الوطني / المنظمة إلى الجهة المانحة تفيد بأن البلد مستعد لاستقبل شحنة الأدوية. ويجب على المنظمة أو منسق البرنامج الوطني تأكيد استكمال التجهيزات **اللازمة** قبل إرسال مذكرة الضوء الأخضر. ▪ تعين وزارة الصحة / منسق البرنامج الوطني / المنظمة الموظفين المسؤولين عن تقييم كل سؤال من الأسئلة الخمسة المدرجة في القائمة المرجعية للضوء الأخضر.	▪ انظر بنود العمل والقائمة المرجعية للضوء الأخضر في **الملحق ٣**: يجب على منسق البرنامج الوطني / المنظمة / المرسل إليه الإجابة بـ "نعم" على جميع الأسئلة قبل إعطاء الضوء الأخضر.

المهمة	التعليمات	المسؤولية	المراجع
٦.	**حجز الشحن** ١,٦ تقوم الجهة المانحة بالحجز لإرسال الشحنة وتحميلها على وسيلة نقل (جوي أو بحري). ٢,٦ إصدار وثائق الشحن ٣,٦ ترسل الجهة المانحة وثائق الشحن إلى منسق البرنامج الوطني / المنظمة		

المراجع

١. حزمة الطلبات المشتركة – التخطيط وطلب الأدوية والإبلاغ. في صفحة الأمراض المدارية المهملة للموقع الشبكي للمنظمة. جنيف: منظمة الصحة العالمية؛ ٢٠٢١ (https://www.who.int/teams/control-of-neglected-tropical-diseases/interventions/strategies/preventive-chemotherapy/joint-application-package/version4 ، تم الاطلاع عليه في ١٨ آذار / مارس ٢٠٢٢).

٢. تدير المبادرة الدولية للتراخوما تبرع شركة فايزر بالمضاد الحيوي اللازم لعلاج التراخوما من خلال موقع المبادرة الدولية للتراخوما In: International Trachoma Initiative [website]. Decatur (GA): International Trachoma Initiative; 2021 (https://www.trachoma.org/fighting-trachoma-zithromax, accessed 18 March 2022).

٣. الموجز القطري .[online view]. In: NTDeliver Supply Chain Information System [website]. (https://www.ntdeliver.com/country, accessed 18 March 2022).

٤. نموذج الاشتراك في الصفحة القطرية .In: NTDeliver Supply Chain Information System [website]. (https://www.ntdeliver.com/subscribers/new, accessed 18 March 2022).

٥. تتبع الزيثروماكس القطري. In: GET2020 [online database]. Decatur (GA): International Trachoma Initiative; 2021 (https://www.trachomadata.org/supply-chain/subscription, accessed 18 March 2022).

٣. التخليص الجمركي والتسليم

١,٣ الغرض من إجراء التشغيل الموحد هذا ونطاقه

يشكل التخليص الجمركي والتسليم الخطوتين الأخيرتين في استلام الأدوية في البلد. ويحدد هذا الإجراء العمليات الرئيسية لكل من الجهات المانحة للأدوية ومتلقيها.

التخليص الجمركي هو العملية الأولى. وهو يشمل الإفراج عن الأدوية من نقطة الدخول إلى المتلقي.

والتسليم هو العملية الثانية. وهو يشمل نقل الأدوية من نقطة الدخول (بعد الإفراج عنها) إلى المخزن / المستودع الطبي المركزي. وينبغي اتباع هذه الإجراءات من أجل:

- تبسيط نقل الأدوية، من مصنع الجهة المانحة أو مستودع الإنتاج التابع لها إلى المخزن الطبي المركزي للبلد، للتمكين من تنفيذ المعالجة الجموعية في الوقت المقرر؛
- تجنب التأخر الناجم عن عدم توافر الموظفين اللازمين لتفريغ الأدوية المسلمة إلى المخزن الطبي المركزي؛
- خفض التكاليف التي تتكبدها الجهة المانحة والبلد المتلقي للأدوية، وتشمل ما يلي:
  - تكاليف الشحن البحري: تأجير حاويات شركات الشحن، ورسوم التخزين في الميناء والغرامات، وكذلك تكاليف الحيازة لدى شركة الشحن أو شركة النقل بين القارات؛
  - تكاليف الشحن الجوي: تكاليف التخزين والاحتجاز في المطار التي تتكبدها شركة النقل بين القارات.

٢,٣ الاعتبارات الرئيسية

- الوظائف المحددة، وأدوارها، والخطوات التي يجب اتخاذها في هذا الإجراء هي أمثلة توضيحية وينبغي تعديلها بما يناسب السياق السائد في كل بلد.
- بالنسبة للبلدان غير الساحلية، قد تتطلب الشحنات البحرية التخليص في كل من الميناء البحري والحدود البرية. وينبغي أن يوضع في الاعتبار الوقت الإضافي اللازم للتخليص المتعدد.

٣,٣ إجراء التشغيل الموحد

١,٣,٣ قبل وصول الشحنة

متى	من	ماذا	كيف
قبل وصول شحنة الأدوية إلى الميناء / الحدود؛ عادةً بمجرد أن يبدأ المتبرع بالأدوية عملية شحنها (من أسابيع إلى أشهر قبل الوصول، بحسب وسيلة الشحن).	▪ المنظمة ▪ منسق البرنامج الوطني ▪ وكيل الشحن المعيَّن من المتبرع أو وكيل الشحن المعيَّن من المنظمة / منسق البرنامج الوطني ("وكيل الشحن") ▪ مدير سلسلة الإمداد في المخزن / المستودع الطبي المركزي	▪ تقدم المنظمة / منسق البرنامج الوطني الوثائق المطلوبة من البلد[1] إلى وكيل الشحن المعيَّن من المتبرع أو من المنظمة لغرض التخليص على الأدوية. [1] يرد بيان لإجراء الحصول على الوثائق اللازمة لغرض التخليص على الأدوية في البلد في الفصل ٢: إخطار الشحن والضوء الأخضر.	١. ينبغي للمنظمة / منسق البرنامج الوطني أن تبدأ عملية الحصول على الوثائق بمجرد استلام جميع الوثائق اللازمة للشحنة من المتبرع بالأدوية، وأن تحدد وتجمع الوثائق والتوقيعات والموافقات المطلوبة في البلد.

المهمة	التعليمات	المسؤولية	المراجع
١.	تقدم المنظمة / منسق البرنامج الوطني الوثائق المطلوبة من البلد إلى وكيل الشحن المعيَّن من المتبرع أو من المنظمة لغرض التخليص على الأدوية. ١,١ حدد الوثائق المطلوبة لبلدك، التي قد تشمل: – الاعفاء من الضرائب – تصاريح الاستيراد – خطة توزيع الأدوية – ترخيص التسويق – موافقة وزارة المالية في البلد – نسخ من الوثائق مختومة من وزارة الصحة، مثل الفاتورة، أو قائمة التعبئة، أو بيان الشحنة، أو شهادة المنشأ، أو شهادة التبرع، أو شهادة التحليل ٢,١ يمكن أيضاً لوكيل الشحن الاتصال بالخدمات الجمركية لتأكيد الوثائق والاستفسار عن المتطلبات الإضافية أو تغييرات العملية في البلد. – إذا لزم الأمر، يخطر وكيل الشحن المنظمة / منسق البرنامج الوطني في الوقت المناسب لغرض الحصول على الوثائق الإضافية أو تلبية المتطلبات الجديدة من أجل تجنب تأخر التخليص. – البدء في جمع الوثائق.	▪ المنظمة ▪ منسق البرنامج الوطني. ▪ وكيل الشحن	انظر الفصل ٢: إخطار الشحن والضوء الأخضر
٢.	قد تكون الوثائق، ولاسيما الاعفاءات من الضرائب وتصاريح الاستيراد، مطلوبة من قنوات مختلفة بحسب محتويات وقيمة الشحنة؛ ومن المهم معرفة القناة أو القنوات المناسبة لبلدك في وقت مبكر لتجنب تأخر التخليص أثناء السعي للحصول على الموافقات.		

٢,٣,٣ عند وصول الشحنة إلى نقطة الدخول أو الحدود

متى	من	ماذا	كيف
لدى الوصول، وفي غضون يومين إلى أسبوعين بعد الوصول	▪ المنظمة ▪ منسق البرنامج الوطني ▪ وكيل الشحن ▪ مدير سلسلة الإمداد أو المرسل إليه	▪ إجراء التخليص الجمركي	١. إبلاغ جميع الأطراف المعنية ٢. تحديد جدول زمني ٣. تقديم الوثائق المطلوبة الموقعة / المختومة

المهمة	التعليمات	المسؤولية	المراجع
١.	**يخطر وكيل الشحن الأطراف ذات الصلة بوصول الشحنة** ١,١ يخطر وكيل الشحن المنظمة / منسق البرنامج الوطني بوصول الشحنة ويقدم جدولاً زمنياً متوقعاً للتخليص الجمركي والتسليم في المخزن الطبي المركزي، وذلك بالبريد الإلكتروني أو الهاتف. ٢,١ تقدم المنظمة / منسق البرنامج الوطني المعلومات المذكورة أعلاه إلى مدير سلسلة الإمداد، أو مدير عمليات المخزن الطبي المركزي أو صيدلي برنامج الأمراض المدارية المهملة، على النحو المحدد في البلد.	▪ وكيل الشحن ▪ المنظمة ▪ منسق البرنامج الوطني	
٢.	**يستكمل وكيل الشحن التخليص الجمركي** ١,٢ يتأكد وكيل الشحن من تسليم جميع الوثائق المطلوبة، مع التوقيعات / الأختام المناسبة المطلوبة بموجب اللوائح الجمركية. ٢,٢ يخطر وكيل الشحن المنظمة / منسق البرنامج الوطني ومدير سلسلة الإمداد أو من ينوب عنه بموعد وصول الشحنة إلى المخزن الطبي المركزي. ٣,٢ يؤكد مدير سلسلة الإمداد أو من ينوب عنه لصيدلي برنامج الأمراض المدارية المهملة والمنظمة / منسق البرنامج الوطني بتوافر المساحة اللازمة في المخزن الطبي المركزي، وبتوافر الموظفين لتفريغ الشحنة لدى وصولها.	▪ وكيل الشحن ▪ مدير سلسلة الإمداد أو من ينوب عنه	انظر الفصل ٥: إدارة المخزون

٣,٣,٣ بعد التخليص الجمركي: التسليم في المخزن / المستودع الطبي المركزي

متى	من	ماذا	كيف
بعد التخليص الجمركي على الشحنة	▪ وكيل الشحن ▪ مدير سلسلة الإمداد أو من ينوب عنه	▪ تُورد الأدوية وتسلم في المخزن أو المستودع المركزي	١. توفير مبادئ توجيهية واضحة لتسليم الأدوية في المخزن / المستودع الطبي المركزي. ٢. ضمان اتباع عمليات واضحة لاستلام الأدوية وتأكيد استلامها.

المهمة	التعليمات	المسؤولية	المراجع
١.	**يقدم مدير سلسلة الإمداد أو من ينوب عنه تعليمات واضحة بشأن تسليم الأدوية إلى المخزن / المستودع الطبي المركزي** ١,١ يقوم وكيل الشحن بالتخليص على الشحنة ويفيد المنظمة ومنسق البرنامج الوطني بموعد الوصول المقرر للشحنة في المخزن / المستودع الطبي المركزي. ٢,١ يزود مدير سلسلة الإمداد أو من ينوب عنه وكيل الشحن بتفاصيل المخزن / المستودع الطبي المركزي، بما في ذلك المسار الدقيق والتعليمات المتعلقة بعملية التفريغ: ▪ يقوم وكيل الشحن بنقل الشحنة إلى المخزن / المستودع الطبي المركزي. ▪ يتسلم مدير المخزن / المستودع الطبي المركزي الأدوية ويشرف على تفريغها. ▪ يشرف مدير المخزن / المستودع الطبي المركزي على عملية نقل الأدوية إلى الواح التحميل وأرفف المخزن أو المستودع. ▪ يجب أن يحتوي هذا القسم على العملية الكاملة لتفريغ كل دواء؛ وقد تتطلب التركيبات الصلبة، أو القابلة للمضغ، أو المسحوقة، أو السائلة عمليات مختلفة.	▪ وكيل الشحن ▪ مدير سلسلة الإمداد أو من ينوب عنه ▪ مدير المخزن / المستودع الطبي المركزي	انظر الفصل ٤: النقل
٢.	**يجهز مدير سلسلة الإمداد أو من ينوب عنه المخزن أو المستودع لاستقبال الأدوية** ١,٢ يؤكد مدير المخزون / المستودع الطبي المركزي وجود مساحة كافية للشحنة الجديدة وموظفين لمباشرة عمليتي التفريغ والتخزين.	▪ مدير سلسلة الإمداد أو من ينوب عنه ▪ مدير المخزن / المستودع الطبي المركزي	انظر الفصل ٥: إدارة المخزون انظر الفصل ٦: التخزين انظر الفصل ٧: ما تنتهي صلاحيته أولاً يُصرف أولاً

المهمة	التعليمات	المسؤولية	المراجع
٣.	**تُسلم الأدوية إلى المخزن / المستودع الطبي المركزي**	▪ وكيل الشحن ▪ مدير سلسلة الإمداد أو من ينوب عنه	انظر الفصل ٤: النقل انظر الفصل ٥: إدارة المخزون انظر الفصل ٦: التخزين انظر الفصل ٧: ما تنتهي صلاحيته أولاً يُصرف أولاً
	١,٣ ينقل وكيل الشحن الشحنة إلى المخزن / المستودع الطبي المركزي في حاويتها الأصلية.		
	٢,٣ يوفر مدير سلسلة الإمداد أو من ينوب عنه الموظفين اللازمين لتفريغ الشاحنات في المخزن / المستودع الطبي المركزي.		
	٣,٣ يتحقق مدير سلسلة الإمداد أو من ينوب عنه من عدم كسر أقفال الحاوية. فإن كانت مكسورة: – يُطلب من السائق أن يسجل في قسيمة التسليم أن الأقفال مكسورة؛ – إن أمكن، تؤخذ صورة للقفل المكسور بحيث يُسجل الوقت ولتوفير دليل مرئي. – قد يشير القفل المكسور إلى إزالة بعض الأدوية من الشحنة.		
٤.	**استلام الأدوية وتأكيد استلامها**	▪ وكيل الشحن ▪ مدير سلسلة الإمداد أو من ينوب عنه ▪ منسق البرنامج الوطني	
	١,٤ يجري مدير سلسلة الإمداد أو من ينوب عنه جرداً لجميع الأدوية الواردة ويؤكد توافر جميع الواح التحميل والصناديق بحالة جيدة وفقاً لوثائق الشحن. فإن لم تكن الأدوية بحالة جيدة أو بها نقص، يُستكمل ما يلي: – إن كانت الواح التحميل تالفة، افتح جميع الصناديق التالفة على لوح التحميل وتحقق من أن الأدوية في حالة جيدة. وتعني الحالة الجيدة أن الزجاجات غير تالفة وأن سداداتها غير مكسورة. – يُبلغ في مذكرة التسليم عن أي أدوية غير صالحة للاستخدام بسبب التلف، ويُحتفظ بنسخة من السجل. – إن أمكن، تؤخذ صورة لكل البضاعة التالفة بحيث يُسجل الوقت ولتوفير دليل مرئي على التلف.		
	١,١,٤ إن كانت الواح التحميل مفقودة، أوعز إلى السائق أن يسجل أي طبليات مفقودة ورقم التشغيلة أو الدفعة للدواء أو الأدوية المرتبطة بهذه الطبلية في نموذج إثبات التسليم. – يتضمن بيان الشحنة (قائمة التعبئة) والفاتورة رقم الدفعة أو التشغيلة. – إن أمكن، التقط صوراً لكل طبلية تم استلامها للمساعدة في تأكيد الطبليات المفقودة. – أبلغ وكيل الشحن بالأدوية التالفة أو المفقودة واطلب من وكيل الشحن تقديم تقرير رسمي.		
	٢,٤ منسق البرنامج الوطني مسؤول عن طلب أدوية بديلة للتالفة أو المفقودة وفقاً لشروط طلب الحصول على أدوية الأمراض المدارية المهملة.		
	٣,٤ يعد مدير المخزون الطبي المركزي ويقدم تقارير رسمية إلى المورّد في غضون عشرة أيام.		
	٤,٤ يوقع مدير سلسلة الإمداد أو من ينوب عنه أمر التسليم المقدم من وكيل الشحن ويتأكد من توقيع السائق على نسخة أمر التسليم الخاصة بالمشرف على المخزن الطبي المركزي.		
	٥,٤ يجب أن تكون نسخة نموذج إثبات التسليم المقدمة إلى مدير سلسلة الإمداد واضحة وسهلة القراءة. فمن شأن النسخة السهلة القراءة من هذه الوثيقة أن تسمح للبلد أن يتلقى شحنة بديلة للأدوية المفقودة أو التالفة.		
	٦,٤ يقدم وكيل الشحن نموذج إثبات التسليم إلى الجهة المانحة والمنظمة / منسق البرنامج الوطني.		

١,٣ معلومات تكميلية

أنشأ منتدى سلسلة الإمداد بأدوية الأمراض المدارية المهملة بوابة معلومات الكترونية بشأن سلسلة الإمداد بالأدوية، هي NTDeliver (www.ntdeliver.com) ، وهي بوابة تجمع المعلومات المستمدة من مجموعة متنوعة من المصادر في مركز واحد من أجل تحسين رصد وتقييم سلسلة الإمداد بالأدوية المتبرع بها. والغرض من هذه البوابة هو زيادة وضوح سلسلة الإمداد بأدوية الأمراض المدارية المهملة، بدايةً من إصدار أوامر التوريد إلى تسليم الشحنات. ويمكن للبلدان والشركاء، من خلال هذه المعلومات، تنسيق سلاسل الإمداد الداخلية لديهم على نحو أفضل.

ولتعزيز الوصول إلى المعلومات في الوقت المناسب، يمكن للبلدان المتلقية للأدوية تتبع الشحنات المتاحة عن طريق:

- الموجزات القطرية *(١)*، التي تسمح بتتبع العديد من شحنات أدوية الأمراض المدارية المهملة في الوقت الفعلي، وذلك عن طريق الحاسوب أو الهاتف الذكي أو الحاسوب اللوحي؛
- نموذج الاشتراك في الصفحة القطرية *(٢)*، الذي يسمح للمشتركين باختيار البلد الذي يرغبون في تلقي إشعارات البريد الالكتروني عنه. وتقدم البوابة أيضاً تحديثاً أسبوعياً للمشترك.

وتشمل شحنات الأدوية المتاحة للتتبع أدوية الأمراض التالية:

- الفيلاريات اللمفية
  - ألبيندازول المتبرع به من شركة GlaxoSmithKline من خلال المنظمة
  - سترات ثنائي ايثيل كارياميزين المتبرع به من شركة Eisai من خلال المنظمة
- البلهارسيات
  - برازيكوانتيل المتبرع به من شركة Merck KGaA من خلال المنظمة
- الديدان الطفيلية المنقولة بالتربة
  - ألبيندازول المتبرع به من شركة GlaxoSmithKline من خلال المنظمة
  - ميبيندازول المتبرع به من شركة Johnson & Johnson من خلال المنظمة
- التراخوما
  - أزيثروميسين المتبرع به من شركة Pfizer من خلال المبادرة الدولية لمكافحة التراخوما.

ولا يمكن تتبع إيفرمكتين من خلال بوابة NTDeliver . يُرجى الرجوع إلى برنامج مكتيزان للتبرع (https://mectizan.org/)

المراجع

١. الموجز القطري [على الانترنت]. في الموقع الشبكي لنظام معلومات سلسلة الإمداد بأدوية الأمراض المدارية المهملة NTDeliver. (https://www.ntdeliver.com/country ، تم الاطلاع عليه في ١٨ آذار / مارس ٢٠٢٢).

٢. نموذج الاشتراك في الصفحة القطرية. في الموقع الشبكي لنظام معلومات سلسلة الإمداد بأدوية الأمراض المدارية المهملة NTDeliver. (https://www.ntdeliver.com/subscribers/new ، تم الاطلاع عليه في ١٨ آذار / مارس ٢٠٢٢).

٤. النقل

١,٤ الغرض من إجراء التشغيل الموحد هذا ونطاقه

يغطي هذا الإجراء عملية نقل الأدوية من المخازن الطبية المركزية إلى الأقاليم / الولايات / المحافظات، أو من الأقاليم إلى نقاط التوزيع إلى مستوى المقاطعات. ويبين **الشكل** ١,٤ الخطوات الأساسية.

وتنطوي عملية نقل الأدوية بعد التخليص الجمركي إلى نقاط التوزيع على العديد من الخطوات وتستغرق وقتاً، وتُنقل عادة بالطرق البرية وفي بعض البلدان بالطائرة أيضاً. ويتطلب ضمان وصول الأدوية الصحيحة بالكميات الصحيحة إلى كل مركز صحي تخطيطاً دقيقاً وعمليات دقيقة؛ وقد يكون استرداد الأدوية الزائدة من أحد المواقع لتلبية الاحتياجات في موقع آخر، ربما في أطراف البلد، مكلفاً للغاية وقد يؤخر كثيراً جدول المعالجة الجموعية. ومن المهم جداً أن نعرف في وقت مبكر الأماكن المحتاجة إلى الأدوية، وكميات الأدوية المطلوبة، ومتى يُحتاج إليها، قبل وقت كاف من موعد النقل.

٢,٤ الاعتبارات الرئيسية

التخطيط. ينطوي نجاح نقل الأدوية على العوامل المهمة التالية.

خطة توزيع

- خطة توزيع تحدد دائرة ومراحل التوزيع من المستوى المركزي إلى مستوى المقاطعات.

ميزانية

- التمويل اللازم لتأمين تأجير الشاحنات أو دفع البدل اليومي للسائقين أو توفير الأمن، إن لم يكن ذلك متاحاً بالفعل، عن طريق نظم الإمداد الطبية الحكومية القائمة.
- مثال: يخصص البرنامج الوطني لمكافحة الأمراض المدارية المهملة تمويلاً لصيدلية الإمدادات الوطنية بالأدوية في صيدليات الإمداد الإقليمية. ويُخصص على المستوى الإقليمي خط نقل للمناطق لغرض الإزالة والتوجيه عند نقاط تقديم الخدمات.

السلطة المسؤولة

- حدد الشخص الذي يقرر أي الأقاليم أو المقاطعات تتلقى أي أدوية، وخاصة عندما تصل الأدوية إلى البلد في أوقات مختلفة. تحقق من أن السلطة المشار إليها لديها صلاحية تحديد الأولويات.
- حدد من له سلطة التوقيع في نقطة الاستلام.

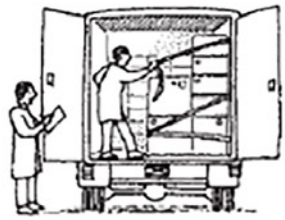
الشكل ١,٤ الخطوات الرئيسية لنقل الأدوية إلى الميدان



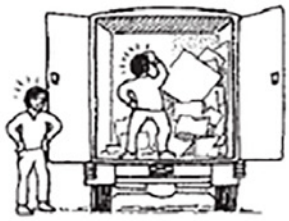
املأ فراغات الصندوق بمواد التعبئة



تجنب كسر العبوات



حمِّل المركبات بعناية وبطريقة منهجية، ما يُحمَّل أولاً يُخرج آخراً



وفِّر الوقت عند التفريغ.
تجنب التلف المادي



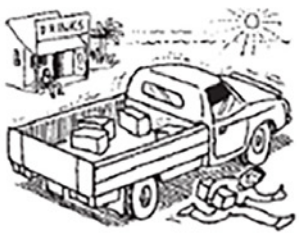
أحكم غلق أبواب المركبة



تجنب الفاقد أو السرقة



قم بحماية الإمدادات من أشعة الشمس أو المطر.
قف بالقرب من المركبة



قلل تلف الأدوية قدر الإمكان أثناء النقل.
احترس من السرقة



ابدأ الرحلة في الصباح الباكر مع القيادة بعناية، وبخاصة على الطرق الخطيرة



تجنب القيادة ليلاً



تأكد من التسليم الآمن وفي الوقت المناسب



تجنب الحوادث

المصدر: مستنسخ بإذن من مؤسسة MSH (Management Sciences for Health) (الشكل ٢٥-٣: النقل الآمن للأدوية). (https://www.msh.org/resources/mds-3-managing-access-to-medicines-and-health-technologies ، تم الاطلاع عليه في ١٨ آذار / مارس ٢٠٢٢).

الأمن

- لبعض الأدوية قيمة عالية في تلبية احتياجات أخرى (الثروة الحيوانية وفئات مستهدفة أخرى)؛ ومن الأهمية بمكان ضمان سلامة نقل الأدوية دون التعرض للتلف أو السرقة من أجل تنفيذ المعالجة الجموعية بتغطية جيدة وتحقيق أهداف التخلص من الأمراض ومكافحتها. ويجب ضمان سلامة الأدوية على جميع المستويات، بداية من تلقيها في البلد وانتهاءً بوصولها إلى المجتمعات.

الوثائق

- يحقق تتبع وحدات حفظ المخزون الإلكترونية فائدة عظيمة في إدارة سلسلة الإمداد، من المستوى المركزي إلى مستوى المقاطعات؛ ومع ذلك فإن النظم الورقية تكفي إذا أُديرت بكفاءة مع العمليات المفصلة وإعادة النماذج الموقعة إلى منشأها لغرض الحفظ (إغلاق الدائرة).
- يجب ضمان توفر النماذج المناسبة لدى البلد لتوثيق عملية النقل.
- يجب ضمان وجود نظم لمراقبة المخزونات في كل خطوة؛ وينبغي أن ترافق عملية التسليم في كل مرحلة وثائق مستكملة بشكل صحيح.

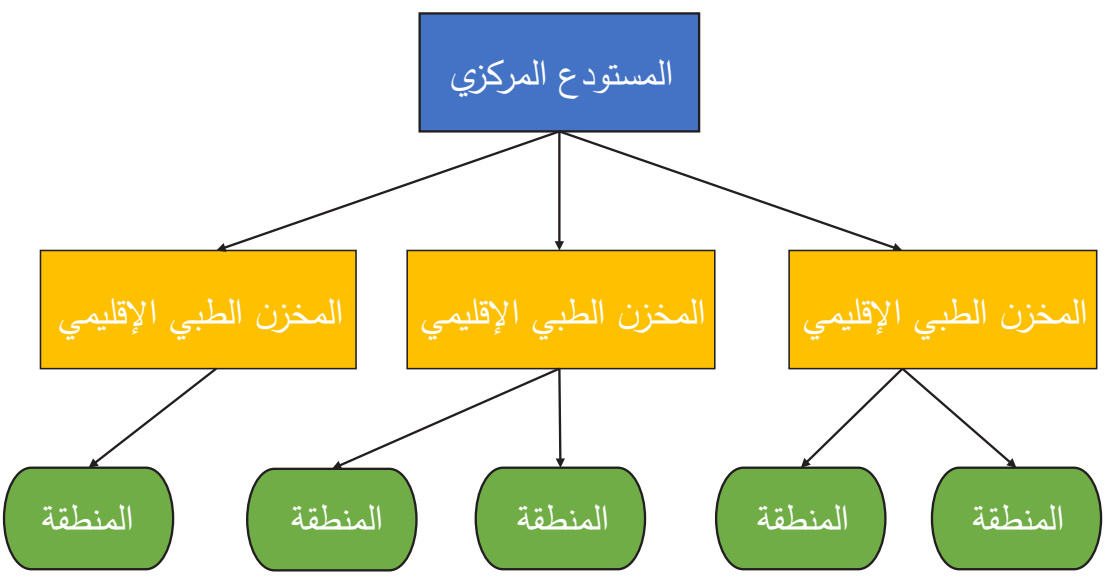
الأوضاع البيئية

- يمكن بسهولة أن تتلف الأدوية التي تُنقل في طقس لا يمكن التنبؤ به (مثلاً الموسم الدافئ أو الجاف مقابل الموسم الرطب) أو على طرق سيئة. ومن الضروري ضمان أن تكون آليات النقل المستخدمة مناسبة لحفظ المخزونات من التلف أو التدهور ولضمان وصولها في حالة تُعتبر سليمة أو غير تالفة. ولمزيد من المعلومات والتوضيح، انظر الفصل ٩.

٣,٤ إجراء التشغيل الموحد

يتألف الإجراء من مرحلتين: النقل من المستوى المركزي إلى الأقاليم / الولايات / المحافظات (١,٤,٣)، والنقل من الأقاليم إلى المقاطعات (٢,٤,٣). وقد يكون استخدام هذه الخطوات لتطوير إجراءات التشغيل الموحدة إجراءً مستقلاً أو مشتركاً بحسب الحاجة المحددة لسلسلة الإمداد. وعادةً ما يكون الإطار الزمني لتخطيط النقل قبل المعالجة الجموعية بأسبوعين إلى أربعة أسابيع. ويبين **الشكل** ٢,٤ مثالاً لمخطط تدفق النقل. والوظائف المحددة وأدوارها والخطوات الواجب اتخاذها في هذا الإجراء هي أمثلة توضيحية وينبغي تعديلها بما يناسب السياق السائد في كل بلد.

الشكل ٢,٤ مثال لمخطط تدفق النقل



ملاحظة: في حالة عدم وجود مخزون طبي إقليمي، يكون اتجاه المسار إلى المناطق مباشرةً.

١,٣,٤ النقل من المستوى المركزي إلى الأقاليم / الولايات / المحافظات (أو إلى المقاطعات إن لم توجد مرافق إقليمية)

متى	من	ماذا	كيف
بناءً على طلب من الأقاليم (عادة من أسبوعين إلى أربعة قبل المعالجة الجموعية) بعد المعالجة الجموعية إذا أُعيدت المخزونات إلى المستوى المركزي	▪ المنظمة / المرسل إليه ▪ برنامج الأمراض المدارية المهملة ▪ الشركاء المنفذون (في حالة تكاليف الدعم) ▪ الصيدلية المركزية ▪ المخازن الطبية المركزية ▪ المخزن الطبي للولاية ▪ المخازن الطبية الإقليمية ▪ السائقون ▪ عمال تحميل / تفريغ الشاحنات **مستوى السلطة المطلوبة** ▪ سلطة التوقيع لتخصيص كميات محددة من الأدوية للأقاليم ▪ سلطة التوقيع لإزالة الأدوية، إما لصرفها لمواقع ميدانية أو لتدميرها	▪ نقل المواد الدوائية المتبرع بها أو المشتراة من الموقع المركزي إلى الموقع الإقليمي ▪ تخصيص وتوزيع الكميات الصحيحة من الأدوية إلى نقاط التوزيع على مستوى الإقليم / المقاطعات	١. التحضير لنقل الشحنة من المستوى المركزي ٢. تجهيز علب الكرتون / الصناديق لكل مخزن طبي إقليمي ٣. إعداد قسيمة صرف / استلام لكل مخزن طبي إقليمي، وبوليصة شحن لإجمالي علب الكرتون لكل وجهة. ٤. فحص / عد علب الكرتون المحكمة الإغلاق / المكتملة، وحصر عدد الزجاجات في علب الكرتون المفتوحة ٥. تحميل الشاحنات ٦. تفريغ الشاحنات ٧. استلام المخزن الطبي الإقليمي للشحنة أو الشحنات والوثائق ٨. تأكيد التسليم

المهمة	التعليمات	المسؤولية	المراجع
١.	**التحضير لنقل الشحنة من المستوى المركزي** ١,١ التواصل مع برنامج الأمراض المدارية المهملة والتحقق بانتظام من الموعد الدقيق لوصول الأدوية إلى المستوى الإقليمي وفقاً لجدول توزيع الأدوية. ١,١,١ توفير معلومات الاتصال الخاصة بالمرسل إليه وجهات الاتصال الإقليمية. ٢,١ تأكد من أن المستودع الإقليمي على علم بالتسليم المقرر وأن مساحة التخزين متوفرة. ١,٢,١ تحديد القيود المرتبطة بالتسليم في أيام معينة (مثلاً، عدم قبول التسليم في إجازة نهاية الأسبوع). ٣,١ وضع جدول زمني للكميات والتوزيع بالتنسيق مع برنامج الأمراض المدارية المهملة لضمان النقل الآمن والفعال؛ وإعلام المرفق الطبي الإقليمي بهذا الجدول الزمني. ١,٣,١ ينبغي أن يشمل هذا الجدول الزمني أوقات السفر التقريبية لكل شحنة تُسلم في المخزن الطبي الإقليمي، مع مراعاة فترات التوقف المناسبة لأخذ قسط من الراحة، وتجنب القيادة ليلاً، وسوء أحوال الطرق. ٤,١ الحصول على الموافقة اللازمة من منسق مكافحة الأمراض المدارية المهملة في المقاطعة أو من المكتب الصحي في المقاطعة على خطة التوزيع وميزانية النقل وتأمين التمويل.	▪ نقطة الاتصال في المخزن الطبي المركزي بالتنسيق مع كل من: ▪ برنامج الأمراض المدارية المهملة ▪ المنظمة / المرسل إليه ▪ الشركاء المنفذين ▪ نقطة الاتصال في المكتب الصحي للمقاطعة ▪ نقطة الاتصال في المخزن الطبي الإقليمي ▪ السائقين ▪ موظفي تعبئة / تفريغ الشاحنات	انظر الفصل ٦: التخزين انظر الفصل ١١: التتبؤ والتقدير الكمي

المهمة	التعليمات	المسؤولية	المراجع
	١,٤,١ النظر في تزويد السائقين بباقات تواصل متنقلة للإبلاغ عن الحوادث التي تقع على الطريق؛ فإن لم يكن لدى السائقين هواتف محمولة، يُنظر في تزويدهم بهواتف مؤقتة مزودة بآلات تصوير. ٢,٤,١ تأكد من دفع أجر للسائق لإعادة النماذج الموقعة إلى المخزن الطبي المركزي أو المخزن الطبي في الولاية لتأكيد التسليم. ٥,١ تأكد من أن مركبات النقل تفي بالمعايير المقبولة لنقل الأدوية (مثلاً، حالة العمل، والتغطية المناسبة من أحوال الطقس). ٦,١ حدد العدد الكامل من علب الكرتون / الصناديق التي ستُسلم إلى كل مخزن طبي إقليمي، وجهّز بوليصة الشحن. ٧,١ تأكد من إعداد القسائم لكل مخزن طبي إقليمي محدد. ٨,١ تأكد من ترتيب النقل إلى المخزن الطبي الإقليمي في الموعد المحدد أو المواعيد المحددة. مثلاً، إن كانت الشاحنات غير متاحة للاستعمال من جانب المخزن الطبي المركزي، كيف ستُوفر وسيلة النقل؟ ٩,١ يخطر المخزن الطبي المركزي المخزن الطبي الإقليمي مسبقاً بأن الشاحنة يجري إعدادها للنقل. ١,٩,١ تأكد من توافر موظفين لتعبئة وتفريغ الشاحنات. ١٠,١ جهّز إجراءات تأمين النقل من السرقة أو الأحوال الجوية أو المخاطر الأخرى. ١١,١ حدّد / تأكد من الشخص الذي له حق الوصول إلى المخزون أثناء النقل (إن كان مغلقاً عليه في الشاحنة).		
٢.	**تجهيز علب الكرتون / الصناديق لكل مخزن طبي إقليمي** ١,٢ إعادة تجهيز علب الكرتون بالمخزون على أساس الكمية اللازمة المحددة في جدول التوزيع. ٢,٢ املأ الفراغات في علب الكرتون بمواد التعبئة لتجنب تلف الأدوية. ٣,٢ ضع، إن أمكن، بطاقة على كل علبة يُدون عليها اسم المخزن الطبي الإقليمي المقصود لغرض التحقق المزدوج. ٤,٢ تأكد من تعبئة المخزون الأقدم والسابق الفتح أولاً (مرفقاً لمبدأ "ما تنتهي صلاحيته أولاً يُصرف أولاً) ٥,٢ ينبغي توثيق وإزالة أي مخزون تالف أو انتهت صلاحيته.	▪ نقطة الاتصال في المخزن الطبي المركزي بالتنسيق مع كل من: ▪ نقطة الاتصال في المخزن الطبي الإقليمي ▪ نقطة الاتصال في المكتب الصحي للمقاطعة	انظر الفصل ٧: ما تنتهي صلاحيته أولاً يُصرف أولاً انظر الفصل ١٠: إدارة النفايات
٣.	**إعداد قسيمة صرف / استلام لكل مخزن طبي إقليمي، وبوليصة شحن لإجمالي علب الكرتون المرسلة لكل وجهة** ١,٣ سجّل بوضوح عدد زجاجات كل نوع دواء مرسلة إلى كل مخزن طبي إقليمي. وإن أمكن، أدرج أيضاً مراكز التوزيع المحددة لكل علبة كرتون.	▪ نقطة الاتصال في المخزن الطبي الإقليمي، بالتنسيق مع: ▪ نقطة الاتصال في المخزن الطبي المركزي ▪ السائقين	
٤.	**فحص / عد علب الكرتون المغلقة / الكاملة وحساب عدد الزجاجات في علب الكرتون المفتوحة** ١,٤ ضمان وجود كشوف الإحصاء أو نماذج إدارة المخزون المناسبة الأخرى قبل التحميل على الشاحنات. ٢,٤ يؤكد المخزن الطبي المركزي والسائق العدد بالمقارنة مع القسائم المعدة وبوليصة الشحن ويوقعان على كل منهما.	▪ المخزن الطبي الإقليمي بالتنسيق مع: ▪ نقطة الاتصال في المخزن الطبي المركزي ▪ السائقين	انظر الفصل ٥: إدارة المخزون
٥.	**التحميل على الشاحنات** ١,٥ قم بتحميل الشاحنات بشكل منهجي، باتباع إجراء "ما يُحمل أولاً يفرغ آخراً". ٢,٥ استخدم أحزمة التحميل لمنع التلف المادي. ٣,٥ قم بتأمين أبواب المركبة من السرقة وأحوال الطقس. وأكد الشخص الذي له حق الوصول إلى المخزون. ٤,٥ تأكد من أن المسار يوفر وقتاً كافياً للراحة والسلامة (تجنب القيادة ليلاً والطرق السيئة). ٥,٥ يجب تأمين أي شحنة يستغرق توصيلها أكثر من يوم وفحصها بصرياً عند كل توقف بالليل وفي كل صباح، مع توثيق ذلك على النحو المناسب.	▪ نقطة الاتصال في المخزن الطبي الإقليمي، بالتنسيق مع: ▪ السائقين ▪ موظفي تحميل الشاحنات	

المهمة	التعليمات	المسؤولية	المراجع
٦.	**تفريغ الشاحنات** ١,٦ عند وصول الشحنة، قم بتفريغها وفقاً لجدول التوزيع وسياسة ما يُحمل أولاً يُفرغ آخراً. ٢,٦ يقدم السائق القسيمة وبوليصة الشحن إلى المتلقي في كل مخزن طبي إقليمي، مع تسجيل اسم السائق ولقبه وتوقيعه والتاريخ (اليوم / الشهر / السنة). ٣,٦ يقوم نقطة الاتصال في المخزن الطبي الإقليمي بفحص وعد علب الكرتون المغلقة وغير المغلقة، ويوقع القسيمة وبوليصة الشحن المعدة. ٤,٦ ينبغي توثيق أي مخزونات تالفة / انتهت صلاحيتها وإزالتها	▪ نقطة الاتصال في المخزن الطبي الإقليمي، بالتنسيق مع: ▪ السائقين ▪ موظفي تفريغ الشاحنات	انظر الفصل ٦: التخزين انظر الفصل ١٠: إدارة النفايات
٧.	**استلام المخزن الطبي الإقليمي للشحنة / الشحنات والوثائق** ١,٧ إن كانت الوثائق غير كاملة أو مفقودة، لا ينبغي للمخزن الطبي الإقليمي قبول الشحنة؛ اتصل بنقطة الاتصال في المخزن الطبي المركزي للحصول على توجيهات. ٢,٧ إن كانت الوثائق لا تتطابق مع الكميات المستلمة: ١,٢,٧ قبول التسليم وإعداد تقرير عن التباين في الكمية الموردة تُسجل فيه الكمية الزائدة أو الناقصة. تُسلم نسخة للسائق لتقديمها إلى نقطة الاتصال في المخزن الطبي المركزي. ٣,٧ في حالة وجود زيادة في الكمية الموردة، تُعاد الكمية الزائدة والفاتورة إلى السائق، وتُطلب فاتورة جديدة بالكمية المقبولة. ٤,٧ يُخطر نقطة الاتصال في برنامج الأمراض المدارية المهملة والمكتب الصحي في المقاطعة باستلام الكميات. ٥,٧ ينبغي توثيق وإزالة أي مخزون تالف أو انتهت صلاحيته.	▪ نقطة الاتصال في المخزن الطبي الإقليمي، بالتنسيق مع: ▪ نقطة الاتصال في المخزن الطبي المركزي ▪ السائقين	انظر الفصل ١٠: إدارة النفايات
٨.	**تأكيد التسليم** ١,٨ يتسلم السائق إيصال الاستلام الموقع ويودع نسخة منه لدى المخزن الطبي المركزي كمحضر تسليم مؤرخ (اليوم / الشهر / السنة).	▪ نقطة الاتصال في المخزن الطبي المركزي، بالتنسيق مع: ▪ برنامج الأمراض المدارية المهملة ▪ المنظمة / المرسل إليه ▪ نقطة الاتصال في المخزن الطبي الإقليمي ▪ السائقين	

٢,٣,٤ النقل من الأقاليم إلى المقاطعات

(بما في ذلك النقل من المقاطعات بعد المعالجة الجموعية إلى المستوى الإقليمي / المركزي لغرض التخزين النهائي أو التدمير)

متى	من	ماذا	كيف
بناءً على طلب من مستوى المقاطعة (عادةً ٢ – ٤ أسابيع قبل المعالجة الجموعية) بعد المعالجة الجموعية أو بعد تقييم حالة أمراض محددة إذا أُعيدت المخزونات إلى المستوى المركزي / الإقليمي أو لغرض التدمير	▪ المنظمة / المرسل إليه ▪ برنامج الأمراض المدارية المهملة ▪ مكتب الصحة في المقاطعة ▪ الشركاء المنفذين (في حالة تكاليف الدعم) ▪ المخزن الطبي الإقليمي ▪ السائقون ▪ موظفو تعبئة / تفريغ الشاحنات مستوى السلطة المطلوبة: ▪ سلطة التوقيع لتخصيص كميات محددة من الأدوية للمناطق / نقاط التوزيع ▪ سلطة التوقيع لإزالة الأدوية، إما لصرفها لمواقع ميدانية أو لتدميرها	▪ نقل الأدوية المتبرع بها / المشتراة و/أو مواد التشخيص ▪ تخصيص وتوزيع الكميات الصحيحة من الأدوية و / أو مواد التشخيص على نقاط التوزيع على مستوى المقاطعة	٤. التحضير لنقل الشحنة من مستوى الإقليم أو المقاطعة، أو بعد المعالجة الجموعية إلى التخزين الطويل الأجل و / أو لتدمير النفايات ٥. تجهيز علب الكرتون / الصناديق لكل نقطة توزيع ٦. إعداد قسيمة صرف / استلام لكل مخزن طبي إقليمي لإجمالي علب الكرتون المرسلة لكل وجهة. ٧. فحص وعد علب الكرتون المغلقة / حصر عدد الزجاجات في علب الكرتون المفتوحة ٨. التحميل على الشاحنات / تفريغ الشاحنات ٩. التخزين المؤقت أو التدمير ١٠. استلام المقاطعة للشحنة (الشحنات) والوثائق ١١. تأكيد التسليم

المهمة	التعليمات	المسؤولية	المراجع
١.	**تقوم مقاطعة التخطيط / التنسيق بتجهيز مستودع المقاطعة** ١,١ قبل خمسة أيام من بدء المعالجة الجموعية، يجب على المكتب الصحي في المقاطعات التأكد من توزيع الأدوية على مستوى المقاطعة. ٢,١ يجب أن يضمن برنامج الأمراض المدارية المهملة إبلاغ مدير مستودع المقاطعة ببرنامج التسليم المخطط وبتوافر مساحة للتخزين في المستودع. ٣,١ يجب أن يعتمد برنامج الأمراض المدارية المهملة على التخطيط الجزئي للمعالجة الجموعية لوضع خطة للتوزيع في المقاطعات. ٤,١ يجب أن يطلع برنامج الأمراض المدارية المهملة مدير مستودع المقاطعة على خطة التوزيع وأن يبلغه بموعد النقل. ٥,١ يجب على مدير المستودع إعداد بوليصة الشحن بحسب المقاطعة ١,٥,١ يجب أن تتضمن خطة التوزيع مواعيد السفر التقريبية لكل شحنة تُسلم على مستوى المقاطعة، مع مراعاة أوقات التوقف المناسبة للراحة، وضرورة تجنب القيادة ليلاً، وسلوك الطرق المعبّدة المعتادة. ٢,٥,١ الحصول على الموافقة اللازمة من قِبل برنامج الأمراض المدارية المهملة على خطة التوزيع وميزانية النقل.	▪ ينسق نقطة الاتصال في المخزن الطبي الإقليمي / المكتب الصحي للمقاطعة مع: ▪ البرنامج المجتمعي للأمراض المدارية المهملة ▪ الشركاء المنفذين ▪ السائقين ▪ موظفي تحميل / تفريغ الشاحنات	انظر الفصل ٦: التخزين
٢.	**تجهيز علب الكرتون / الصناديق لكل نقطة توزيع** ١,٢ إعادة تجهيز علب الكرتون بالمخزون على أساس الكمية اللازمة لكل مقاطعة، المحددة في جدول التوزيع. ٢,٢ املأ فراغات علب الكرتون بمواد التعبئة لتجنب تلف الأدوية. ٣,٢ ضع، إن أمكن، بطاقة على كل علبة تُدون عليها المقاطعة المقصودة لغرض التحقق المزدوج. ٤,٢ تأكد من تعبئة المخزون الأقدم والسابق الفتح أولاً. ٥,٢ ينبغي توثيق وإزالة أي مخزون تالف أو انتهت صلاحيته.	▪ ينسق نقطة الاتصال في المخزن الطبي الإقليمي / المكتب الصحي للمقاطعة مع: ▪ البرنامج المجتمعي للأمراض المدارية المهملة	انظر الفصل ٧: ما تنتهي صلاحيته أولاً يُصرف أولاً. انظر الفصل ١٠: إدارة النفايات.
٣.	**إعداد قسيمة صرف / استلام لكل مخزن طبي إقليمي لإجمالي علب الكرتون المرسلة لكل وجهة.** ١,٣ سجّل بوضوح عدد الزجاجات التي سترسل الى كل مقاطعه من كل نوع دواء	▪ ينسق نقطة الاتصال في المخزن الطبي الإقليمي / المكتب الصحي للمقاطعة مع: ▪ البرنامج المجتمعي للأمراض المدارية المهملة ▪ السائقين	
٤.	**فحص / عد علب الكرتون المغلقة وحصر عدد الزجاجات في علب الكرتون المفتوحة** ١,٤ تأكد من وجود كشوف الإحصاء أو نماذج إدارة المخزون المناسبة قبل التحميل على الشاحنات. ٢,٤ يؤكد كلا من المخزن الطبي الإقليمي والسائق العدد بالمقارنة مع القسائم المعدة وبوليصة الشحن ويوقعان على كليهما.	▪ ينسق نقطة الاتصال في المخزن الطبي الإقليمي والمكتب الصحي للمقاطعة مع: ▪ البرنامج المجتمعي للأمراض المدارية المهملة ▪ السائقين	انظر الفصل ٥: إدارة المخزون
٥.	**التحميل على الشاحنات** ١,٥ قم بتحميل الشاحنات بشكل منهجي، باتباع إجراء "ما يُحمّل أولاً يفرغ آخراً". ٢,٥ استخدم أحزمة التحميل لمنع التلف المادي. ٣,٥ قم بتأمين أبواب المركبة من السرقة وأحوال الطقس. وأكد الشخص الذي له حق الوصول إلى المخزون. ٤,٥ تأكد من أن المسار يتيح وقتاً كافياً للراحة، والسلامة (تجنب القيادة ليلا والطرق السيئة). ٥,٥ ينبغي تأمين أي شحنة يستغرق توصيلها أكثر من يوم وفحصها بصرياً عند كل توقف بالليل وفي الصباح، مع توثيق ذلك بشكل مناسب.	▪ ينسق نقطة الاتصال في المخزون الطبي الإقليمي / المكتب الصحي للمقاطعة مع: ▪ البرنامج المجتمعي للأمراض المدارية المهملة ▪ السائقين ▪ موظفي تحميل الشاحنات	

المهمة	التعليمات	المسؤولية	المراجع
٦.	**تفريغ الشاحنات وتخزين الأدوية مؤقتاً أو تدميرها** ١,٦ عند الوصول، قم بتفريغ الشحنة وفقاً لجدول التوزيع، واتبع نهج ما تنتهي صلاحيته أولاً يصرف أولاً. ٢,٦ يقدم السائق القسيمة وبوليصة الشحن إلى المستلم على مستوى كل مقاطعة، مع تسجيل اسم السائق ولقبه وتوقيعه والتاريخ (اليوم / الشهر / السنة). ٣,٦ يقوم نقطة الاتصال في المقاطعة بفحص / عد علب الكرتون المغلقة وغير المغلقة، ويوقع على القسيمة المعدة. ٤,٦ ينبغي أن يتوفر على مستوى كل مقاطعة مخزن مخصص للأدوية إلى حين تنفيذ المعالجة الجموعية. ٥,٦ ينبغي توثيق أي مخزون تالف / انتهت صلاحيته وإزالته.	▪ نقطة الاتصال في المقاطعة بالتنسيق مع: ▪ نقطة الاتصال في المخزن الطبي الإقليمي ▪ السائقين ▪ موظفي تفريغ الشاحنات	انظر الفصل ٦: التخزين انظر الفصل ٧: ما تنتهي صلاحيته أولاً يصرف أولاً انظر الفصل ١٠: إدارة النفايات
٧.	**استلام المقاطعات للشحنة (الشحنات) والوثائق** ١,٧ إن كانت الوثائق غير كاملة أو مفقودة، ينبغي للمقاطعة عدم قبول الشحنة، اتصل بنقطة الاتصال في المخزن الطبي الاقليمي لتلقي المساعدة. ٢,٧ إن كانت الوثائق لا تتطابق مع الكميات المستلمة: ١,٢,٧ يُقبل التسليم ويُعد تقرير عن التباين في الكمية الموردة تُسجل فيه الكمية الناقصة أو الزائدة. وتُسلم نسخة من التقرير للسائق لتقديمها إلى نقطة الاتصال في المخزن الطبي الإقليمي. ٣,٧ في حالة زيادة الكمية الموردة، تُعاد الكمية الزائدة والفاتورة إلى السائق، وتُطلب فاتورة جديدة بالكمية المقبولة. ٤,٧ يُخطر نقطة الاتصال في البرنامج المجتمعي للأمراض المدارية المهملة، والمكتب الصحي في المقاطعة، باستلام الكميات على مستوى المقاطعة.	▪ نقطة الاتصال في المقاطعة بالتنسيق مع: ▪ نقطة الاتصال في المخزن الطبي الإقليمي ▪ السائقين	
٨.	**تأكيد التسليم** ١,٨ يتسلم السائق إيصال الاستلام الموقع ويودع نسخة منه لدى المخزن الطبي الإقليمي كمحضر تسليم مؤرخ (اليوم / الشهر / السنة)	▪ نقطة الاتصال في المقاطعة بالتنسيق مع: ▪ نقطة الاتصال في المخزن الطبي الإقليمي ▪ البرنامج المجتمعي للأمراض المدارية المهملة ▪ السائقين	

٣,٤ النقل من المقاطعات إلى نقاط تقديم الرعاية

(بما في ذلك النقل من المقاطعات بعد المعالجة الجموعية إلى المستوى الإقليمي / المركزي لغرض التخزين النهائي أو التدمير)

متى	من	ماذا	كيف
بناءً على طلب من مستوى المقاطعة (عادة قبل ٢ – ٤ أسابيع من المعالجة الجموعية) بعد المعالجة الجموعية أو بعد تقييم حالة أمراض معينة إذا أُعيدت المخزونات إلى المستوى المركزي / الإقليمي أو لغرض التدمير	▪ المنظمة / المرسل إليه ▪ البرنامج المجتمعي للأمراض المدارية المهملة ▪ المكتب الصحي للمقاطعة ▪ الشركاء المنفذون (في حالة تكاليف الدعم) ▪ المخزن الطبي الإقليمي ▪ السائقون ▪ موظفو تعبئة / تفريغ الشاحنات مستوى السلطة المطلوبة: ▪ سلطة التوقيع لتخصيص كميات محددة من الأدوية للمقاطعات / نقاط التوزيع ▪ سلطة التوقيع لإزالة الأدوية، إما لصرفها لمواقع ميدانية أو لتدميرها	▪ نقل الأدوية و / أو مواد التشخيص المتبرع بها / المشتراة ▪ تخصيص وإرسال الكميات الصحيحة من الأدوية و / أو مواد التشخيص إلى نقاط التوزيع على مستوى المقاطعة	١. التحضير لنقل الشحنة من المستوى الإقليمي أو مستوى المقاطعة، أو بعد المعالجة الجموعية إلى التخزين الطويل الأجل و / أو تدمير النفايات. ٢. تجهيز علب الكرتون / الصناديق لكل نقطة توزيع ٣. إعداد قسيمة صرف / استلام لكل مخزن طبي إقليمي لإجمالي علب الكرتون المرسلة لكل وجهة ٤. فحص وعد علب الكرتون المغلقة / حصر عدد الزجاجات في علب الكرتون المفتوحة ٥. تعبئة الشاحنات / تفريغ الشاحنات ٦. التخزين المؤقت أو التدمير ٧. استلام المقاطعات للشحنة (الشحنات) والوثائق ٨. تأكيد التسليم

المهمة	التعليمات	المسؤولية	المراجع
١.	**التحضير لنقل الشحنة من المستوى الإقليمي أو مستوى المقاطعة، أو بعد المعالجة الجموعية لغرض التخزين الطويل الأجل و/ أو تدمير النفايات** ١,١ توفير معلومات عن نقطة الاتصال المعنية بالتوزيع في البرنامج المجتمعي للأمراض المدارية المهملة ومعلومات الاتصال الخاصة بالمنفذين (إن لزم الأمر) ٢,١ الاتصال بالبرنامج المجتمعي للأمراض المدارية المهملة والتحقق بانتظام من الموعد المقرر لوصول الأدوية إلى نقاط التوزيع ٣,١ التأكد من أن مستودع المقاطعة على علم بالتسليم المقرر ومن توافر مساحة به. ٤,١ وضع جدول بالكميات والتوزيع بالتنسيق مع البرنامج المجتمعي للأمراض المدارية المهملة، لضمان النقل الآمن والفعال؛ وإطلاع المخزن الطبي الإقليمي، ونقطة الاتصال على مستوى المقاطعة، على هذا الجدول. ١,٤,١ ينبغي أن يتضمن هذا الجدول أوقات السفر التقريبية لكل عملية تسليم في المقاطعات، مع مراعاة أوقات التوقف المناسبة لأخذ قسط من الراحة، وتجنب القيادة ليلاً والطرق السيئة. ٥,١ الحصول على الموافقة اللازمة من منسق برنامج الأمراض المدارية المهملة في المقاطعة أو المكتب الصحي في المقاطعة على خطة التوزيع وميزانية النقل. ١,٥,١ النظر في تزويد السائقين بباقات تواصل متنقلة للإبلاغ عن الحوادث التي تقع على الطرق؛ فإن لم يكن لدى السائقين هواتف محمولة، يُنظر في تزويدهم بهواتف مؤقتة مزودة بآلات تصوير. ٢,٥,١ تأكد من دفع أجر السائق لإعادة النماذج الموقعة إلى المخزن الطبي الإقليمي أو المخزن الطبي للولاية لتأكيد التسليم. ٦,١ تأكد من أن مركبات النقل تفي بالمعايير المقبولة لنقل الأدوية (مثلاً، حالة العمل والتغطية المناسبة للحماية من أحوال الطقس). ٧,١ حدد العدد الكلي من علب الكرتون / الصناديق التي ستُسلم إلى كل نقطة توزيع. ٨,١ تأكد من إعداد القسائم للمرسل إليه على مستوى المقاطعة. ٩,١ تأكد من ترتيب النقل إلى المقاطعات في الموعد المحدد أو المواعيد المحددة. فإن كانت الشاحنات غير متاحة للاستخدام من جانب المخزن الطبي الإقليمي، كيف ستُوفر وسيلة النقل؟ ١٠,١ تأكد من توافر موظفين لتعبئة وتفريغ الشاحنات ١١,١ اتخذ إجراءات تأمين النقل من السرقة أو الأحوال الجوية أو المخاطر الأخرى. ١٢,١ حدّد / أكد الشخص الذي له حق الوصول إلى المخزون أثناء النقل (إن كان مغلقاً عليه في الشاحنة).	▪ ينسق نقطة الاتصال في المخزن الطبي الإقليمي / المكتب الصحي للمقاطعة مع: ▪ البرنامج المجتمعي للأمراض المدارية المهملة ▪ الشركاء المنفذين ▪ السائقين ▪ موظفي تعبئة / تفريغ الشاحنات	انظر الفصل ٦: التخزين انظر الفصل ١١: التنبؤ والتقدير الكمي
٢.	**تجهيز علب الكرتون / الصناديق لكل نقطة توزيع** ١,٢ تعبئة علب الكرتون بالمخزون على أساس الكمية اللازمة لكل مقاطعة، المحددة في جدول التوزيع. ٢,٢ املأ فراغات علب الكرتون بمواد التعبئة لتجنب تلف الأدوية. ٣,٢ ضع، إن أمكن، بطاقة على كل كرتونة يُدون عليها اسم المقاطعة المقصودة لغرض التحقق المزدوج. ٤,٢ تأكد من تعبئة المخزون الأقدم والسابق الفتح أولاً. ٥,٢ ينبغي توثيق وإزالة أي مخزون تالف أو انتهت صلاحيته.	▪ ينسق نقطة الاتصال في المخزن الطبي الإقليمي / المكتب الصحي للمقاطعة مع: ▪ البرنامج المجتمعي للأمراض المدارية المهملة	انظر الفصل ٧: ما تنتهي صلاحيته أولاً يصرف أولاً. انظر الفصل ١٠: إدارة النفايات
٣.	**إعداد قسيمة صرف استلام لكل مخزن طبي إقليمي إجمالي علب الكرتون المرسلة لكل وجهة** ١,٣ حدد بوضوح عدد الزجاجات من كل نوع دواء ستُرسل لكل مقاطعة	▪ ينسق المخزن الطبي الإقليمي / المكتب الصحي للمقاطعة مع: ▪ البرنامج المجتمعي للأمراض المدارية المهملة ▪ السائقين	

المهمة	التعليمات	المسؤولية	المراجع
٤.	**فحص / حصر علب الكرتون المغلقة وحصر عدد الزجاجات في علب الكرتون المفتوحة** ١,٤ تأكد من وجود كشوف الإحصاء أو نماذج إدارة المخزون المناسبة الأخرى قبل التحميل على الشاحنات. ٢,٤ يؤكد المخزن الطبي الإقليمي والسائق العدد بالمقارنة مع القسائم المعدة وبوليصة الشحن ويوقعان عليهما.	▪ ينسق نقطة الاتصال في المخزن الطبي الإقليمي / المكتب الصحي للمقاطعة مع: ▪ البرنامج المجتمعي للأمراض المدارية المهملة ▪ السائقين	انظر الفصل ٥: إدارة المخزون
٥.	**التحميل على الشاحنات** ١,٥ قم بتحميل الشاحنات بشكل منهجي، باتباع نهج "ما يُحمَّل أولاً يُفرغ آخراً". ٢,٥ استخدم أحزمة التحميل لمنع التلف المادي. ٣,٥ قم بتأمين أبواب المركبة من السرقة وأحوال الطقس. وأكد الشخص الذي له حق الوصول إلى المخزون. ٤,٥ تأكد من أن المسار يتيح وقتاً كافياً للراحة، مع توخي السلامة (تجنب القيادة ليلاً والطرق السيئة). ٥,٥ ينبغي تأمين أي شحنة يستغرق توصيلها أكثر من يوم، وفحصها بصرياً عند كل توقف بالليل وفي الصباح، مع توثيق ذلك بشكل مناسب.	▪ ينسق منظمة الاتصال في المخزن الطبي الإقليمي / المكتب الصحي في المقاطعة مع: ▪ البرنامج المجتمعي للأمراض المدارية المهملة ▪ السائقين ▪ موظفي تحميل الشاحنات	
٦.	**تفريغ الشاحنات وتخزين الأدوية مؤقتاً أو تدميرها** ١,٦ عند الوصول، قم بتفريغ الشحنة وفقاً لجدول التوزيع، واتبع نهج ما يدخل أولاً يصرف أولاً. ٢,٦ يقدم السائق القسيمة وبوليصة الشحن إلى المستلم على مستوى كل مقاطعة، مع تسجيل اسم السائق ولقبه وتوقيعه والتاريخ (اليوم / الشهر / السنة) ٣,٦ يقوم نقطة الاتصال في المقاطعة بفحص / عد علب الكرتون المغلقة وغير المغلقة والتوقيع على القسيمة المعدة. ٤,٦ ينبغي أن يتوفر على مستوى كل مقاطعة مخزن مخصص للأدوية إلى حين تنفيذ المعالجة الجموعية. ٥,٦ ينبغي توثيق أي مخزون تالف / انتهت صلاحيته وإزالته.	▪ نقطة الاتصال في المقاطعة بالتنسيق مع: ▪ نقطة الاتصال في المخزن الطبي الإقليمي ▪ السائقين ▪ موظفي تفريغ الشاحنات	انظر الفصل ٦: التخزين انظر الفصل ٧: ما تنتهي صلاحيته أولاً يصرف أولاً انظر الفصل ١٠: إدارة النفايات
٧.	**استلام المقاطعات للشحنة (الشحنات) والوثائق** ١,٧ إن كانت الوثائق غير كاملة أو مفقودة، ينبغي للمقاطعة عدم قبول الشحنة؛ اتصل بنقطة الاتصال في المخزن الطبي الإقليمي لتلقي المساعدة. ٢,٧ إن كانت الوثائق لا تتطابق مع الكميات الواردة: ١,٢,٧ قبول التسليم وإعداد تقرير عن التباين في الكمية الموردة تُسجل فيه الكمية الناقصة أو الزائدة الموردة. تُسلم نسخة للسائق لتقديمها إلى نقطة الاتصال في المخزن الطبي الإقليمي. ٣,٧ في حالة ورود كمية زائدة، تُعاد الكمية الزائدة والفاتورة إلى السائق، وتُطلب فاتورة جديدة بالكمية المقبولة. ٤,٧ يُخطر نقطة الاتصال في البرنامج المجتمعي للأمراض المدارية المهملة والمكتب الصحي للمقاطعة باستلام الكميات على مستوى المقاطعة.	▪ نقطة الاتصال في المقاطعة بالتنسيق مع: ▪ نقطة الاتصال في المخزن الطبي الإقليمي ▪ السائقين	
٨.	**تأكيد التسليم** ١,٨ يتسلم السائق إيصال الاستلام الموقع ويودع نسخة منه لدى المخزن الطبي الإقليمي كمحضر تسليم مؤرخ (اليوم / الشهر / السنة).	▪ نقطة الاتصال في المقاطعة بالتنسيق مع: ▪ نقطة الاتصال في المخزن الطبي الإقليمي ▪ البرنامج المجتمعي لبرنامج الأمراض المدارية المهملة ▪ السائقين	

٥. إدارة المخزون

١,٥ الغرض من إجراء التشغيل الموحد هذا ونطاقه

الغرض من إدارة مخزونات أدوية الأمراض المدارية المهملة هو:

- تقليل التكلفة الإجمالية للمخزون عن طريق الموازنة بين تكاليف حيازة المخزون وطلبه؛
- ضمان سهولة توافر معلومات عن مستويات المخزون في النظام الصحي في جميع المواقع؛
- تيسير توافر مخزون كافٍ لتوزيعه على السكان المتضررين؛
- تجنب نفاد المخزون؛
- ضمان حفظ السجلات بشكل سليم؛
- تقليل الخسائر والأضرار وسوء الاستخدام إلى أقل حد؛
- ضمان المساءلة أمام الجهات المانحة للأدوية.

وتُنفذ عملية إدارة المخزون عند استلام المخزون أو تخزينه أو نقله أو عند اقتراب انتهاء صلاحيته أو التخلص منه. وتشمل إدارة المخزون فحصه المادي وحصره والاحتفاظ بسجلات له.

٢,٥ الاعتبارات الرئيسية

تتعلق المهام والمسؤوليات التي ينطوي عليها هذا الإجراء بما يلي:

- البرنامج الوطني لمكافحة الأمراض المدارية المهملة؛
- موظفي سلسلة الإمداد والمستودعات / المخازن والصيدليات على جميع مستويات النظام الصحي؛
- موظفي الاتصال المعنيين بالأمراض المدارية المهملة والمشرفين على موزعي الأدوية على المدارس والمجتمع. والوظائف المحددة، وأدوارها، والخطوات التي يجب اتخاذها في هذا الإجراء هي أمثلة توضيحية وينبغي تعديلها بما يناسب السياق السائد في كل بلد.

وينبغي للبرنامج الوطني لمكافحة الأمراض المدارية المهملة:

- التواصل بانتظام مع جميع المواقع التي تُخزن بها الأدوية المتبرع بها، من أجل تحديث المعلومات المتعلقة بالمخزون؛
- تشجيع المواقع على إجراء عملياتها الخاصة لجرد الأدوية المتبرع بها، إلى جانب السلع الصحية الأخرى، وعلى إنشاء نظم إنذار بالمخزون الذي أوشك على انتهاء صلاحيته؛
- إبلاغ نتائج الجرد المادي إلى جميع الجهات صاحبة المصلحة، بما في ذلك الشركاء المنفذون، أو إدارة سلسلة الإمداد الوطنية، أو منظمة الصحة العالمية، أو الجهات المتبرعة بالأدوية، أو أي جهة فاعلة أخرى مشاركة في إعطاء المعالجة الجموعية.

٣,٥ إجراء التشغيل الموحد

١,٣,٥ قبل وأثناء المعالجة الجموعية

متى	من	ماذا	كيف
▪ كلما تم استلام مخزون أو تخزينه أو صرفه أو نقله، أو اقترب تاريخ انتهاء صلاحيته أو التخلص منه. ▪ قبل المعالجة الجموعية	الأشخاص المسؤولون عن إدارة المخازن على كل مستوى في النظام الصحي، بمن فيهم: ▪ مدير سلسلة الإمداد ▪ الصيدلي ▪ فني الصيدلة ▪ مشرف المستودع أو المخازن ▪ موظفو برنامج مكافحة الأمراض المدارية المهملة ▪ الناقل ▪ منسق برنامج الأمراض المدارية المهملة ▪ وزارة الصحة	الفحص المادي والحصر وحفظ سجلات المخزون	▪ فحص وحصر المخزون الوارد ▪ تخزين الأدوية المتبرع بها بشكل منفصل ▪ اتبع الإجراء الوارد في الفصل ٧: ما تنتهي صلاحيته أولاً يصرف أولاً ▪ استخدم نماذج النقل لتسجيل حركات المخزون (انظر **الملحق** ٤ للاطلاع على النموذج)

المهمة	التعليمات	المسؤولية	المراجع
١.	**استلام الأدوية المتبرع بها** ١,١ قبل استلام المخزون، تأكد من وجود مساحة كافية للتخزين وانظر في التخزين على الأرفف. ٢,١ تأكد من أن المكان نظيف وفارغ ومجهز لاستقبال وتخزين الشحنة. ٣,١ قم بفحص وحصر المخزون الوارد، وتحديث بطاقة المخزون ونظام المعلومات الالكتروني لإدارة اللوجستيات بناءً على ذلك (حيثما يُستخدم هذا النظام). ٤,١ قم بفحص المخزون لاستكشاف أي تلف وتأكد من تواريخ انتهاء الصلاحية. ٥,١ إن لزم الأمر، اتبع الإجراء المناسب بشأن المخزون التالف و/ أو الذي انتهت صلاحيته. ٦,١ استكمل نموذج التحويل بعد استلام المخزون على كل مستوى. وينبغي توقيع هذا النموذج وتأريخه وإعادة نسخة منه إلى موقع المنشأ.	▪ مدير سلسلة الإمداد ▪ الصيدلي أو الفني ▪ مشرف المستودع أو المخازن ▪ منسق برنامج الأمراض المدارية المهملة ▪ الناقل (السائق)	انظر الفصل ٣: التخليص الجمركي انظر الفصل ٤: النقل انظر الفصل ٦: التخزين انظر الفصل ٧: ما تنتهي صلاحيته أولاً يصرف أولاً انظر الفصل ٨: الدورة العكسية للخدمات اللوجستية انظر الفصل ٩: إزالة الأدوية المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستعمال انظر الفصل ١٠: إدارة النفايات
٢.	**التخزين** ١,٢ الفصل المادي بين الأدوية المتبرع بها والأدوية المشتراة على المستوى الوطني. ٢,٢ إنشاء بطاقة مخزون خاصة ورمز خاص للمخزون في نظام المعلومات الالكتروني لإدارة اللوجستيات (حيثما يكون هذا النظام مستخدماً) لضمان إمكانية تمييز الأدوية المتبرع بها عن الأدوية المشتراة وطنياً. ٣,٢ تُرفق بطاقة مخزون مستقلة بكل كومة أدوية في المستودع / المخازن.	▪ مدير سلسلة الإمداد ▪ الصيدلي أو الفني ▪ مشرف المستودع أو المخازن	انظر الفصل ٦: التخزين انظر الفصل ٧: ما تنتهي صلاحيته أولاً يصرف أولاً انظر الفصل ٨: الدورة العكسية للخدمات اللوجستية

المهمة	التعليمات	المسؤولية	المراجع
٣.	**الصرف.** ١,٣ اتبع سياسة ما تنتهي صلاحيته أولاً يصرف أولاً، على جميع المستويات. ٢,٣ افتح كرتونة واحدة في الوقت ذاته لصرف الزجاجات على المستوى المجتمعي. ٣,٣ لا تفصل علب الكرتون إلى زجاجات منفردة إلا عند صرفها لموزعي الأدوية في المدارس والمجتمع. ٤,٣ حدّث بطاقة المخزون فور صرف الأدوية (أي حفظ السجلات)	▪ مدير سلسلة الإمداد ▪ الصيدلي أو الفني ▪ مشرف المستودع أو المخازن ▪ الناقل (السائق) ▪ منسق برنامج الأمراض المدارية المهملة	انظر الفصل ٤: النقل انظر الفصل ٧: ما تنتهي صلاحيته أولاً يصرف أولاً
٤.	**النقل (التحويل)** ١,٤ ينبغي استخدام نموذج التحويل عند صرف الأدوية المتبرع بها، من مخزن إلى آخر أو إلى أفرقة توزيع الأدوية على المدارس أو المجتمع. ٢,٤ في حالة عدم وجود نظام معلومات الكتروني لإدارة اللوجستيات، ينبغي استخدام نسختين من النموذج لتسجيل كل معاملة: ▪ تُرسل نسخة إلى الوجهة المقصودة مع الناقل (أي الشخص المسؤول عن النقل)؛ ▪ يُحتفظ بنسخة في موقع المنشأ لغرض حفظ السجلات. ▪ ينبغي أن يكون للنسختين نفس الرقم التسلسلي. ٣,٤ يُسجل في الجزء الأول من النموذج كلّ من المنشأ والوجهة واسم الشخص الناقل للشحنة، إلى جانب الكمية المنصرفة. ٤,٤ ينبغي استكمال هذا الجزء في موقع المنشأ وأن يُوقع من كل من الناقل والشخص الذي قام بالصرف. ٥,٤ ينبغي استكمال الجزء الثاني من النموذج في الوجهة وأن يُوقع عليه من كل من الناقل والمستلم. ٦,٤ ينبغي تسجيل أي كمية تالفة من الشحنة في النموذج وإخطار الموظف المعني بذلك، بمن فيهم موظف برنامج الأمراض المدارية المهملة. ٧,٤ اتبع الإجراءات ذات الصلة لإزالة الأدوية المنتهية الصلاحية أو غير الصالحة للاستعمال (الفصل ٩) وإدارة النفايات (الفصل ١٠). ٨,٤ ينبغي لجميع مستويات النظام الصحي، بمن فيهم أفرقة توزيع الأدوية على المدارس والمجتمع، استخدام نفس النموذج عند استلام الأدوية. ٩,٤ ينبغي الاحتفاظ بنماذج التحويل بأمان في الملف طوال الفترة الزمنية التي تحددها وزارة الصحة / الجهة المانحة.	▪ مدير سلسلة الإمداد ▪ مشرف المستودع أو المخازن ▪ الناقل (السائق) ▪ منسق برنامج الأمراض المدارية المهملة ▪ نقطة الاتصال في المدارس أو مركز التوزيع ▪ الموظف الصحي في المقاطعة	انظر الفصل ٤: النقل انظر الفصل ٧: ما تنتهي صلاحيته أولاً يصرف أولاً الملحق ٤: نموذج تحويل المخزون انظر الفصل ٨: الدورة العكسية للخدمات اللوجستية انظر الفصل ٩: إزالة الأدوية المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستعمال انظر الفصل ١٠: إدارة النفايات

٢,٣,٥ بعد المعالجة الجموعية

متى	من	ماذا	كيف
▪ بعد كل معالجة جموعية ▪ قبل تقديم طلب للحصول على شحنة جديدة. مثلاً، قبيل تقديم حزمة الطلبات المشتركة السنوية / نموذج رصد التخلص من التراخوما. ▪ كلما أُجري جرد مادي منتظم للسلع الصحية الأخرى. ▪ في أي وقت عند تلقي تنبيه بحدوث تلف و / أو فقدان و / أو سرقة. ▪ عند طلب ذلك من جانب المتبرع.	الأشخاص المسؤولون عن إدارة المخازن في أي مستوى من مستويات النظام الصحي، بمن فيهم: ▪ مدير سلسلة الإمداد، ▪ الصيدلي، ▪ فني الصيدلة، ▪ مشرف المستودع أو المخازن، ▪ موظفو برنامج الأمراض المدارية المهملة، ▪ الناقل	١. التخطيط ٢. التنظيم ٣. الحصر ٤. إعادة التنظيم ٥. التحديث ٦. اتخاذ إجراء	▪ تحقق من المخزون المادي الفعلي بالمقارنة مع أرصدة بطاقات المخزون. ▪ حدد كميات المخزون القابل للاستعمال بغرض توزيعه. ▪ اكتشف وافصل المخزون التالف و / أو المنتهي الصلاحية.

المهمة	التعليمات	المسؤولية	المراجع
١.	**تخطيط جرد المخزون** ١,١ حدد تواريخ ومواعيد معينة لإجراء جرد المخزون. على الأقل قبل وبعد كل معالجة جموعية، وكلما أُجري جرد عادي للمخزون من السلع الصحية الأخرى في موقع التخزين. ٢,١ تجنب أوقات الانشغال، حيث يجب وقف عملية استلام وصرف المخزون طوال عملية الجرد. ٣,١ حدد شخصين على الأقل (حيثما أمكن) لإجراء الحصر والمطابقة. ٤,١ تأكد من عدم وجود تضارب في المصالح. مثلاً، لا ينبغي للشخص المسؤول عن المخزن المشاركة في الجرد لكن ينبغي أن يتواجد في الموقع لعرض المخزونات.	▪ مدير سلسلة الإمداد ▪ مشرف المستودع أو المخازن	انظر الفصل ٦: التخزين انظر الفصل ٧: ما تنتهي صلاحيته أولاً يُصرف أولاً انظر الفصل ٨: الدورة العكسية للخدمات اللوجستية
٢.	**تنظيم المخزون** ١,٢ قم بتجميع الزجاجات بحسب تاريخ انتهاء صلاحيتها. ٢,٢ رتب الأدوية بحسب تاريخ انتهاء صلاحيتها، بحيث تكون الأدوية الأقدم في المقدمة والأحدث في الخلف. ٣,٢ ينبغي فصل الزجاجات المفتوحة عن المغلقة. ▪ أية محاليل فموية معاد تركيبها (مثل محلول أزيثروميسين الفموي الخاص بالأطفال) ينبغي عدم حفظها في المخزون بل التخلص منها فوراً ▪ أي أقراص قابلة للمضغ (مثل ميبيندازول) يكون لها فور فتح العبوة عمر تخزيني من شهر إلى شهرين، ولذلك لا ينبغي تخزينها لدورة المعالجة الجموعية التالية. ٤,٢ تُفصل الأدوية التالفة و / أو المنتهية الصلاحية عن المخزون القابل للاستعمال. اتبع إجراءات إزالة الأدوية المنتهية الصلاحية وغير القابلة للاستعمال (الفصل ٩) وإدارة النفايات (الفصل ١٠)	▪ مدير سلسلة الإمداد ▪ مشرف المستودع أو المخزن	انظر الفصل ٦: التخزين انظر الفصل ٧: ما تنتهي صلاحيته أولاً يُصرف أولاً انظر الفصل ٨: الدورة العكسية للخدمات اللوجستية انظر الفصل ٩: إزالة الأدوية المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستعمال انظر الفصل ١٠: إدارة النفايات
٣.	**عد المخزون** ١,٣ يقوم شخص بالعد بينما يقوم الشخص الآخر بالتسجيل. ٢,٣ استخدم قلماً بلون مختلف لتمييز كميات المخزون الفعلي على بطاقة المخزون. ٣,٣ قم بالعد في موقع واحد في المرة الواحدة وسجّل المخزون بشكل منفصل بحسب المجموعات المتماثلة في انتهاء الصلاحية. ٤,٣ قم بعد الزجاجات بحسب المجموعات المتماثلة في انتهاء الصلاحية. ٥,٣ سجّل بوضوح تاريخ انتهاء الصلاحية، بأرقام كبيرة وداكنة على واجهة كل كرتونة. افصل أية أدوية تالفة أو منتهية الصلاحية، وسجّل كمية هذه الأدوية في عمود الفاقد / التعديلات على بطاقة المخزون، وقدّم توضيحاً موجزاً لانتهاء الصلاحية أو التلف. ٦,٣ قم بعد الكرتونات المغلقة / الكاملة أولاً، ثم اضرب هذا العدد في عدد الزجاجات في كل كرتونة؛ وبذلك تحصل على العدد الكلي للزجاجات. ٧,٣ قم بعد الزجاجات غير المفتوحة في الكرتونات المفتوحة. ٨,٣ قم بعد الزجاجات المفتوحة واقسم العدد الكلي على اثنين؛ وبذلك تحصل على العدد المكافئ المقدر للزجاجات الكاملة. ٩,٣ لا تمزج أو تدمج الزجاجات المفتوحة في زجاجة واحدة. ١٠,٣ سجّل ما يلي على نموذج جرد المخزون (النموذج المقدم من الجهة المانحة): ▪ كمية الزجاجات المفتوحة ▪ كمية الزجاجات غير المفتوحة ▪ المنتجات المنتهية الصلاحية و / أو التالفة ١١,٣ سجّل الكميات بأقل وحدة قياس، لا بعدد الزجاجات ١٢,٣ احصل على توقيع الصيدلي / فني الصيدلة أو الموظف المعني الآخر على تقرير جرد المخزون النهائي. ١٣,٣ أعد نظام تنبيه بتواريخ انتهاء صلاحية المخزون المتاح؛ وينبغي لهذا النظام إصدار تنبيه قبل ستة أشهر وثلاثة أشهر و ٣٠ يوماً. ١٤,٣ أبلغ مدير برنامج الأمراض المدارية المهملة، عبر الرسائل القصيرة، بتنبيهات انتهاء صلاحية المخزون، من حيث صلاحية الأدوية ونفاد الكميات.	▪ مدير سلسلة الإمداد ▪ مشرف المستودع أو المخازن ▪ مدير برنامج الأمراض المدارية المهملة	انظر الفصل ٦: التخزين انظر الفصل ٧: ما تنتهي صلاحيته أولاً يُصرف أولاً انظر الفصل ٩: إزالة الأدوية المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستعمال

المهمة	التعليمات	المسؤولية	المراجع
٤.	**إعادة تنظيم المخزون** ١,٤ أعد تنظيم المخزون بحسب تواريخ انتهاء الصلاحية مع الالتزام بسياسة ما تنتهي صلاحيته أولاً يُصرف أولاً. ٢,٤ إن كان المخزون المفتوح مسموحاً باستخدامه، تأكد من صرفه أولاً في حملة المعالجة الجموعية التالية ٣,٤ أكمل العملية بأسرع ما يمكن للسماح باستئناف العمليات العادية.	▪ مدير سلسلة الإمداد ▪ مشرف المستودع أو المخازن	انظر الفصل ٦: التخزين انظر الفصل ٧: ما تنتهي صلاحيته أولاً يُصرف أولاً
٥.	**تحديث بطاقة المخزون** ١,٥ بمجرد انتهاء العد، قم بمطابقة العدد الكلي للزجاجات التي تم حصرها مع الكميات المسجلة في بطاقة المخزون. ٢,٥ استخدم قلماً بلون مختلف لتمييز كمية المخزون الذي تم جرده على بطاقة المخزون. ٣,٥ إن لوحظت اختلافات، أضف أو اطرح عدد الزجاجات المسجل على بطاقة المخزون تحت عمود الفاقد / التعديلات. سجل بوضوح التاريخ والفرق في الكمية واكتب عبارة "جرد المخزون". ٤,٥ احفظ سجلات لجميع بطاقات مخزون الأدوية المتبرع بها. ٥,٥ قم بنقل بطاقات المخزون الأقدم من سنتين إلى البرنامج الوطني للأمراض المدارية المهملة.	▪ مدير سلسلة الإمداد ▪ مشرف المستودع أو المخازن	**الملحق** ٥: نموذج بطاقة المخزون **الملحق** ٦: نموذج استمارة جرد المخزون انظر الفصل ٩: إزالة الأدوية المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستعمال
٦.	**الإجراء** ١,٦ تبادل تقارير جرد الأدوية المتبرع بها مع البرنامج الوطني للأمراض المدارية المهملة وإدارة سلسلة الإمداد الوطنية، عند الاقتضاء. فإن كان المخزون الفعلي يختلف عن رصيد بطاقة المخزون، أبلغ عن أسباب الاختلاف. ٢,٦ أدرج الإجراءات الناتجة عن جرد المخزون في تخطيط الميزانية. وقد يشمل ذلك الدورة العكسية للخدمات اللوجستية وإدارة النفايات	▪ مدير سلسلة الإمداد ▪ مشرف المستودع أو المخازن ▪ مدير برنامج الأمراض المدارية المهملة	انظر الفصل ٨: الدورة العكسية للخدمات اللوجستية انظر الفصل ٩: إزالة الأدوية المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستعمال انظر الفصل ١٠: إدارة النفايات

٦. التخزين

١,٦ الغرض من إجراء التشغيل الموحد هذا ونطاقه

يضمن التخزين السليم سلامة الأدوية وجودتها العالية حتى وقت توزيعها على فئات السكان المعرضين للخطر في إطار المعالجة الجموعية. ويجب مراعاة الإجراء الذي يكفل ظروف التخزين المناسبة، بما في ذلك رصد ظروف التخزين المحيطة من أجل الحفاظ على جودة الأدوية إلى حين خروجها من المخزن أو المستودع. وتشمل الأهداف الرئيسية للتخزين السليم ما يلي:

- استلام شحنات الأدوية و/ أو مواد التشخيص المتبرع بها / المشتراة؛
- التخزين الآمن للأدوية و / أو مواد التشخيص إلى حين طلبها من قِبَل أفرقة التوزيع الميدانية؛
- تخصيص الكميات الصحيحة من الأدوية و/ أو مواد التشخيص لنقاط التوزيع وتوزيعها عليها؛
- استلام الأدوية و / أو مواد التشخيص الصالحة للاستعمال المتبقية بعد المعالجة الجموعية لتكون بمثابة مستودع أو لغرض تقييم أمراض معينة.

٢,٦ الاعتبارات الرئيسية

ينبغي إقامة علاقة قوية بين المخزن الطبي المركزي أو الإقليمي وبرنامج الأمراض المدارية المهملة من أجل الإدارة والعمليات والتوثيق والاتصال. ولتقدير المساحة بالأمتار المكعبة المطلوبة للكميات المختلفة من الأدوية، يُرجى الاطلاع على **الجدول ١,٦**.

الإدارة

- حق امتياز مملوك للحكومة أو للقطاع الخاص.
- مستوى المستودع، مركزي أو إقليمي أو على مستوى المقاطعة أو دون المقاطعة.
- شروط الوصول والأمن والسلامة للمخزن / المستودع.

العمليات

- إجراءات ونظام تخزين مناسبة.
- تواتر الفحص البصري والجرد المادي.
- تنفيذ وتواتر أخذ عينات ضمان جودة الدفعات، حيثما كان ذلك متاحاً.

الجدول ١,٦ ملخص المعلومات اللوجستية للأدوية المتبرع بها لغرض العلاج الكيميائي الوقائي

الدواء	عدد الأقراص / زجاجة	عدد الأقراص / شاحن لكل شحنة (كرتونة)	عدد الشاحنين / الواح التحميل	عدد الأقراص / الواح التحميل	مقاس لوح التحميل / العرض / الطول (سم)	ارتفاع لوح التحميل (سم)	الوزن الصافي للوح التحميل (كغم)	الوزن الكلي للوح التحميل (كغم)
ألبيندازول (أقراص ٤٠٠ مغم)	٢٠٠	٢٠٠ × ٣٠ زجاجة (٦٠٠٠ قرص)	٥٢	٣١٢ ٠٠٠	١٠٠ x ١٢٠	١٢٠	٣٩٢	٤١٠
ميبيندازول (أقراص ٥٠٠ مغم)	١٥٠	١٥٠ × ٢٠ زجاجة (٣٠٠٠ قرص)	١٣٥	٤٠٥ ٠٠٠	٨٠ x ١٢٠	١١٥		٣٨١
برازيكوانتيل (أقراص ٦٠٠ مغم)	١٠٠٠	١٠٠٠ × ٩ زجاجات (٩٠٠٠ قرص)	٣٠	٢٧٠ ٠٠٠	٨١ x ١٢١	١٢٢	٤٢٦	٤٢٩
سترات ثنائي ايثيل كاربامازين (أقراص ١٠٠ مغم)	١٠٠٠	١٠٠٠ × ١٢ زجاجة (١٢٠٠٠ قرص) [أ]	٨٤	١ ٠٠٨ ٠٠٠	الأدنى ١١٠ x ١١٠ الأقصى ١٢٠ x ١٢٠	١٢٧	٣٢٢	٣٤٠–٣٥٠
إيفرمكتين (أقراص ٣ مغم)	٥٠٠	٥٠٠ × ٩٦ زجاجة لجميع الشاحنين	[ب]٢٥	[ج]١ ١٩٥ ٠٠٠	١٠٠ x ١٢٠	١١٥	١٢٧,٩	١٥٣
تريكلابيندازول (أقراص ٢٥٠ مغم)	٤	١٢٠٠ قرص (٣٢٠ صندوق ورقي؛ ٤ أقراص / صندوق)	١٨	٢١ ٦٠٠	٨٠ x ١٢٠	٨٩	٨٨	١٢١ ~
أزيثروميسين (أقراص ٥٠٠ مغم) للداء العليقي	٣	٣ أقراص × ٦٠ عبوة	١٣٢	٢٣ ٧٦٠	٨٠ x ١٢٠	١٦٠	١٣٨	١٤٤
برازيكوانتيل (أقراص ٦٠٠ مغم) من شركة Bayer	١٠٠٠	(١٠٠٠ × ١٠) / صندوق كرتون	٢١	٢١٠ ٠٠٠	٨٠ x ١٢٠	١٠٣	٤٠٠ ~	
نيكلوزاميد (أقراص ٤٠٠ مغم)	٤	٧٢٠ قرصاً / شاحن (٤ × ١٥ × ١٨٠)	٣٢	٢٣ ٠٤٠	٨٠ x ١٢٠	٩٨٥	٧٥	٩٠
أزيثروميسين (أقراص ٢٥٠ مغم) للتراخوما	٥٠٠	٥٠٠ × ٢٤ (١٢٠٠٠ قرص)	٥٤	٦٤٨ ٠٠٠	١٠٠ x ١٢٠	٨٠	٣٥٩	٣٧٩

[أ] صندوق كرتون للشحن (يحتوي على ١٠٠٠ قرص / زجاجة × ١٢ زجاجة) أبعاده ٣٢ سم طولاً × ٢٥ سم عرضاً × ١٦ سم ارتفاعاً، وزنه ٣,٣٦ كغم.

[ب] ٢٥ كرتونة (عادة ٢٤ كرتونة كاملة بكل منها ٩٦ زجاجة؛ يمكن أن تكون الكرتونة الأخيرة غير مكتملة، في هذه الحالة ٨٦ زجاجة).

[ج] بافتراض ٢٣٩٠ وحدة = ١١٩٥٠٠٠ قرص هي أكبر لوح تحميل.

- ظروف التخزين المناسبة، والمراقبة والرصد، بما في ذلك:
  - نظام تبريد؛
  - صيانة مصدر الطاقة؛
  - هيكل للتخزين؛
  - سجل يومي للظروف.
- إدارة / تخزين اللوازم الأخرى للأمراض المدارية المهملة.
- بروتوكول تشغيل المخزن، ويشمل:
  - ما تنتهي صلاحيته أولاً يُصرف أولاً؛
  - منع وإدارة النفايات / التلف.

التوثيق والاتصالات

- تكييف النماذج والسجلات بما يلائم الاحتياجات، واستخدامها بشكل صحيح.
- عمليات توثيق الاستلام / الإزالة.
- البروتوكول المناسب للتوثيق.
- نظام المعلومات الإلكتروني لإدارة اللوجستيات، وإجراءات الاتصال.

٣,٦ إجراء التشغيل الموحد

الوظائف المحددة، وأدوارها، والخطوات التي يجب اتخاذها في هذا الإجراء هي أمثلة توضيحية وينبغي تعديلها بما يناسب السياق السائد في كل بلد.

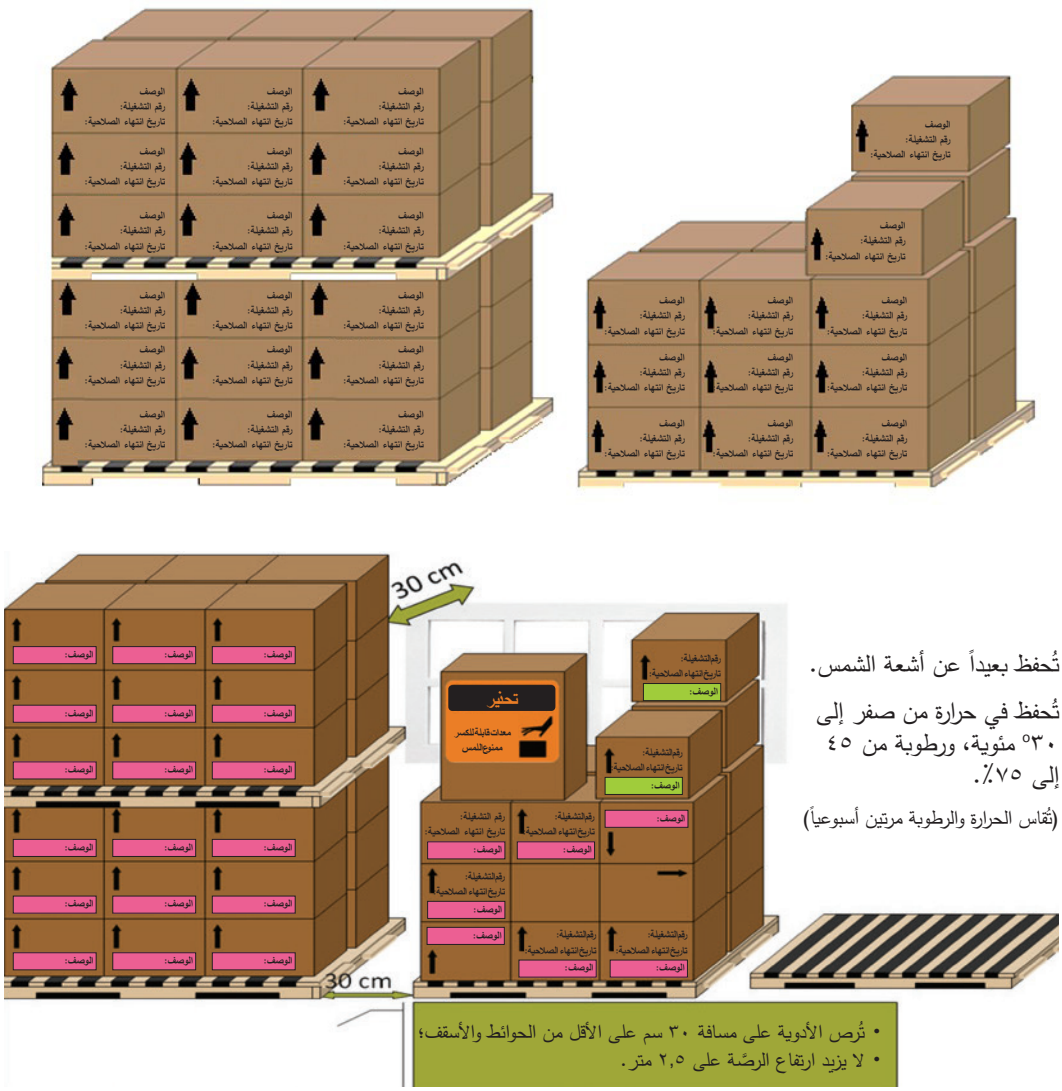
١,٣,٦ التخزين المركزي للأدوية قبل المعالجة الجموعية

متى	من	ماذا	كيف
▪ المستوى المركزي --> عند إصدار الضوء الأخضر لشحن الأدوية إلى البلد حتى شهر واحد قبل المعالجة الجموعية	▪ مدير سلسلة الإمداد المركزية بأدوية الأمراض المدارية المهملة ▪ مدير البرنامج الوطني للأمراض المدارية المهملة ▪ المرسل إليه / وكيل الشحن والتخليص	▪ استلام وتخزين أدوية الأمراض المدارية المهملة التي تصل أولاً إلى البلد إلى حين الحاجة إليها لغرض المعالجة الجموعية ▪ التخصيص الدقيق للأدوية المناسبة وكمياتها للأقاليم لغرض توزيعها.	▪ إعداد مساحة كافية وتأكيد موعد الوصول لضمان التخزين ▪ استلام الشحنة أو الشحنات والوثائق ▪ رص المخزون الجديد ▪ مراقبة الظروف المحيطة بالتخزين

المهمة	التعليمات	المسؤولية	المراجع
١.	**إعداد مساحة كافية وتأكيد موعد الوصول لضمان التخزين** ١,١ جهّز مساحة للتخزين والظروف المناسبة لوصول الشحنة. ٢,١ تأكد من توافر الأدوات اللازمة، بما في ذلك السجلات وبطاقات المخزون. ٣,١ تأكد من توافر كشوف الإحصاء أو النماذج المناسبة الأخرى لإدارة المخزون. ٤,١ احصل على معلومات الاتصال بالمرسل إليه (مع تعيين المرسل إليه مسبقاً). ٥,١ الاتصال ببرنامج الأمراض المدارية المهملة والتحقق بانتظام من حالة التسليم والموعد المقرر لتسليم الأدوية. ٦,١ تأكد من ترتيب إجراءات النقل إلى المركز الطبي المركزي في الموعد المقرر / المواعيد المقررة. ٧,١ تأكد من توافر الموظفين لتفريغ الشاحنات وتخزين الشحنة. ٨,١ حدد / أكد الشخص الذي له حق الوصول إلى المخزون.	▪ مدير سلسلة الإمداد المركزية بأدوية الأمراض المدارية المهملة ▪ مدير برنامج الأمراض المدارية المهملة ▪ المرسل إليه / وكيل الشحن والتخليص	انظر الفصل ٣: التخليص الجمركي انظر الفصل ٤: النقل انظر الفصل ٥: إدارة المخزون، والفصل ٧: ما تنتهي صلاحيته أولاً يُصرف أولاً

المهمة	التعليمات	المسؤولية	المراجع
٢.	**فحص / عد علب الكرتون المغلقة / الكاملة الواردة** ١,٢ تسلم الشحنة أو الشحنات والوثائق. ٢,٢ تحقق من وحدَة كمية كل منتج تم استلامه بالمقارنة مع الوثائق. ٣,٢ الفحص البصري والعد المادي للكرتونات المغلقة / الكاملة: ▪ قم بعد الكرتونات المغلقة / الكاملة؛ ▪ قم بعد الزجاجات في الكرتونات المفتوحة. ٤,٢ قم بتوثيق وإزالة أي مخزون تالف أو انتهت صلاحيته لدى وصول الشحنة. ٥,٢ لا تجمع رصيد الزجاجات المفتوحة في زجاجة واحدة؛ احتفظ به في زجاجات منفصلة وقم بوسم الكرتونة وفقاً لذلك بحسب تاريخ أو تواريخ انتهاء الصلاحية. ٦,٢ أعد مذكرة لتأكيد الاستلام وأرسلها إلى برنامج الأمراض المدارية المهملة / مدير المخزن الطبي المركزي.	▪ مدير سلسلة الإمداد المركزية بأدوية الأمراض المدارية المهملة	انظر الفصل ٣: التخليص الجمركي انظر الفصل ٥: إدارة المخزون انظر الفصل ١٠: إدارة النفايات
٣.	**استلام الشحنة أو الشحنات والوثائق** ١,٣ وقّع على القسيمة وبوليصة الشحن وأعد نسخة إلى وكيل التخليص. ٢,٣ إن كانت الوثائق غير كاملة أو مفقودة، لا تقبل الشحنة؛ اتصل بالمرسل إليه لتلقي المساعدة. ٣,٣ إن كانت الوثائق لا تطابق الكميات الواردة: ▪ اقبل التسليم وأعد تقريراً عن الاختلاف في الكمية الموردة، تُسجل فيه الكمية الناقصة أو الزائدة؛ سلِّم نسخة للسائق لتقديمها إلى المورد / الشاحن. ▪ في حالة ورود كمية زائدة، أعد الكمية الزائدة والفاتورة إلى السائق، واطلب فاتورة جديدة بالكمية المقبولة. ٤,٣ أخطر المرسل إليه	▪ مدير سلسلة التوريد المركزية لأدوية الأمراض المدارية المهملة ▪ الناقل ▪ مدير برنامج الأمراض المدارية المهملة ▪ المرسل إليه / وكيل الشحن والتخليص	انظر الفصل ٣: التخليص الجمركي انظر الفصل ٤: النقل انظر الفصل ٥: إدارة المخزون
٤.	**أعد مذكرة لتأكيد الاستلام وأرسلها إلى برنامج الأمراض المدارية المهملة** ١,٤ سجّل الكميات المستلمة (مثلاً، في سجل الصيدلية؛ أو نماذج التحويل / إقرار موقّع بالاستلام أو تقرير المعاملة بين الأطراف المسلِّمة أو المستلمة). ٢,٤ تأكد من إخطار برنامج الأمراض المدارية المهملة إن كانت كميات المخزون لا تطابق الوثائق (سواء أكانت كثيرة جداً أو قليلة جداً).	▪ مدير سلسلة الإمداد المركزية بأدوية الأمراض المدارية المهملة ▪ الناقل ▪ مدير برنامج الأمراض المدارية المهملة ▪ المرسل إليه / وكيل الشحن والتخليص	انظر الفصل ٣: التخليص الجمركي انظر الفصل ٤: النقل انظر الفصل ٥: إدارة المخزون
٥.	**تنفيذ بروتوكول ضمان جودة الدفعات، بحسب الاقتضاء** ١,٥ تأكد من وجود بروتوكول لاختبار الدفعات إن وُجدت سياسة وموظفون لليقظة الدوائية في البلد. ٢,٥ وثّق أنشطة تأكيد الجودة وأعد تقريراً لمنظمة الصحة العالمية و / أو البرنامج الوطني للأمراض المدارية المهملة.	▪ مدير سلسلة الإمداد المركزية بأدوية الأمراض المدارية المهملة	
٦.	**رصد المخزون الجديد (انظر الشكل ١,٦)** ١,٦ افرز الأدوية وفقاً للسياسة الوطنية، ثم وفقاً للتشغيلات وتاريخ انتهاء الصلاحية، مع وضع الأدوية الأقدم المخزنة في الجزء الأمامي من رف التخزين. ١,١,٦ في حالة تخزين الكرتونات المفتوحة (المتبقية من حملات المعالجة الجموعية السابقة)، أعد تنظيم الكرتونات بحيث يكون المخزون الأقدم في الجزء الأمامي. ٢,٦ سجّل بوضوح تاريخ الاستلام وتاريخ انتهاء الصلاحية واسم المدوَّن بحروف كبيرة وداكنة على واجهة كل كرتونة / صندوق وتأكد من وضع العلامات على جميع الأوجه. ٣,٦ تأكد قدر الإمكان من تخزين أدوية الأمراض المدارية المهملة في أماكن باردة وجافة وبعيدة عن الضوء المباشر وعلى ارتفاع مناسب يتيح سهولة الوصول إليها ولتجنب التلف. ٤,٦ املأ بطاقات التخزين وبطاقات المخزون.	▪ مدير سلسلة الإمداد المركزية بأدوية الأمراض المدارية المهملة	انظر الفصل ٥: إدارة المخزون. انظر الفصل ٧: ما تنتهي صلاحيته أولاً يُصرف أولاً
٧.	**مراقبة الظروف المحيطة بالتخزين** ١,٧ ينبغي إجراء مراقبة يومية للتأكد من ضبط درجة الحرارة والأمان ولضمان استمرار رص الصناديق بطريقة سليمة. ٢,٧ سجّل نتائج المراقبة في نموذج مناسب.	▪ مدير سلسلة الإمداد المركزية بأدوية الأمراض المدارية المهملة	انظر الفصل ٥: إدارة المخزون

الشكل ١,٦ التخزين المناسب في علب الكرتون، مع تدوين الوصف وأرقام التشغيلات وتواريخ انتهاء الصلاحية على الواجهة "حافظ على درجة الحرارة من صفر إلى ٢٥ ° مئوية والرطوبة النسبية بين ٤٥ و ٧٥٪ (يقيسها الموظفون مرتين أسبوعياً)" "الأدوية المرصوصة بحد أدنى ...." "ارتفاع المجموعة لا يزيد على ٢,٥ متراً).



المصدر: الرسم التوضيحي لكاساندرا هولوواي Cassandra Holloway

٢,٣,٦ التخزين المركزي للأدوية بعد المعالجة الجموعية (في غضون أسبوعين إلى شهر بعد المعالجة الجموعية)

متى	من	ماذا	كيف
▪ المستوى المركزي --> شهر بعد المعالجة الجموعية ▪ مستوى الإقليم / المقاطعة --> من أسبوعين إلى شهر بعد المعالجة الجموعية ▪ المرفق الصحي المحيطي --> من أسبوعين إلى شهر بعد المعالجة الجموعية	▪ مدير سلسلة الإمداد المركزية بأدوية الأمراض المدارية المهملة ▪ مدير أدوية الأمراض المدارية المهملة في المرفق الصحي الإقليمي / المقاطعي / المحيطي ▪ مدير البرنامج الوطني للأمراض المدارية المهملة	▪ استلام وتخزين أدوية الأمراض المدارية المهملة المتبقية بعد المعالجة الجموعية إلى حين الحاجة إليها في حملة المعالجة الجموعية التالية	▪ تجهيز مساحة كافية وتأكيد تاريخ الوصول لضمان التخزين ▪ استلام الشحنة (الشحنات) والوثائق ▪ رص المخزون الجديد ▪ مراقبة الظروف المحيطة بالتخزين

المهمة	التعليمات	المسؤولية	المراجع
١.	**جهّز مساحة كافية وأكد تاريخ الوصول من مستوى الإقليم / المقاطعة لضمان التخزين** ١,١ جهز مساحة كافية للتخزين والظروف المناسبة لوصول الشحنة (انظر الشكل ١,٦) ٢,١ ضمان ترتيب النقل إلى المركز الطبي المركزي مع مدير البرنامج الوطني للأمراض المدارية المهملة ومدير سلسلة الإمداد على مستوى الإقليم / المقاطعة. ٣,١ أعد قسيمة استلام من كل مخزن طبي على مستوى الإقليم / المقاطعة لإجمالي عبوات الكرتون الواردة من كل وجهة.	▪ مدير سلسلة الإمداد المركزية بأدوية الأمراض المدارية المهملة ▪ مدير برنامج الأمراض المدارية المهملة ▪ مدير سلسلة الإمداد على مستوى الإقليم / المقاطعة	انظر الفصل ٤: النقل انظر الفصل ٥: إدارة المخزون انظر الفصل ٦: التخزين، **والجدول ١,٦**
٢.	**استلام الشحنة (الشحنات) والوثاق ورص المخزون الوارد** ١,٢ استلام الشحنة (الشحنات) والوثائق. ٢,٢ قم بفحص / حصر عدد الكرتونات المغلقة (بعد المعالجة الجموعية) وعدد الزجاجات المغلقة في الكرتونات المفتوحة (بعد المعالجة الجموعية) / عدد الزجاجات المفتوحة في الكرتونات المفتوحة (بعد المعالجة الجموعية). ١,٢,٢ دوّن على أية زجاجات متبقية عبارة "فُتحت في اليوم / الشهر / السنة" مع وضع الأحرف الأولى من الاسم. ٣,٢ تحقق من كمية كل دواء تم استلامها بالمقارنة مع قسيمة الاستلام الواردة من المخزن الطبي في الإقليم / المقاطعة وحدد هذه الكمية. ٤,٢ إن كانت الوثائق لا تتطابق مع الكميات الواردة من المخزن الطبي في الإقليم أو المقاطعة: ▪ اقبل الاستلام وأعد تقريراً عن الاختلاف في الكمية الموردة، تُسجل فيه الكمية الناقصة أو الزائدة، ويُسلم إلى برنامج الأمراض المدارية المهملة والمخزن الطبي في الإقليم / المقاطعة، بحسب الاقتضاء. ٥,٢ قم بتوثيق وإزالة أي مخزون تالف أو انتهت صلاحيته بعد الوصول. ٦,٢ أعد تنظيم ورص الكرتونات / الصناديق ٧,٢ أعد مذكرة لتأكيد الاستلام تُرسل إلى برنامج الأمراض المدارية المهملة، تُسجل فيها جميع الكميات بحسب الفئة (مغلقة، مفتوحة، تالفة، منتهية الصلاحية). ٨,٢ قدم مذكرة تأكيد الاستلام وتقرير الاختلاف في الكمية الموردة (بحسب الحاجة) إلى برنامج الأمراض المدارية المهملة.	▪ مدير سلسلة الإمداد المركزية بأدوية الأمراض المدارية المهملة ▪ الناقل ▪ مدير برنامج الأمراض المدارية المهملة	انظر الفصل ٤: النقل انظر الفصل ٥: إدارة المخزون انظر الفصل ٧: ما تنتهي صلاحيته أولاً يُصرف أولاً انظر الفصل ٨: الدورة العكسية للخدمات اللوجستية انظر الفصل ٩: إزالة الأدوية المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستعمال انظر الفصل ١٠: إدارة النفايات انظر الفصل ٦: التخزين
٣.	**صيانة ومراقبة ظروف التخزين** ١,٣ المراقبة اليومية لدرجة حرارة التخزين والأمان والتخزين السليم للصناديق المرصوصة. ٢,٣ تسجيل نتائج المراقبة في نموذج مناسب.	▪ مدير سلسلة الإمداد المركزية بأدوية الأمراض المدارية المهملة	انظر الفصل ٦: التخزين

٣,٣,٦ التخزين على مستوى المرفق الصحي الإقليمي / المقاطعي / المحيطي قبل المعالجة الجموعية

متى	من	ماذا	كيف
قبل شهر إلى أسبوعين من تاريخ المعالجة الجموعية، بعد استلام الأدوية الجديدة	▪ منسق البرنامج على مستوى المرافق الصحية الإقليمية / المقاطعية / المحيطية أو من ينوب عنه. ▪ مدير سلسلة الإمداد في المرفق الصحية الإقليمي أو المقاطعي أو المحيطي / مسؤول الخدمات اللوجستية ▪ الصيدلي في المرفق الصحي الإقليمي أو المقاطعي أو المحيطي ▪ مدير سلسلة الإمداد الوطنية المركزية بأدوية الأمراض المدارية المهملة ▪ مدير البرنامج الوطني للأمراض المدارية المهملة	▪ استلام وتخزين أدوية الأمراض المدارية المهملة الموردة إلى المرافق الصحية على المستوى الإقليمي / المقاطعي / المحيطي قبل المعالجة الجموعية ▪ التخصيص الدقيق للأدوية المناسبة بالكميات المناسبة لنقاط التوزيع	▪ تجهيز مساحة كافية وتأكيد موعد الوصول لضمان التخزين ▪ استلام الشحنة (الشحنات) والوثائق ▪ رص المخزون الجديد ▪ مراقبة الظروف المحيطة بالتخزين

المهمة	التعليمات	المسؤولية	المراجع
١.	**تجهيز مساحة كافية وتأكيد تاريخ الوصول لضمان التخزين** ١,١ التحضير لوصول الشحنة (من المستوى المركزي أو الميداني، بحسب الاقتضاء) وضمان توفر الظروف المناسبة لوصول الشحنة. انظر الشكل ١,٦. ٢,١ تأكد من توفر المساحة والواح التحميل المناسبة، والأدوات والسجلات / بطاقات المخزون اللازمة. ٣,١ تأكد من توفر كشوف العد أو نماذج إدارة المخزون المناسبة الأخرى. ٤,١ الحصول على معلومات الاتصال الخاصة بالبرنامج القطري للأمراض المدارية المهملة. ٥,١ الاتصال ببرنامج الأمراض المدارية المهملة والتحقق بانتظام من حالة التسليم. ٦,١ تأكد من تنسيق عملية النقل إلى المخزن الطبي الإقليمي مع الموظف الصحي في المقاطعة أو مع البرنامج المجتمعي للأمراض المدارية المهملة. ٧,١ تأكد من توفر الموظفين لتفريغ الشاحنات وتخزين الشحنة. ٨,١ حدد / أكد الشخص الذي سيكون له حق الوصول إلى المخزون. ٩,١ قم بإعداد قسيمة الاستلام لكل مخزن طبي على مستوى الإقليم / المقاطعة لإجمالي الكرتونات الواردة من كل وجهة.	▪ مدير سلسلة الإمداد بأدوية الأمراض المدارية المهملة في المرافق الصحية على المستوى الإقليمي / المقاطعي / المحيطي، أو من ينوب عنه ▪ مدير برنامج الأمراض المدارية المهملة ▪ مدير سلسلة الإمداد المركزية بأدوية الأمراض المدارية المهملة	القسم ٤,٣,٦: التخزين على مستوى المرفق الصحي الإقليمي / المقاطعي / المحيطي انظر الفصل ٤: النقل انظر الفصل ٥: إدارة المخزون القسم ١,٣: التخزين المركزي قبل المعالجة الجموعية
٢.	**فحص / عد الكرتونات المغلقة / الكاملة الواردة** ١,٢ تسلم الشحنة (الشحنات) والوثائق. ٢,٢ قم بالفحص البصري والعد المادي للكرتونات المغلقة / الكاملة. ▪ قم بالعد المادي للكرتونات المغلقة / الكاملة. ▪ قم بالعد المادي للزجاجات في الكرتونات المفتوحة. ٣,٢ تحقق من وحدد كمية كل منتج تم استلامه بالمقارنة مع وثائق النقل. ٤,٢ قم بتوثيق وإزالة أي مخزون تالف أو انتهت صلاحيته، بعد الوصول. ٥,٢ لا تجمع رصيد الزجاجات المفتوحة في زجاجة واحدة، احتفظ به في زجاجات منفصلة وقم بوسم الكرتونة وفقاً لذلك بحسب تاريخ / تواريخ انتهاء الصلاحية.	▪ مدير سلسلة الإمداد بأدوية الأمراض المدارية المهملة في المرفق الصحي الإقليمي / المقاطعي / المحيطي	انظر الفصل ٥: إدارة المخزون انظر الفصل ١٠: إدارة النفايات انظر الفصل ٦: التخزين قبل المعالجة الجموعية

المهمة	التعليمات	المسؤولية	المراجع
٣.	**استلام الشحنة (الشحنات) والوثائق** ١,٣ وقّع قسيمة الاستلام مع إعادة نسخة منها إلى المخزن الطبي المركزي (تأكد من أن الناقل متعاقد على القيام بذلك). ▪ إن كانت الوثائق غير كاملة أو مفقودة، اتصل بمسؤول الخدمات اللوجستية الميداني أو المكتب الصحي في المقاطعة أو نقطة الاتصال في البرنامج المجتمعي للأمراض المدارية المهملة، لتلقي المساعدة. ▪ إن كانت الوثائق لا تطابق الكميات الواردة: – اقبل التسليم وأعد تقريراً عن الاختلاف في الكمية الموردة تُسجل فيه إجمالي الكميات المنفذة. ٢,٣ أرسل رسالة قصيرة إلى مدير برنامج الأمراض المدارية المهملة تُسجل فيها الأعداد النهائية الواردة لضمان التأكيد السريع في حالة إمكانية استعمال الأدوية في مواقع أخرى في فترة المعالجة الجموعية نفسها. ٣,٣ أعد مذكرة لتأكيد الاستلام وأرسلها إلى برنامج الأمراض المدارية المهملة.	▪ مدير سلسلة الإمداد بأدوية الأمراض المدارية المهملة في المرفق الصحي على المستوى الإقليمي / المقاطعي / المحيطي. ▪ الناقل ▪ مدير برنامج الأمراض المدارية المهملة	انظر الفصل ٤: النقل انظر الفصل ٥: إدارة المخزون انظر الفصل ٦: التخزين قبل المعالجة الجموعية
٤.	**رص المخزون الجديد (انظر الشكل ١,٦)** ١,٤ رص الأدوية وفقاً لنوع الدواء، ثم وفقاً للتشغيلات وتاريخ انتهاء الصلاحية، مع وضع الزجاجات الأقدم المخزنة في الجزء الأمامي من رف التخزين. ▪ في حالة تخزين الزجاجات المتبقية من المعالجة الجموعية، تأكد من وجود عبارة "فُتحت في اليوم / الشهر / السنة" عليها مع التوقيع بالأحرف الأولى. ▪ تأكد من صرف الزجاجات المفتوحة أولاً في حملة المعالجة الجموعية القادمة. ٢,٤ إن كانت الكرتونات / الصناديق غير مدون عليها البيانات، سجّل بوضوح تاريخ انتهاء الصلاحية بأرقام كبيرة وداكنة على واجهة كل كرتونة / صندوق وتأكد من تسجيل البيانات على جميع الأوجه. ٣,٤ تأكد (قدر الإمكان) من تخزين الأدوية في أماكن باردة وجافة وبعيدة عن ضوء الشمس المباشر وعلى ارتفاع مناسب يتيح سهولة الوصول إليها ولتجنب التلف. ٤,٤ املأ بطاقات التخزين وبطاقات المخزون، بحسب الاقتضاء	▪ مدير سلسلة الإمداد بأدوية الأمراض المدارية المهملة في المرافق الصحية الإقليمية / المقاطعية / المحيطية	انظر الفصل ٥: إدارة المخزون انظر الفصل ٧: ما تنتهي صلاحيته أولاً يُصرف أولاً انظر الفصل ٦: التخزين قبل المعالجة الجموعية
٥.	**صيانة ومراقبة ظروف التخزين** ١,٥ أجر مراقبة يومية لدرجة حرارة التخزين والأمان والتخزين السليم للصناديق المرصوصة. ٢,٥ راقب درجة الحرارة وسجّلها على نموذج مناسب. وينبغي أن تكون بيانات مراقبة درجات الحرارة المسجلة متاحة للاستعراض. وينبغي فحص المعدات المستخدمة للرصد على فترات زمنية مناسبة محددة سلفاً، مع تسجيل نتائج هذا الفحص والاحتفاظ بها. وينبغي أيضاً معايرة المعدات المستخدمة في المراقبة على فترات زمنية محددة.	▪ مدير سلسلة الإمداد بأدوية الأمراض المدارية المهملة في المرافق الصحية الإقليمية / المقاطعية / المحيطية	انظر الفصل ٥: إدارة المخزون انظر الفصل ٦: التخزين قبل المعالجة الجموعية

٤,٣,٦ التخزين على مستوى المرفق الصحي الإقليمي / المقاطعي / المحيطي بعد المعالجة الجموعية (من شهر إلى أسبوعين بعد المعالجة الجموعية)

متى	من	ماذا	كيف
من أسبوعين إلى شهر بعد تاريخ المعالجة الجموعية	▪ منسق البرنامج على مستوى المرفق الصحي الإقليمي / المقاطعي / المحيطي، أو من ينوب عنه. ▪ مدير سلسلة الإمداد / مسؤول الخدمات اللوجستية في المرفق الصحي الإقليمي / المقاطعي / المحيطي ▪ صيدلي المرفق الصحي الإقليمي / المقاطعي / المحيطي ▪ مدير سلسلة الإمداد الوطنية المركزية بأدوية الأمراض المدارية المهملة	▪ استلام وتخزين أدوية الأمراض المدارية المهملة المتبقية بعد المعالجة الجموعية إلى حين الحاجة إليها في حملة المعالجة الجموعية القادمة	▪ تجهيز مساحة كافية وتأكيد تاريخ الوصول لضمان التخزين ▪ استلام الشحنة (الشحنات) والوثائق ▪ رص المخزون الجديد ▪ مراقبة الظروف المحيطة بالتخزين

المهمة	التعليمات	المسؤولية	المراجع
١.	**تجهيز مساحة كافية وتأكيد تاريخ الوصول لضمان التخزين** ١,١ الإعداد لوصول الشحنة (من المستوى الميداني، بحسب الاقتضاء) وضمان توفر الظروف المناسبة. ٢,١ تأكد من توفر الأدوات الضرورية، بما في ذلك السجلات أو بطاقات المخزون أو كشوف العد أو نماذج إدارة المخزون المناسب الأخرى. ٣,١ الاتصال ببرنامج الأمراض المدارية المهملة والتحقق بانتظام من حالة تسليم الأدوية والموعد المقرر لوصولها. ٤,١ تأكد من ترتيب عملية النقل إلى المخزن الطبي المركزي في المواعيد المقررة. ٥,١ تأكد من توافر الموظفين لتفريغ الشاحنات وتخزين الشحنة. ٦,١ حدّد / أكد الشخص الذي سيكون له حق الوصول إلى المخزون. ٧,١ (في حالة المخزن الطبي الإقليمي) قم بإعداد قسيمة الاستلام من كل مخزن طبي في المقاطعات لإجمالي الكرتونات الواردة من كل وجهة.	▪ مدير سلسلة الإمداد بأدوية الأمراض المدارية المهملة في المرافق الصحية الإقليمية / المقاطعية / المحيطية، أو من ينوب عنه ▪ مدير برنامج الأمراض المدارية المهملة	القسم ٣,٣,٦: التخزين على مستوى المرفق الصحي الإقليمي / المقاطعي / المحيطي قبل المعالجة الجموعية انظر الفصل ٤: النقل انظر الفصل ٥: إدارة المخزون
٢.	**استلام الشحنة (الشحنات) والوثائق ورص المخزون الجديد** ١,٢ استلم الشحنة (الشحنات) والوثائق. ٢,٢ قم بالفحص البصري والعد المادي للكرتونات المغلقة / الكاملة (قم بحصر مادي للكرتونات المغلقة / الكاملة؛ وقم بحصر مادي لعدد الزجاجات في الكرتونات المفتوحة). ٣,٢ أعد مذكرة لتأكيد الاستلام وأرسلها إلى برنامج الأمراض المدارية المهملة / مدير المخزن الطبي المركزي. ٤,٢ افرز الأدوية بحسب نوع الدواء، ثم بحسب التشغيلات وتاريخ انتهاء الصلاحية، وانقل الزجاجات الأقدم المخزنة بالفعل إلى الجزء الأمامي من رف التخزين. ▪ إن كانت الكرتونات / الصناديق غير مدون عليها البيانات، سجّل بوضوح تاريخ انتهاء الصلاحية بأرقام كبيرة وداكنة على واجهة كل كرتونة / صندوق وتأكد من تسجيل البيانات على جميع الأوجه. ▪ ينبغي أن يُدون على أية زجاجات متبقية عبارة "فُتحت في اليوم / الشهر / السنة" مع التوقيع بالأحرف الأولى. ٥,٢ تأكد (قدر الإمكان) من تخزين الأدوية في أماكن باردة وجافة وبعيدة عن ضوء الشمس المباشر وعلى ارتفاع مناسب يتيح سهولة الوصول إليها ولتجنب التلف. ٦,٢ املأ بطاقات التخزين وبطاقات المخزون، بحسب الاقتضاء. ٧,٢ تأكد من صرف الزجاجات المفتوحة أولاً في إطار دورة المعالجة الجموعية التالية. ٨,٢ إن كانت الأدوية ستظل في مخزن المرفق الطبي الإقليمي / المقاطعي / المحيطي حتى دورة المعالجة الجموعية التالية، أرسل حصراً نهائياً للأدوية مع تواريخ انتهاء صلاحيتها إلى نقطة الاتصال في برنامج الأمراض المدارية المهملة لكي يستخدمها في إعداد نموذج الإبلاغ المشترك والطلب المشترك لأدوية مختارة. ٩,٢ إن كانت الأدوية ستُنقل إلى مكان آخر أو ستُدمر، أخطر نقطة الاتصال في البرنامج المجتمعي للأمراض المدارية المهملة في أسرع وقت ممكن مع ذكر التفاصيل المتعلقة بالأدوية والكميات.	▪ مدير سلسلة الإمداد بأدوية الأمراض المدارية المهملة في المرافق الصحية الإقليمية / المقاطعية / المحيطية	القسم ٣,٣,٦: التخزين في المرافق الصحية الإقليمية والمقاطعية والمحيطية قبل المعالجة الجموعية انظر الفصل ٥: إدارة المخزون انظر الفصل ٧: ما تنتهي صلاحيته أولاً يُصرف أولاً انظر الفصل ٩: إزالة الأدوية المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستعمال انظر الفصل ١٠: إدارة النفايات
٣.	**صيانة ومراقبة ظروف التخزين** ١,٣ أجر مراقبة يومية لدرجة حرارة التخزين والأمان والتخزين السليم للصناديق المرصوصة. ٢,٣ سجل نتائج المراقبة على نموذج مناسب.	▪ مدير سلسلة الإمداد بأدوية الأمراض المدارية المهملة في المرافق الصحية / الإقليمية / المقاطعية / المحيطية	القسم ٣,٣,٦: التخزين في المرافق الصحية الإقليمية / المقاطعية / المحيطية قبل المعالجة الجموعية انظر الفصل ٥: إدارة المخزون

٧. ما تنتهي صلاحيته أولاً يُصرف أولاً

١,٧ الغرض من إجراء التشغيل الموحد هذا ونطاقه

يبين هذا الإجراء عملية تقليل الفاقد الناجم عن انتهاء الصلاحية، بضمان أن يُصرف أولاً المخزون الذي تنتهي صلاحيته أولاً. ويُنظم المخزون بحسب تاريخ انتهاء الصلاحية؛ فالمخزون الذي تنتهي صلاحيته أولا يُصرف أولاً، بغض النظر عن تاريخ استلامه في المخازن الطبية أو المرفق الصحية. ويشير الحرف "E" من المختصر "FEFO"[١] (أي ما تنتهي صلاحيته أولاً يُصرف أولاً) إلى تاريخ انتهاء صلاحية المنتج، الذي يحدده المصنّع. وهذا النهج هو أفضل ممارسة لإدارة المخزون وهو جزء من ممارسات التخزين الجيدة وإدارة المخزون.

٢,٧ الاعتبارات الرئيسية

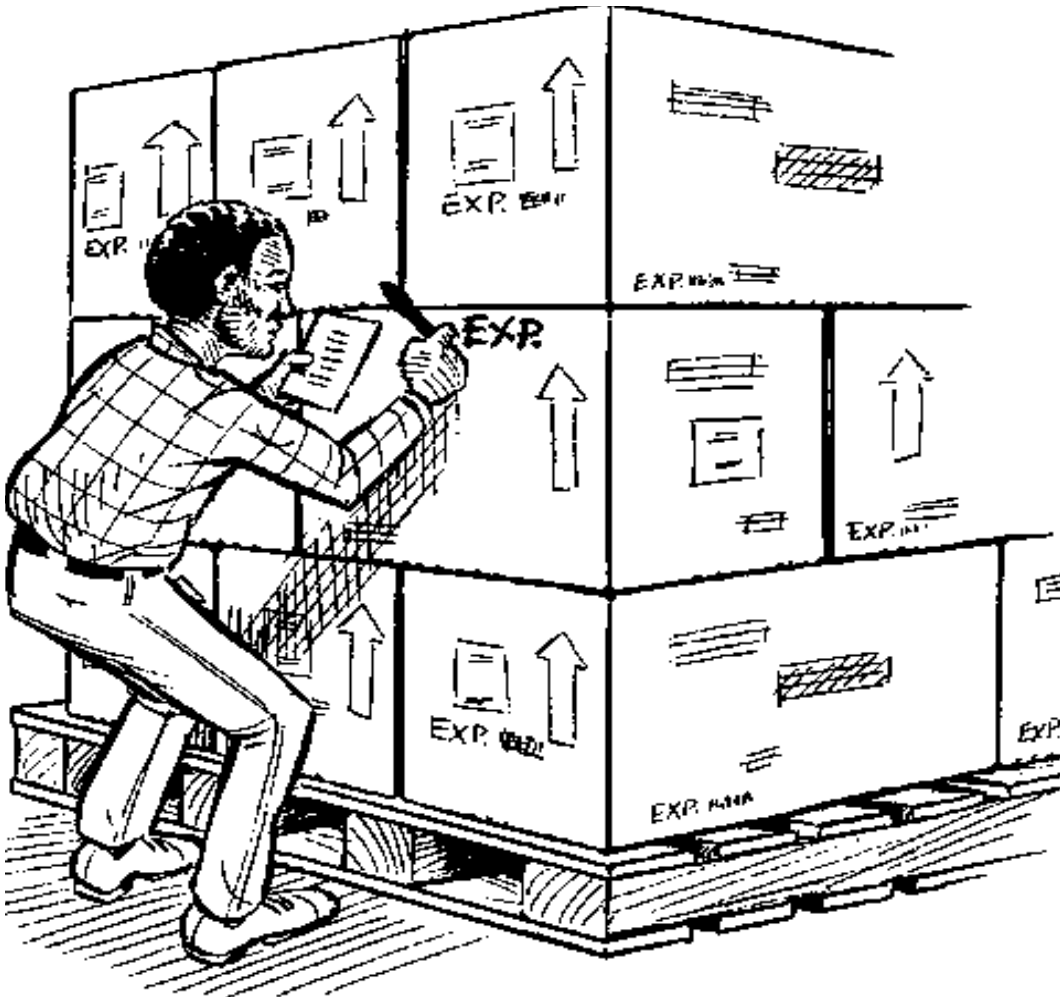
نظم إدارة المستودعات. ينبغي استخدام نظم إدارة المستودعات أو تطبيقها حيثما أمكن لتيسير اتباع نهج ما تنتهي صلاحيته أولاً يُصرف أولاً، سواء باتباع النظام الالكتروني أم الورقي. ولدى استلام المخزون، ينبغي تسجيل أرقام التشغيلات/ الدفعات وتواريخ انتهاء الصلاحية وموقع الرف/ الحامل في هذه النظم وتسجيلها على الأرفف / الحوامل التي يخزن عليها المنتج. وينبغي لصيدلي المخزن / مدير سلسلة الإمداد إنشاء نظام تنبيه وإجراء عمليات تحقق منتظمة لتحديد المخزون الذي اقترب تاريخ انتهاء صلاحيته ولإخطار الجهات المعنية، مثل برنامج الأمراض المدارية المهملة. وينبغي أن يُدون على جميع الزجاجات والكرتونات رقم التشغيلة / الدفعة وأن يُدون تاريخ انتهاء الصلاحية بوضوح على كل كرتونة (انظر الشكل ١,٧)، مع الاحتفاظ ببطاقات دفتر الموازنة الخاصة بالمخزون (انظر النماذج في الملحق ٧).

تعظيم موارد العمالة والإنتاجية، وخفض الفاقد من المخزون بسبب انتهاء الصلاحية. من شأن نهج ما تنتهي صلاحيته أولاً يُصرف أولاً (FEFO) أن يوفر تكاليف العمالة والوقت، مما يقلل من المشكلات المتعلقة بتواريخ انتهاء الصلاحية في وقت توزيع المخزون. وبتطبيق هذه العملية، من الممكن لبرنامج الأمراض المدارية المهملة أن يحسّن إدارة مستويات المخزون وأن يتجنب الفاقد الناجم عن انتهاء الصلاحية، وبذلك يرفع إلى أعلى مستوى العمر التخزيني المتبقي للمخزون المتاح ويزيد الإنتاجية الإجمالية للموارد والفوائد التي تعود على السكان المحليين المستهدفين. **ولا يزال من الضروري جرد المخزون الفعلي ومراقبة تواريخ انتهاء صلاحية المخزون.**

الإشراف على الأدوية المتبرع بها. يفيد نهج ما تنتهي صلاحيته أولاً يُصرف أولاً في إظهار فعالية الإشراف على برنامج التبرع بأدوية الأمراض المدارية المهملة، والحد من الأعداد المبلغ عنها من المخزون المنتهي الصلاحية أو المفقود المسجلة في نموذج الإبلاغ المشترك (انظر الفصل ١)، وتقليص الاحتياجات الإضافية من المخزون نتيجة للإبلاغ الأكثر دقة عن المخزون المتاح (انظر الفصل ١١)، مما يضمن مزيداً من الثقة في العلاقة بين المتبرعين بالأدوية ومتلقيها.

١ FEFO: First expiry first out

الشكل ١,٧ تسجيل تاريخ (تواريخ) انتهاء الصلاحية على كل كرتونة أدوية واردة



المصدر: الرسم التوضيحي أعدته Cassandra Holloway

٣,٧ إجراء التشغيل الموحد

الوظائف المحددة، وأدوارها، والخطوات التي يجب اتخاذها في هذا الإجراء هي أمثلة توضيحية وينبغي تعديلها بما يناسب السياق السائد في كل بلد.

١,٣,٧ في جميع الأوقات، وعلى جميع المستويات

متى	من	ماذا	كيف
▪ كلما تم استلام أدوية في مرفق التخزين ▪ كلما نُقلت الأدوية فيما بين مرافق التخزين ▪ قبل المعالجة الجموعية ▪ بعد المعالجة الجموعية وعند استلام المخزون المتبقي	▪ صيدلي المخزن ▪ فني الصيدلية ▪ مدير سلسلة الإمداد في جميع مستويات المخازن الطبية (المركزي، الإقليمي، المقاطعي، ونقطة الرعاية)	▪ إيلاء أولوية لتوزيع الأدوية التي اقترب موعد انتهاء صلاحيتها ▪ الحد من فاقد الأدوية بسبب انتهاء صلاحيتها	▪ سجّل بوضوح تواريخ انتهاء الصلاحية واحتفظ بسجلات جرد المخزون ▪ أجر عمليات فحص روتينية ورتّب المخزون بحسب تاريخ انتهاء الصلاحية ▪ تحقق من سياسات العمر التخزيني المتبقي وأصدر إشعارات بالمخزون الذي تنتهي صلاحيته قبل ستة أشهر

المهمة	التعليمات	المسؤولية	المراجع
١.	**سجّل بوضوح تواريخ انتهاء الصلاحية واحتفظ بسجلات جرد المخزون (الشكل ١,٧)** ١,١ عند استلام مخزون جديد أو متبق، سجّل تواريخ انتهاء الصلاحية بقلم أسود عريض على السطح الخارجي لكل كرتونة، مع التأكد من إمكانية قراءة التواريخ من بُعد. ٢,١ في حالة الزجاجات المفردة غير المفتوحة، سجّل تاريخ انتهاء الصلاحية بحروف كبيرة على الزجاجات. ٣,١ ينبغي أن تُسجَّل على أي زجاجات مفتوحة عبارة "فُتحت في اليوم / الشهر / السنة" مع التوقيع بالحروف الأولى، وكذلك تسجيل تاريخ انتهاء الصلاحية بلون مختلف. ٤,١ سجّل تفاصيل المخزون، مثل رقم التشغيلة / الدفعة، وتواريخ انتهاء الصلاحية، والكميات على نماذج المخزون ونظم المستودعات (مثلاً، بطاقة دفتر الموازنة الخاص بالمخزون، ونظام إدارة المستودع). ٥,١ أكد ووثّق العمر التخزيني المتبقي المقبول للأدوية. اتبع سياسة البلد في وقت استلام المخزون.	▪ صيدلي المخزن ▪ فني الصيدلية ▪ مديرو سلسلة الإمداد في المخزن الطبي على جميع المستويات (المركزي، الإقليم، المقاطعة، نقطة الرعاية).	انظر الفصل ٥: إدارة المخزون انظر الفصل ٦: التخزين انظر الفصل ٨: الدورة العكسية للخدمات اللوجستية
٢.	**حافظ على تنظيم المخزون بحسب تاريخ انتهاء الصلاحية في جميع الأوقات** ١,٢ ضع زجاجات أو كرتونات كل دواء بحيث يُرص المخزون الذي تنتهي صلاحيته أولاً أمام أو فوق مخزون نفس الدواء الذي تنتهي صلاحيته في وقت لاحق. وفي حالة وجود عدة منتجات لها نفس تاريخ انتهاء الصلاحية، اتبع نفس المبدأ: ضع المخزون الأقرب في تاريخ انتهاء الصلاحية بحيث يؤخذ أو يصرف أولاً. ٢,٢ أجر عمليات فحص روتينية وأعد الترتيب كلما تم استلام مخزون إضافي.	▪ صيدلي المخزن ▪ فني الصيدلية ▪ مديرو سلسلة الإمداد في المخزن الطبي على جميع المستويات (المركزي، الإقليم، المقاطعة، نقطة الرعاية)	بطاقة دفتر الموازنة الخاص بالمخزون (الملحق ٧). نظام إدارة المستودعات (إن وُجد). انظر الفصل ٥: إدارة المخزون. انظر الفصل ٦: التخزين.
٣.	**إخطارات تاريخ انتهاء الصلاحية، وصرف المخزون** ١,٣ استخدم بطاقة دفتر الموازنة الخاص بالمخزون أو نظام إدارة المستودعات، إن وُجد، للتحقق الروتيني من تواريخ انتهاء صلاحية المخزون المتاح وللتأكد من أن رقم تشغيلة / دفعة المخزون المأخوذ يستند إلى مبدأ ما تنتهي صلاحيته أولاً يُصرف أولاً. ٢,٣ أطلع برنامج الأمراض المدارية المهملة، بانتظام، على كميات المخزون المتاح وتواريخ انتهاء الصلاحية. ٣,٣ أصدر إشعارات شهرية بالمنتجات التي تنتهي صلاحيتها قبل ستة أشهر. ٤,٣ يجب توثيق أي دواء انتهت صلاحيته ونقله من أجل التخلص منه بشكل سليم في أقرب وقت ممكن وفقاً للسياسة الوطنية. ٥,٣ أخطر برنامج الأمراض المدارية المهملة بجميع الأدوية المنتهية الصلاحية، بالاسم والكمية.	▪ صيدلي المخزن ▪ فني الصيدلية ▪ مديرو سلسلة الإمداد في المخزن الطبي على جميع المستويات (المركزي، الإقليم، المقاطعة، نقطة الرعاية) ▪ مدير برنامج الأمراض المدارية المهملة	بطاقة دفتر الموازنة الخاص بالمخزون (الملحق ٧). نظام إدارة المستودعات (إن وُجد). انظر الفصل ٦: التخزين. انظر الفصل ٥: إدارة المخزون انظر الفصل ٩: إزالة الأدوية غير الصالحة للاستعمال والمنتهية الصلاحية. انظر الفصل ١٠: إدارة النفايات

٨. الدورة العكسية للخدمات اللوجستية

١,٨ الغرض من إجراء التشغيل الموحد هذا ونطاقه

يوجِّه هذا الإجراء البلدان في سياق الدورة العكسية للخدمات اللوجستية لأدوية الأمراض المدارية المهملة، بما في ذلك إعادة نقل الأدوية من المراحل النهائية الى الاولية لنظام سلسلة الإمداد. ولا يقل ترتيب الدورة العكسية للخدمات اللوجستية أهميةً عن عملية تخطيط التوزيع، وينبغي القيام بهذا الترتيب كجزء من المعالجة الجموعية. وينطبق هذا الإجراء أساساً على أدوات تشخيص الأمراض المدارية المهملة غير المستعملة.

الأهداف

- ضمان سلامة سلسلة الإمداد الوطنية بالأدوية المتبرع بها والمشتراة.
- منع سرقة الأدوية وتسويقها.
- تجنب إهدار الموارد في البلدان عن طريق شراء أو طلب الكثير جداً أو القليل جداً من الأدوية لتلبية احتياجات المعالجة الجموعية، سواء من منظمة الصحة العالمية أم وكالات المشتريات أم الموردين الآخرين.

النتائج المتوقعة

- عدم تحويل الأدوية من المستودعات المعيَّنة قبل المعالجة الجموعية أو بعدها.
- عدم وجود أدوية منتهية الصلاحية.
- عدم وجود أدوية مهدرة.
- تخزين الأدوية بشكل مناسب لاستعمالها في دورة المعالجة الجموعية المقبلة.
- توجيه الأدوية غير الصالحة للاستعمال نحو التخلص منها وفقاً للسياسة الوطنية.

٢,٨ الاعتبارات الرئيسية

لضمان إدارة الأدوية المتبقية على نحو سليم ومنع إهدار المخزون، ينبغي لمنسق أو منسقي البرنامج الوطني للأمراض المدارية المهملة أو من ينوب عنهم أخذ ما يلي في الاعتبار.

- ضمان توفير ميزانية مناسبة لدعم الدورة العكسية للخدمات اللوجستية (بدل السفر، والانتقال، والوقود، وما إلى ذلك) كجزء من تخطيط المعالجة الجموعية، بما في ذلك ما يلي:
  - وضع استراتيجيات لتحفيز موزعي الأدوية في المجتمع، أو المدرسين، أو العاملين في المرافق الصحية (بحسب الاقتضاء) على تجميع ودمج الأدوية المتبقية بعد المعالجة الجموعية. ولا تحصل هذه الأطراف المسؤولة في جميع الأحيان على بدل سفر عند إعادة الأدوية، الأمر الذي يقلل من حماسهم على القيام بذلك.
- تأكد من إعادة جميع الأدوية غير المستعملة إلى المستودع النهائي المحدد في فترة لا تزيد على شهر من استكمال حملات المعالجة الجموعية. ويستلزم ذلك ما يلي:
  - إعداد جدول زمني محدد لكل مرحلة من مراحل إعادة الأدوية؛
  - تحديد الأشخاص الذين يجرون الجرد في كل مرحلة، وتجميع المخزون المتبقي على كل مستوى معين؛ وينبغي أن يشترك شخصان على الأقل في إجراء الجرد؛
  - التخطيط لمتابعة الفجوات المحددة في عمليات إعادة الأدوية المتبقية، بحيث تجري تسوية جميع الأدوية أو الإبلاغ عنها.
- وضع خطة وتحديد المسؤولين عن تنفيذ واستكمال وتقديم عمليات تسوية الزجاجات المفتوحة والمغلقة، وعن التخزين / إعادة الاستعمال مقابل التدمير أو النقل إلى المخزن الطبي المركزي أو الصيدلية المركزية (انظر إجراءات النقل (الفصل ٤)، وإدارة المخزون (الفصل ٥)، والتخزين (الفصل ٦)، وما تنتهي صلاحيته أولاً يُصرف أولاً (الفصل ٧)، وإدارة النفايات (الفصل ١٠) للاطلاع على الخطوات الموصى بها في كل مرحلة).
- أبلغ عن رصيد الزجاجات المفتوحة والمغلقة المخزنة للاستعمال المستقبلي، وذلك في نموذج الإبلاغ المشترك بعد المعالجة الجموعية (الفصل ١)، والتنبؤ والتقدير الكمي (الفصل ١١).
  - بالنسبة لأقراص أزيثروميسين أو محلوله الفموي الخاص للأطفال، أبلغ أيضاً عن المخزونات للمبادرة الدولية لمكافحة التراخوما.
  - أية محاليل فموية معاد تكوينها لا ينبغي حفظها ضمن المخزون بل التخلص منها فوراً.
  - بالنسبة للأقراص القابلة للمضغ (مثل ميبيندازول)، يكون عمرها التخزيني من شهر إلى شهرين فقط بعد الفتح، ومن ثم لا ينبغي تخزينها لحملة المعالجة الجموعية في العام التالي.
- افرز الأدوية المنتهية الصلاحية والتالفة وتخلص منها وفقاً للمبادئ التوجيهية الحكومية، ووثّق هذه العملية (انظر إجراءات إدارة النفايات في الفصل ١٠). أطلع منسق البرنامج الوطني للأمراض المدارية المهملة أو من ينوب عنه على هذه الوثائق لضمان إدراجها في نموذج الإبلاغ المشترك. والوظائف المحددة، وأدوارها، والخطوات التي يجب اتخاذها في هذا الإجراء هي أمثلة توضيحية وينبغي تعديلها بما يناسب السياق السائد في كل بلد.

٣,٨ إجراء التشغيل الموحد

قد تختلف الخطوات العامة في عملية الدورة العكسية للخدمات اللوجستية بحسب السياق القطري. وتوضح الوظائف والمسؤوليات المبينة أدناه الخطوات النموذجية المتخذة في كل مرحلة من الدورة العكسية للخدمات اللوجستية، بدايةً من مستوى المعالجة الجموعية إلى مستوى المخزن الطبي المركزي. ومن المسلم به أن بعض البلدان قد تختار الاحتفاظ بالأدوية المتبقية على المستوى الإقليمي أو مستوى المقاطعة؛ في هذه الحالة، يمكن تجاهل النقاط اللاحقة المبينة في الجدول الزمني. ويمكن، بل ينبغي، تكييف هذا الإجراء بما يناسب السياق المحدد لكل بلد. وترد عينات من النماذج في *الملحقين* ٨ و ٩. وتُعرض النماذج والوثائق الأخرى اللازمة للدورة العكسية الفعالة للخدمات اللوجستية **بالخط العريض في التعليمات**. ولتلقي المساعدة في إعداد نماذج الوثائق، يُرجى الاتصال بمنظمة الصحة العالمية.

متى	من	ماذا	كيف
بعد المعالجة الجموعية مباشرة	▪ موزعو الأدوية في المجتمع / المدرسون / موظفو المرفق الصحي، بحسب ما يقتضيه سياق المعالجة الجموعية ▪ مدير المخزن الطبي في المقاطعة	▪ إعادة الأدوية المتبقية والتالفة والمنتهية الصالحة إلى مرفق معين مسبقاً / المرفق الطبي في المقاطعة (بحسب الوضع في البلد)	▪ استكمال نموذج إعادة / نقل الأدوية وفقاً للأدوات المساعدة على العمل (الملحقان ٨ و ٩)
من أسبوع إلى أسبوعين بعد المعالجة الجموعية (إن كانت الأدوية ستُنقل إلى مرافق تخزين أعلى مستوى)	▪ منسق الأمراض المدارية المهملة في المقاطعة أو من ينوب عنه ▪ مدير المخزن الطبي في الإقليم / المقاطعة	▪ تأكيد الأعداد الإجمالية للعلاجات في ضوء الأدوية الواردة. ▪ ملاحظة أي اختلافات و / أو مخزون مفقود من أجل المتابعة، وإرسال تقرير إلى منسق البرنامج الإقليمي أو الوطني للأمراض المدارية المهملة (بحسب السياق القطري). ▪ حفظ الأدوية المعادة والاحتفاظ بسجلات للكميات الواردة من كل مقاطعة (ووحدة تنفيذ إن وُجدت). ▪ ملاحظة فجوات البيانات والإبلاغ عنها لمنسق البرنامج الوطني للأمراض المدارية المهملة لمتابعتها.	▪ استكمال نموذج إعادة / نقل الأدوية وفقاً للأدوات المساعدة على العمل (الملحقان ٨ و ٩)
من أسبوع إلى أسبوعين بعد المعالجة الجموعية (إن كانت الأدوية ستُنقل إلى مرافق تخزين أعلى مستوى)	▪ منسق الأمراض المدارية المهملة في المقاطعة أو من ينوب عنه ▪ مدير المخزن الطبي في الإقليم / المقاطعة ▪ المخزن الطبي المركزي	▪ تأكيد استلام الأدوية المعادة من جميع المقاطعات. ▪ إعادة جميع الأدوية التي جُمعت في المرحلة ٢ إلى المخزن المركزي بعد التشاور مع منسق البرنامج الوطني للأمراض المدارية المهملة. ▪ حفظ الأدوية المعادة.	▪ استكمال نموذج إعادة / نقل الأدوية وفقاً للأدوات المساعدة على العمل (الملحقان ٨ و ٩)

المهمة	التعليمات	المسؤولية	المراجع
٠١	المرحلة ١: التجميع في المرفق أو المخزن المعيَّن الأقرب إلى نقطة المعالجة الجموعية (عادة على مستوى المقاطعة، وقد يكون مستوى المقاطعة الفرعية، بحسب عدد وحدات التنفيذ في المنطقة) ١,١ خطط لاستكمال هذه المهمة بعد المعالجة الجموعية مباشرة. ٢,١ ينبغي وضع علامات واضحة على الأدوية التالفة أو المنتهية الصلاحية أو غير الصالحة للاستعمال، وتعبئتها بشكل منفصل. وينبغي أيضاً كتابة أرقام التشغيلات (الموجودة على الزجاجة أو العبوة) إن وُجدت. ٣,١ اجمع الزجاجات الفارغة واطمس البيانات المدونة عليها (باستخدام قلم داكن أو بلون أخف) لتدميرها وفقاً لسياسة إدارة النفايات في البلد. ٤,١ احصر عدد الزجاجات / الحاويات بشكل منفصل عن الزجاجات / الحاويات غير المفتوحة (المغلقة). ٥,١ قدِّم إلى منسق برنامج الأمراض المدارية المهملة في المقاطعة إحصاءً للعد الكلي للعلاجات **وسجلاً برصيد مخزون الأدوية** أو نماذج إعادة / نقل الأدوية، إلى جانب الأدوية المتبقية. ٦,١ يحتفظ نقطة الاتصال في مخزن المقاطعة أو المرفق الصحي مؤقتاً بالأدوية المعادة ويحتفظ **بسجلات الكميات الواردة**، بما في ذلك أرقام التشغيلات. ٧,١ إن كان المرفق مخزناً رسمياً تُحفظ به أدوية الأمراض المدارية المهملة، ينبغي تحديث **دفتر الموازنة الخاص بالمخزون** وإعداد **تقرير عن حالة المخزون** من الكميات المتاحة، وتواريخ انتهاء الصلاحية، والفاقد، يُقدم إلى برنامج الأمراض المدارية المهملة. وبعد ذلك يجري تعبئة الأدوية في صناديق وتخزينها.	▪ موزعو الأدوية في المجتمع / المدرسون / موظفو المرفق الصحي، بحسب ما يقتضيه سياق المعالجة الجموعية ▪ الناقل (بحسب الاقتضاء) ▪ مدير المخزن الطبي في المقاطعة ▪ منسق برنامج الأمراض المدارية المهملة في المقاطعة	نموذج إعادة / نقل الأدوية (الملحق ٨) المواد المساعدة على استكمال نموذج إعادة / نقل الأدوية (الملحق ٩) انظر الفصل ٥: إدارة المخزون انظر الفصل ٦: التخزين انظر الفصل ٧: ما تنتهي صلاحيته أولاً يُصرف أولاً انظر الفصل ١٠: إدارة النفايات

المهمة	التعليمات	المسؤولية	المراجع
٢.	المرحلة ٢: جمع الحزم التي تم تجميعها من جميع مرافق المرحلة ١ في المخزن الإقليمي (إن كانت الأدوية ستُنقل إلى مرافق تخزين أعلى مستوى). ١,٢ خطط لاستكمال هذه المهمة في غضون أسبوع إلى أسبوعين بعد المعالجة الجموعية. ٢,٢ أكد الأعداد الإجمالية للعلاجات في ضوء الأدوية الواردة. ٣,٢ لاحظ أي اختلافات و / أو مخزون مفقود من أجل المتابعة، وأرسل **تقريراً** إلى منسق البرنامج الإقليمي أو الوطني للأمراض المدارية المهملة (بحسب السياق القطري). ٤,٢ أعد جميع الأدوية التي جُمعت في المرحلة ١ إلى المخزن الطبي الإقليمي بعد التشاور مع منسق البرنامج الوطني للأمراض المدارية المهملة. ٥,٢ احفظ الأدوية المعادة واحتفظ **بسجلات الكميات الواردة** من كل مقاطعة (ووحدة تنفيذ إن وُجدت) ٦,٢ لاحظ فجوات البيانات **وأبلغ** عنها لمنسق البرنامج الوطني للأمراض المدارية المهملة لمتابعتها. ٧,٢ قم بمضاهاه الكمية المعادة مع أرقام التشغيلات المدونة بوضوح. ٨,٢ حدّث **دفتر الموازنة الخاص بالمخزون** وأعد أيضاً **تقرير حالة المخزون**.	▪ مدير المخزن الطبي في المقاطعة. ▪ منسق برنامج الأمراض المدارية المهملة في المقاطعة أو من ينوب عنه. ▪ المخزن الطبي في الإقليم / المقاطعة ▪ الناقل (بحسب الاقتضاء)	نموذج إعادة / نقل الأدوية (الملحق ٨) انظر الفصل ٥: إدارة المخزون انظر الفصل ٦: التخزين انظر الفصل ٧: ما تنتهي صلاحيته أولاً يُصرف أولاً
٣.	المرحلة ٣: إعادة جميع الأدوية المتبقية بعد المعالجة الجموعية إلى المخزن الطبي المركزي من أجل دورة المعالجة الجموعية التالية. ١,٣ خطط لاستكمال هذه المهمة في غضون ١ – ٣ أسابيع بعد المعالجة الجموعية. ٢,٣ أكد **استلام** الأدوية المعادة من جميع المقاطعات. ٣,٣ قم بإعادة جميع الأدوية المجمعة في المرحلة ٢ إلى المخزن الطبي المركزي بعد التشاور مع منسق البرنامج الوطني للأمراض المدارية المهملة. ٤,٣ يحتفظ المخزن الطبي المركزي بالأدوية المعادة. ٥,٣ تحقق من أعداد الأدوية التالفة والمنتهية الصلاحية بالمقارنة مع التقارير؛ وافصل هذه الأدوية لغرض تدميرها. ٦,٣ قم بتجميع الزجاجات المفتوحة بحسب نوع الدواء، وتأكد من تدوين عبارة "فُتحت في اليوم / الشهر / السنة" بوضوح على الزجاجات المفتوحة مع التوقيع عليها بالحروف الأولى، وتدوين تاريخ انتهاء الصلاحية بلون مختلف. ١,٦,٣ اتبع السياسات الوطنية المتعلقة باستخدام الزجاجات المفتوحة في المستقبل. ٢,٦,٣ أية محاليل فموية معاد تكوينها لا ينبغي حفظها في المخزون بل التخلص منها فوراً. ٣,٦,٣ بالنسبة للأقراص القابلة للمضغ (مثل ميبيندازول)، يكون عمرها التخزيني من شهر إلى شهرين بعد الفتح، ومن ثم لا ينبغي تخزينها لدورة المعالجة الجموعية في العام التالي. ٧,٣ قم بتخزين الأدوية المتبقية الصالحة للاستعمال من أجل دورة المعالجة الجموعية التالية. ٨,٣ حدّث **دفتر الموازنة الخاص بالمخزون**، بما في ذلك أرقام التشغيلات، وأعد أيضاً **تقرير حالة المخزون**.	▪ منسق البرنامج الإقليمي للأمراض المدارية المهملة أو من ينوب عنه ▪ المخزن الطبي المركزي ▪ الناقل (بحسب الاقتضاء)	(١) انظر الفصل ٥: إدارة المخزون انظر الفصل ٦: التخزين انظر الفصل ٧: ما تنتهي صلاحيته أولاً يُصرف أولاً انظر الفصل ١٠: إدارة النفايات

٤,٨ المرجع

١. دليل ادارة الزيثروماكس بالمبادرة الدولية لمكافحة التراخوما 2019 (https://www.trachoma.org/zithromax-management-guide, accessed 18 March 2022).

٩. إزالة الأدوية المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستعمال

١,٩ الغرض من إجراء التشغيل الموحد هذا ونطاقه

يغطي هذا الإجراء الأدوية المنتهية الصلاحية أو غير الصالحة للاستعمال المخزنة في أي مستوى من مستويات النظام الصحي. ويشمل هذا الإجراء إزالة المخزون من المخازن الطبية / المرافق الصحية التي تُخزن فيها الأدوية وتحديث سجلات جرد المخازن / المرافق والبرنامج الوطني للأمراض المدارية المهملة. وهذا الإجراء جزء من إدارة المخزون في البلد من أجل ضمان جودة المنتجات المستخدمة في علاج الأمراض المدارية المهملة، مثل المعالجة الجموعية.

تشمل **الأدوية المنتهية الصلاحية** أي دواء تجاوز تاريخ انتهاء صلاحيته المحدد من المصنِّع والمدوَّن على العبوة. وهذه الأدوية غير مناسبة للتوزيع على أي فئة سكانية تحتاج إلى العلاج.

وتشمل **الأدوية غير الصالحة للاستعمال** ما يلي:

- المخزون التالف (مثل الماء التالف أو الملوث أو المتسرب أو المتعرض لتغيرات في درجة الحرارة لمدة طويلة)؛
- المخزون الذي يُعد عمره التخزيني قصيراً جداً بحيث لا يمكن توزيعه في حملة المعالجة الجموعية التالية، ويشمل:
  - محلول أزيثروميسين الفموي الخاص للأطفال، المتبقي والمعاد تكوينه؛
  - الزجاجات المفتوحة المعبأ بها ميبيندازول القابل للمضغ؛
  - الأدوية الجديدة التي تنتهي صلاحيتها أثناء المعالجة الجموعية.
- الأدوية المفقودة (مثلاً بالضياع أو السرقة) من المخزون؛
- الزجاجات المفتوحة المستردة من السرقة، نتيجة لعدم مراقبة جودتها.

٢,٩ الاعتبارات الرئيسية

عموماً، يُدار المخزون من خلال الإدارة الدورية للمخزون التي تُجرى كل شهر أو ثلاثة أشهر أو كل عام (انظر الإجراء ذا الصلة لإدارة المخزون، في الفصل ٥).

بالنسبة للأدوية المستعملة في العلاج الكيميائي الوقائي، ينبغي أن يساعد هذا الإجراء على ما يلي:

- تأكيد المخزون الصالح للاستعمال في المعالجة الجموعية؛
- منع استعمال الأدوية المنتهية الصلاحية أثناء المعالجة الجموعية؛
- الحد من تكاليف التخزين؛
- التحقق من المخزون المتاح قبل وبعد المعالجة الجموعية لاستخدامه في التنبؤ بالأدوية المطلوبة للعام التالي وتقدير كميتها.

وتشمل أدوات وتقارير الجرد المناسبة ما يلي:

- تقارير / سجلات جرد المخزون، بحسب الاقتضاء؛
- بطاقات المخزون؛
- نماذج طلب تعديل المخزون.

ويُعد الإبلاغ الدقيق عن المخزون إلى برنامج الأمراض المدارية المهملة أمراً ضرورياً في الاتصال بالمنظمة والجهات المانحة والشركاء المنفذين، وفي التخطيط السليم لحملات المعالجة الجموعية القادمة واللاحقة.

٣,٩ إجراء التشغيل الموحد

الوظائف المحددة، وأدوارها، والخطوات التي يجب اتخاذها في هذا الإجراء هي أمثلة توضيحية وينبغي تعديلها بما يناسب السياق السائد في كل بلد.

١,٣,٩ في أي وقت قبل المعالجة الجموعية وأثناءها وبعدها

متى	من	ماذا	كيف
▪ قبل ٣٠ يوماً على الأقل (أي شهر تقويمي واحد) قبل المعالجة الجموعية ▪ بحد أقصى ٢١ يوماً (أي خلال شهر تقويمي واحد) من المعالجة الجموعية ▪ بشكل دوري في المخازن الطبية على المستوى المركزي والإقليمي ومستوى المقاطعة، والمرافق الصحية التي تخزن فيها الأدوية.	▪ موظف (موظفو) المستودع ▪ أمين المخزن / المشرف ▪ صيدلي التوزيع ▪ نقطة الاتصال المعني بالأمراض المدارية المهملة	▪ تحديد المخزون المنتهي الصلاحية أو غير الصالح للاستعمال ▪ استكمال نموذج طلب تعديل المخزون ▪ تقديم تقرير إلى برنامج الأمراض المدارية المهملة	١. الفصل فوراً بين المخزون المتضرر والمخزون الصالح للاستعمال ٢. التواصل مع برنامج الأمراض المدارية المهملة ٣. تحديث سجلات المخازن وجرد المخزون، مثلاً بطاقة المخزون

المهمة	التعليمات	المسؤولية	المراجع
١.	**مراجعة المخزون الفعلي والتقارير** ١,١ مراجعة أحدث سجلات المخزون الفعلي والجرد لتحديد أي مخزون وكميات منتهية الصلاحية أو غير صالحة للاستعمال. – إن كان سجل الجرد الأخير يرجع تاريخه إلى أكثر من ٩٠ يوماً، أجر جرداً جديداً لتحديث السجل. ٢,١ عمليات دخول / خروج البضائع (مثلاً الاستلام والتداول والتعبئة) ينبغي ألا تُجرى أثناء إجراء الجرد.	▪ موظف المستودع ▪ أمين المخزن ▪ الصيدلي	انظر الفصل ٥: إدارة المخزون انظر الفصل ٦: التخزين تقرير / سجل الجرد (الملحق ١٠) نموذج تعديل المخزون (انظر الملحق ١١) بطاقة المخزون (انظر نموذج البطاقة في الملحق ٥)

المهمة	التعليمات	المسؤولية	المراجع
٢.	**الإبلاغ عن المخزون المنتهي الصلاحية وغير القابل للاستعمال، وفصله** ١,٢ لدى تحديد المخزون المنتهي الصلاحية أو غير القابل للاستعمال، يستكمل كاتب المستودع نموذج طلب تعديل المخزون ويقدمه إلى صيدلي التوزيع لاعتماده. ٢,٢ بعد المراجعة والموافقة، يستكمل صيدلي التوزيع عملية تعديل المخزون. ٣,٢ يفصل كاتب المستودع المخزون المنتهي الصلاحية أو غير الصالح للاستعمال عن المخزون الصالح للاستعمال. ٤,٢ يقوم كاتب المستودع بإزالة المخزون المنتهي الصلاحية أو غير الصالح للاستعمال إلى موقع منفصل لتخزينه إلى حين التخلص منه بطريقة آمنة وسليمة. – عندما تكون المساحة محدودة، ينبغي وضع علامات واضحة على المخزون المنتهي الصلاحية أو غير الصالح للاستعمال، ووضعه داخل كرتونة مغلقة مُدون عليها بيانات واضحة لتجنب توزيعها أثناء المعالجة الجموعية أو بعدها. ٥,٢ يحدّث كاتب المستودع بطاقة المخزون – تُزال كميات الأدوية المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستعمال، الموافق عليها، من بطاقة المخزون. – بالنسبة للمخزون المنتهي الصلاحية، يُكتب "EXP" أي منتهي الصلاحية، والرقم المرجعي لنموذج طلب تعديل المخزون في عمود الملاحظات. – بالنسبة للمخزون التالف / غير الصالح للاستعمال، يُكتب "DAM" أي تالف، والرقم المرجعي *لنموذج طلب تعديل المخزون* وتُسجل طبيعة التلف في عمود الملاحظات. – بالنسبة للمخزون المفقود، يُكتب "MIS" أي مفقود والرقم المرجعي لنموذج طلب تعديل المخزون في عمود الملاحظات. ٦,٢ اتبع المبادئ التوجيهية الوطنية المتعلقة بإدارة نفايات الأدوية.	▪ كاتب المستودع ▪ أمين المخزن ▪ الصيدلي	انظر الفصل ٥: إدارة المخزون انظر الفصل ١٠: إدارة النفايات الملحق ١١: نموذج طلب تعديل المخزون الملحق ٥: بطاقة المخزون
٣.	**إبلاغ برنامج الأمراض المدارية المهملة** ١,٣ أبلغ برنامج الأمراض المدارية المهملة عن كميات الأدوية غير الصالحة للاستعمال، مع ذكر التفاصيل ومبرر انتهاء صلاحيتها أو عدم صلاحيتها للاستعمال.	▪ مسؤول المخازن ▪ الصيدلي ▪ مسؤول الاتصال المعني بالأمراض المدارية المهملة	يُرجع إلى تقرير برنامج الأمراض المدارية المهملة

١٠. إدارة النفايات

١,١٠ الغرض من إجراء التشغيل الموحد هذا ونطاقه

يغطي هذا الإجراء عملية التخلص من الأدوية المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستعمال والإرشادات المتعلقة بأساليب التخلص من الزجاجات الفارغة. وينبغي قراءة هذا الإجراء بالاقتران مع إجراء الدورة العكسية للخدمات اللوجستية (الفصل ٨) وإجراء إزالة الأدوية المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستعمال (الفصل ٩).

تساعد إدارة النفايات على منع صرف الأدوية المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستعمال إلى المجتمعات التي تتلقى الخدمات. ومن الضروري تجنب تحويل الأدوية غير الصالحة للاستعمال لأغراض التسويق أو للأسواق غير القانونية.

ولا ينبغي وصف الأدوية المنتهية الصلاحية أو غير الصالحة للاستعمال تحت أي ظرف من الظروف؛ بل يجب تدميرها وإبلاغ منظمة الصحة العالمية بها عن طريق نموذج الإبلاغ المشترك (وإبلاغ المبادرة الدولية لمكافحة التراخوما عن منتجات أزيثروميسين).

وتشمل الأدوية المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستعمال ما يلي:

- جميع الأقراص أو المحاليل الفموية الخاصة بالأطفال من الأدوية المنتهية الصلاحية؛
- جميع الزجاجات التالفة من الأدوية (مثلاً، الزجاجات المثقوبة أو المسرّبة)؛
- جميع الزجاجات المفتوحة من الأدوية القابلة للمضغ أو المعاد تكوينها أو المحاليل الفموية الخاصة بالأطفال المتبقية بعد استكمال حملة المعالجة الجموعية؛
- جميع الأدوية المعبأة في زجاجات غير مدون عليها تاريخ انتهاء الصلاحية أو المثبت عليها لصاقة غير مقروءة.

فإن كانت الأدوية المتبرع بها ينطبق عليها أي من الحالات المذكورة أعلاه، يجب أن يُخطر فوراً مدير البرنامج الوطني للأمراض المدارية المهملة والصيدلي المعني بأدوية الأمراض المدارية المهملة على مستوى التخزين ذي الصلة. وينبغي للموظفين الميدانيين المحددين اتباع الخطوات الضرورية المدرجة في إجراء التشغيل الموحد هذا من أجل تدمير الأدوية تحت توجيه مدير البرنامج الوطني للأمراض المدارية المهملة أو من ينوب عنه.

ولا يتخلف عن حملات المعالجة الجموعية نفايات معدية؛ ومع ذلك يوجد نوعان من النفايات ذات الصلة بالأمراض المدارية المهملة والمعالجة الجموعية، هما:

- **النفايات العادية**، ومنها الزجاجات ومواد التغليف والتعبئة، والقفازات، والكمامات، والأكواب والملاعق المستخدمة أثناء المعالجة الجموعية؛
- **النفايات الصيدلانية**، ومنها الأدوية المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستعمال (مثلاً، التالفة والملوثة). ويُطلق على هذه الأدوية اسم "الأدوية غير القابلة للاستخدام" وينبغي معالجتها وفقاً لتوجيهات حكومة البلد المتعلقة بإدارة النفايات الصيدلانية.

٢,١٠ الاعتبارات الرئيسية

١,٢,١٠ التعاون

يتطلب التخلص من النفايات الصيدلانية عادةً التعاون فيما بين مختلف الإدارات أو الوكالات والوزارات ومستويات الحكومة في البلد. وبحسب وضع كل بلد، قد تكون السلطة المسؤولة عن إدارة النفايات الصيدلانية هي إدارة شؤون الصيدلة في وزارة الصحة، أو هيئة تنظيم الأدوية، أو سلطة إقليمية أو محلية، أو وزارة البيئة. وينبغي لبرنامج الأمراض المدارية المهملة أن يحدد الهيئة التنظيمية المعتمدة والجهات المعنية المناسبة. وينبغي لهذه الجهات المعنية والسلطات، لدى تحديدها، تعيين وتنفيذ الإجراءات الصحيحة التي تكفل الإدارة الآمنة للنفايات الصيدلانية الناتجة عن علاج الأمراض المدارية المهملة.

ومن شأن عدم الوعي بعواقب الإدارة غير المسؤولة لنفايات أدوية الأمراض المدارية المهملة، وعدم تدريب العاملين الصحيين المجتمعيين، بمن فيهم المشرفون على المعالجة الجموعية وموزعو الأدوية في المجتمع، على الإجراءات الصحيحة، أن يؤدي إلى عواقب صحية وخيمة. ولذلك ينبغي للجهات المعنية أن تضمن إبقاء الأدوية المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستعمال بعيداً عن الفئات أو الأفراد غير المأذون لهم باستعمالها، وإعادة هذه الأدوية إلى موقع آمن للتخلص منها بشكل سليم.

ومن الممكن أن يؤدي الاحتفاظ بأدوية الأمراض المدارية المهملة المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستعمال، ولو بشكل منفصل عن الأدوية القابلة للاستعمال، إلى صرف الأدوية غير القابلة للاستخدام من قبل موظفين غير مؤهلين. ويسمح ذلك أيضاً بأن تحتل الأدوية المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستعمال مساحة تخزينية مهمة يمكن أن تُستغل في تخزين أدوية / سلع صحية أخرى.

ومن شأن الإزالة المأمونة للأدوية المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستعمال من مرافق التخزين أن تساعد البرنامج الوطني للأمراض المدارية المهملة على الحد من خطر صرف الأدوية غير القابلة للاستخدام إلى الفئة السكانية المستهدفة. ومن شأن الإزالة المأمونة لهذه الأدوية أن تقي أيضاً من تعرض الصحة العمومية وسمعة البرنامج الوطني للأمراض المدارية المهملة للخطر.

٢,٢,١٠ الإدارة المتكاملة للنفايات

تقترن حملات المعالجة الجموعية، في كثير من الأحيان، بتدخلات صحية أخرى، مثل أيام صحة الطفل أو حملات التطعيم. وفي هذه الحالات، ينبغي أن تحظى إدارة النفايات الناتجة عن البرامج ذات الصلة بنفس القدر من التنسيق الذي يحظى به التخطيط لتنفيذ عملية توزيع الخدمات. ومن شأن ذلك أن يساعد على تقليل التكاليف وتقليل مخاطر التخلص غير السليم من النفايات.

٣,١٠ إجراء التشغيل الموحد

الوظائف المحددة، وأدوارها، والخطوات التي يجب اتخاذها في هذا الإجراء هي أمثلة توضيحية وينبغي تعديلها بما يناسب السياق السائد في كل بلد.

١,٣,١٠ قبل المعالجة الجموعية وبعدها – المستوى الوطني

متى	من	ماذا	كيف
▪ أثناء مراحل التخطيط للمعالجة الجموعية ▪ بعد المعالجة الجموعية	▪ مدير البرنامج الوطني للأمراض المدارية المهملة ▪ مشرفو المعالجة الجموعية ▪ مدير المخزن الطبي المركزي / الإقليمي ▪ صيدلي أدوية الأمراض المدارية المهملة ▪ المنسق الوطني لإدارة النفايات الصحية	▪ التخلص من أدوية الأمراض المدارية المهملة غير القابلة للاستخدام وعبواتها على المستوى الوطني	▪ التخطيط والتدريب ▪ التخلص من أدوية الأمراض المدارية المهملة غير القابلة للاستخدام ومن عبواتها ▪ الإبلاغ عن نفايات أدوية الأمراض المدارية المهملة المتخلص منها

المهمة	التعليمات	المسؤولية	المراجع
١.	**التخطيط والتدريب** ١,١ راجع حزمة الطلبات المشتركة لغرض الإبلاغ المطلوب عن المخزونات المتبقية والمنتهية الصلاحية والمهدرة. ٢,١ راجع السياسة الوطنية لإدارة النفايات الصحية لمعرفة المتطلبات. – حدد مدى انطباق السياسة على أدوية الأمراض المدارية المهملة وعبواتها. ٣,١ ضع خطة لإدارة نفايات أدوية الأمراض المدارية المهملة، بما في ذلك متطلبات الإبلاغ المحددة من المنظمة. – حدد الأشخاص المسؤولين عن تنفيذ واستكمال وعرض عمليات مطابقة مخزون الزجاجات المفتوحة وكذلك الزجاجات المغلقة، والتخزين / إعادة الاستعمال مقابل التدمير، إلى المخزن الطبي المركزي أو الصيدلية المركزية. وينبغي أن يشترك شخصان على الأقل في إجراء الجرد والتحقق من عمليات الحصر. – إن كانت نفايات أدوية الأمراض المدارية المهملة ستُدمر على المستوى الإقليمي، ينبغي التنسيق مع المخازن الطبية الإقليمية من أجل وضع وتنفيذ خطة لإدارة نفايات أدوية الأمراض المدارية المهملة. ٤,١ تأكد من توافر ميزانية كافية لدعم الدورة العكسية للخدمات اللوجستية وإدارة النفايات (بدل السفر، والانتقال، والوقود، وما إلى ذلك) كجزء من تخطيط المعالجة الجموعية. ٥,١ وضع استراتيجيات لتحفيز موزعي الأدوية في المجتمع، أو المدرسين، أو العاملين في المرافق الصحية (بحسب الاقتضاء)، على تجميع ودمج الأدوية المتبقية والأدوية غير القابلة للاستخدام بعد المعالجة الجموعية. ٦,١ خطط جدولاً زمنياً محدداً لكل مرحلة من مراحل إعادة الأدوية. ٧,١ أبلغ عن خطة إدارة نفايات أدوية الأمراض المدارية المهملة إلى منسقي هذه الأمراض ومسؤولي الاتصال ومشرفي المعالجة الجموعية والصيادلة ومديري المخازن الطبية، وغيرهم من أصحاب المصلحة، بحسب الاقتضاء. ٨,١ تأكد من حصول جميع الأشخاص المسؤولين عن توليد أو تداول أو نقل النفايات على التدريب. وينبغي أن يُقدم هذا التدريب كجزء من التدريب على تقديم المعالجة الجموعية.	▪ مدير / منسق برنامج الأمراض المدارية المهملة ▪ صيدلي أدوية الأمراض المدارية المهملة ▪ مدير المخزن الطبي المركزي / الإقليمي	انظر السياسة الوطنية لإدارة النفايات الصحية انظر الفصل ١: حزمة الطلبات المشتركة انظر الفصل ٤: النقل انظر الفصل ٥: إدارة المخزون انظر الفصل ٨: الدورة العكسية للخدمات اللوجستية انظر الفصل ٩: إزالة الأدوية المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستعمال
٢.	**التخلص من الأدوية غير القابلة للاستخدام ومن عبواتها** ١,٢ ضمان التخلص من جميع الأدوية غير القابلة للاستخدام في غضون فترة لا تزيد على شهر بعد استكمال حملات المعالجة الجموعية. ▪ يُنفذ هذا النشاط، في بعض البلدان، من خلال لجنة قائمة أو فريق يتألف من قطاعات مختلفة وعدة ممثلين من القطاع الصحي. وفي هذه الظروف، ينبغي استخدام الآلية القائمة بالفعل وتكييفها بحيث تتضمن برنامج الأمراض المدارية المهملة أو نقاط الاتصال. ▪ اتبع الخطة الموضوعة لإدارة نفايات الأمراض المدارية المهملة، وضمان تنفيذ كل مرحلة على النحو الموثق. ▪ تخلص من الأدوية المنتهية الصلاحية والتالفة وفقاً للمبادئ التوجيهية الحكومية، ووثّق العملية. ٢,٢ أية محاليل فموية معاد تكوينها لأي دواء ينبغي عدم حفظها في المخزون بل التخلص منها فوراً. ٣,٢ بالنسبة للأقراص القابلة للمضغ (مثل ميبيندازول)، يتراوح عمرها التخزيني من شهر إلى شهرين فقط بعد فتح العبوة، ولذلك ينبغي عدم تخزينها لدورة المعالجة الجموعية في العام التالي، بل ينبغي التخلص منها.	▪ مدير / منسق برنامج الأمراض المدارية المهملة. ▪ صيدلي أدوية الأمراض المدارية المهملة ▪ مدير المخزن الطبي المركزي / الإقليمي ▪ المنسق الوطني لإدارة النفايات الصحية (إن وُجد)	انظر الفصل ١: حزمة الطلبات المشتركة انظر الفصل ٤: النقل انظر الفصل ٥: إدارة المخزون انظر الفصل ٦: التخزين انظر الفصل ٧: ما تنتهي صلاحيته أولاً يُصرف أولاً انظر الفصل ٨: الدورة العكسية للخدمات اللوجستية انظر الفصل ٩: إزالة الأدوية المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستعمال انظر الفصل ١١: التنبؤ والتقدير الكمي
٣.	**الإبلاغ عن نفايات أدوية الأمراض المدارية المهملة المتخلص منها** ١,٣ أبلغ عن التخلص من المخزونات التالفة أو المنتهية الصلاحية أو غير القابلة للاستخدام في نموذج الإبلاغ المشترك. ٢,٣ بالنسبة لأقراص أزيثروميسين أو محلوله الفموي الخاص بالأطفال، أبلغ أيضاً عن المخزونات التالفة أو المنتهية الصلاحية أو غير القابلة للاستخدام إلى المبادرة الدولية لمكافحة التراخوما. ٣,٣ قم بمتابعة أي فجوات محددة في عمليات إعادة الأدوية المتبقية، بحيث يتم مطابقة جميع الأدوية (سواء الصالحة أم غير الصالحة للاستعمال) أو الإبلاغ عنها في نموذج الإبلاغ المشترك.	▪ مدير / منسق برنامج الأمراض المدارية المهملة	انظر الفصل ١: حزمة الطلبات المشتركة انظر الفصل ٨: الدورة العكسية للخدمات اللوجستية انظر الفصل ٩: إزالة الأدوية المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستعمال (١)

٢,٣,١٠ بعد المعالجة الجموعية – مستوى المجتمع

متى	من	ماذا	كيف
بعد المعالجة الجموعية مباشرةً	موزعو الأدوية في المجتمع / المدرسون / موظفو المرفق الصحي (بحسب سياق المعالجة الجموعية)	إعادة النفايات إلى المشرف المعيَّن، أو المرفق الصحي، أو المخازن الطبية في المقاطعة	إعادة النفايات العادية والصيدلانية

المهمة	التعليمات	المسؤولية	المراجع
١.	**إعادة النفايات العادية والصيدلانية.** ١,١ تُعاد النفايات العادية والصيدلانية إلى مرفق صحي معين مسبقاً أو إلى المخازن الطبية للمقاطعة (بحسب الوضع في البلد): – ضع علامة على الأدوية المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستعمال؛ – سجل المعلومات المتعلقة بالكمية المعادة، ورقم التشغيلة / الدفعة، وسبب كونها غير قابلة للاستخدام، وما إلى ذلك؛ – قم بتعبئة الأدوية المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستعمال، وتخزينها بمعزل عن المخزون المتبقي الصالح للاستخدام.	▪ موزعو الأدوية في المجتمع ▪ المدرسون / موظفو المرفق الصحي (بحسب سياق المعالجة الجموعية)	انظر الفصل ٨: الدورة العكسية للخدمات اللوجستية انظر الفصل ٩: إزالة الأدوية المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستعمال السياسة الوطنية لإدارة النفايات الصحية الشكل ١,١٠ المثالان ألف وباء

٣,٣,١٠ بعد المعالجة الجموعية – مستوى المشرف

متى	من	ماذا	كيف
في غضون أسبوعين بعد المعالجة الجموعية	▪ مشرف المعالجة الجموعية أو من ينوب عنه ▪ موظف الاتصال المعني بالأمراض المدارية المهملة	▪ جمع النفايات من جميع وحدات تنفيذ المعالجة الجموعية في المنطقة الواقعة في نطاق المسؤولية ▪ التحضير للتخلص منها ▪ الإعادة إلى المستوى المعيَّن	▪ جمع وفصل المخزون المتبقي القابل للاستخدام والمخزون غير القابل للاستخدام (النفايات) ▪ التحضير لإعادته والتخلص منه ▪ إعادة جميع ما جُمع من النفايات إلى مستودع النفايات المعيَّن

المهمة	التعليمات	المسؤولية	المراجع
١.	**جمع وفصل المخزون المتبقي القابل للاستخدام والمخزون غير القابلة للاستخدام (النفايات)** ١,١ حيازة النفايات العادية والصيدلانية الناتجة من جميع وحدات تنفيذ المعالجة الجموعية ٢,١ تجميع جميع النفايات الناتجة من مواقع التوزيع في المنطقة الواقعة في نطاق المسؤولية في مواقع مركزية. ٣,١ فصل الزجاجات الفارغة والمخزون غير القابل للاستخدام عن المخزون المتبقي القابل للاستخدام. ٤,١ إجراء جرد مادي لهذه النفايات.	▪ مشرف المعالجة الجموعية أو من ينوب عنه ▪ موظف الاتصال المعني بالأمراض المدارية المهملة	انظر الفصل ٥: إدارة المخزون انظر الفصل ٨: الدورة العكسية للخدمات اللوجستية الشكل ١,١٠: المثالان ألف وباء

الشكل ١,١٠ تدمير المخزون

المثال ألف: خيارات التدمير

التدمير









اليه الحرق والدفن

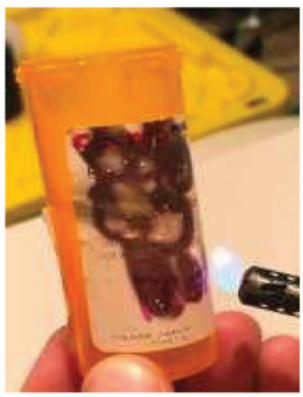
اليه الحرق والدفن

اليه الحرق والدفن



المثال باء: طمس بيانات اللصاقات





المصدر: الرسوم التوضيحية والصور أعدتها Cassandra Holloway

المهمة	التعليمات	المسؤولية	المراجع
٢.	**التحضير لإعادة النفايات والتخلص منها** ١,٢ طمس البيانات المدونة على الزجاجات، وفقاً لسياسة إدارة النفايات في البلد. ويجوز، إن سمحت سياسة البلد، حفظ الزجاجات الفارغة والمطموسة البيانات في المرفق الصحي بالمقاطعة لغرض الاستخدام الشخصي مع إصدار تعليمات بالغسل الجيد للزجاجات من الداخل بالماء والصابون. ٢,٢ تجميع كميات المخزون غير القابل للاستخدام ومعلومات عن ظروفه والتقارير المتعلقة به لإعادته والتخلص منه. ٣,٢ التشاور مع مسؤول الاتصال المعني بالأمراض المدارية المهملة في المنطقة المعينة بشأن الخطوة التالية. ويمكن التخلص من هذا المخزون في الموقع باتباع الأساليب المعتمدة، إن توافرت المرافق اللازمة وسمحت السياسة المتبعة بذلك. ٤,٢ إرسال تقرير إلى مستوى المقاطعة أو الإقليم (بحسب الوضع في البلد) بشأن التخلص من المخزون بالترميد في موعد لا يتجاوز سبعة أيام بعد استكمال المعالجة الجموعية في المنطقة الواقعة في نطاق المسؤولية.	▪ مشرف المعالجة الجموعية أو من ينوب عنه ▪ موظف الاتصال المعني بالأمراض المدارية المهملة	انظر السياسة الوطنية لإدارة النفايات الصحية الشكل ١,١٠: المثال باء
٣.	**إعادة جميع النفايات التي جُمعت إلى المخزن الطبي في الإقليم او المقاطعة أو إلى مستودع النفايات المعيّن** ١,٣ تُحدد الخطوات بحسب سياسة إدارة النفايات الصحية في البلد وخطة إدارة نفايات أدوية الأمراض المدارية المهملة.	▪ مشرف المعالجة الجموعية أو من ينوب عنه	انظر السياسة الوطنية لإدارة النفايات الصحية انظر الفصل ٨: الدورة العكسية للخدمات اللوجستية

٤,٣,١٠ بعد المعالجة الجموعية – مستوى المقاطعة / الإقليم

متى	من	ماذا	كيف
في غضون شهر بعد المعالجة الجموعية	▪ مدير المخازن الطبية في المقاطعة / الإقليم / المقاطعة أو من ينوب عنه ▪ موظف الاتصال المعني بالأمراض المدارية المهملة	جمع جميع كميات المخزون الذي انتهت صلاحيته وغير الصالح للاستعمال المعاد بعد المعالجة الجموعية، والتحضير للتخلص منه أو نقله.	▪ تجميع المخزون غير القابل للاستخدام من مستوى المقاطعات ومستوى ما دون المقاطعات ▪ إعادة جميع النفايات التي جُمعت إلى مستودع النفايات المعيّن ▪ تسجيل المعلومات على النماذج الموحدة وتقديم تقرير إلى الجهات المعنية ذات الصلة

المهمة	التعليمات	المسؤولية	المراجع
٧.	**تجميع المخزون غير القابل للاستخدام من مستوى المقاطعة ومستوى ما دون المقاطعة** ١,٧ ضمان جمع نفايات علاج الأمراض المدارية المهملة من مستوى المقاطعة ونقلها إلى المستوى الإقليمي للتخلص منها أو نقلها إلى المستوى المركزي (بحسب الوضع في البلد) على النحو المحدد في خطة إدارة نفايات علاج الأمراض المدارية المهملة. ٢,٧ تسجيل جميع الكميات وأرقام التشغيلة / الدفعة لكل دواء من أدوية الأمراض المدارية المهملة المقرر التخلص منها، مع تسجيل أسباب التخلص منها؛ والتحقق من الطمس الملائم للبيانات المدونة على جميع الزجاجات. ٣,٧ يُحفظ المخزون المقرر التخلص منه بمعزل عن المخزون القابل للاستخدام، مع التأكد من وضع علامات واضحة عليه. ٤,٧ إن كانت النفايات ستُدمر على مستوى المقاطعة، ينبغي أن يتلقى موظف الاتصال المعني بالأمراض المدارية المهملة في الإقليم التقرير الذي يفيد بأن نفايات المعالجة الجموعية تم تدميرها أو طمس البيانات المدونة عليها، وأنه لا حاجة لاتخاذ أي إجراء آخر. – يُقدم تقرير إلى البرنامج الوطني للأمراض المدارية المهملة لتسجيله في نموذج الطلبات المشتركة.	▪ مدير المخزن الطبي في المقاطعة / الإقليم / المحافظة أو من ينوب عنه ▪ مسؤول الاتصال المعني بالأمراض المدارية المهملة في الإقليم	الملحق ١٢: أمثلة للوثائق الفصل ٨: انظر السياسة الوطنية لإدارة النفايات الصحية انظر خطة إدارة نفايات أدوية الأمراض المدارية المهملة الشكل ١,١٠: المثال باء

المهمة	التعليمات	المسؤولية	المراجع
٨.	**إعادة جميع النفايات المجمعة إلى مستودع النفايات المعيَّن** ١,٨ بدء عملية التخلص من النفايات على النحو المحدد في خطة إدارة نفايات أدوية الأمراض المدارية المهملة. ٢,٨ اتباع المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتخلص من النفايات، وتسجيل جميع الكميات التي تم تدميرها أو طمس البيانات المدونة عليها. ٣,٨ إن كانت النفايات ستُنقل إلى المستوى المركزي، تُسجل جميع الكميات المقرر نقلها ويُعد تقرير إلى المنسق الوطني المعني بالأمراض المدارية المهملة.	المخزن او الشخص الموكل على مستوى المقاطعة / الإقليم / المحافظة	القسم ١,٣,١٠: تداول النفايات العادية والصيدلانية
٩.	**تسجيل المعلومات على النماذج الموحدة وإبلاغ الجهات المعنية ذات الصلة** ١,٩ إن كانت النفايات ستُدمر على المستوى الإقليمي، أعد تقريراً يفيد بأن نفايات أدوية المعالجة الجموعية تم تدميرها أو طمس البيانات المدونة عليها وأنه لا حاجة لأي إجراء آخر. ٢,٩ يُقدم تقرير إلى البرنامج الوطني للأمراض المدارية المهملة لتسجيله في نموذج الطلبات المشتركة.	مسؤول الاتصال المعني بالأمراض المدارية المهملة في الإقليم	الملحق ١٢: أمثلة للوثائق

٥,٣,١٠ تداول النفايات العادية والصيدلانية: إرشادات بشأن أساليب التخلص منها

إدارة الزجاجات الفارغة. ينبغي طمس البيانات المدونة على جميع زجاجات الأدوية الفارغة وذلك بقلم دائم، وغسلها جيداً، إن كانت السياسة الوطنية لإدارة النفايات الصحية تسمح للمجتمع بالاحتفاظ بالزجاجات الفارغة وإعادة استخدامها (الجدول ١,١٠).

وينبغي اتباع أحد الأساليب التالية للتخلص من الأدوية التالفة / المنتهية الصلاحية، مع الالتزام بالسياسة الوطنية لإدارة النفايات (الجدول ٢,١٠).

الجدول ١,١٠ وثائق إدارة النفايات العادية وتدمير هذه النفايات

مستوى الأولوية	الإجراء	الإرشادات
الأول	التخلص	اتباع لوائح وزارة الصحة و/ أو اللوائح البيئية الوطنية في التخلص من حاويات الأدوية، إن وُجدت. وقد يشمل التخلص الترميد في حفرة "حرق ودفن" أو في محرقة درجة حرارتها ٨٠٠ – ١٠٠٠ درجة مئوية (انظر *الشكل* ١,١٠، صور *المثال ألف*). **طريقة التخلص من نفايات أدوية المعالجة الجموعية بالترميد في درجة حرارة متوسطة إلى عالية.** وهذا مهم بشكل خاص لأدوية الأمراض المدارية المهملة التي قد تثير شواغل صحية وبيئية في حال عدم التخلص منها بشكل سليم. وقد لا يكون هذا الخيار متاحاً على المستوى المحلي، ولكن قد يكون من الممكن إعادة النفايات إلى مرفق خارج الموقع يستخدم طريقة الترميد (الحرق عند حرارة ≤ ٨٠٠ – ١٠٠٠ درجة مئوية). **الترميد في فرن أسمنتي محلي، إن وُجد.** من الممكن أن يستخدم الفرن الأسمنتي كميات صغيرة من النفايات (٥٪) كوقود. وتصل حرارة هذه المحارق إلى نطاقات مماثلة من درجات الحرارة. **الإحراق في برميل أو في حفر على درجة حرارة منخفضة**، رغم أنها طريقة غير مثالية، من الممكن أن تحقق مستوى معيناً من الترميد السليم مع تقليل المخاطر البيئية والصحية للنفايات الناتجة من المعالجة الجموعية للأمراض المدارية المهملة. ولكي تُتبع هذه الطريقة، تُجمع النفايات وتوضع في فرن في شكل برميل أو حفرة ثم تُشعل فيها النار. تأكد من وضع النفايات في اتجاه حركة الريح في مناطق العمل أو المناطق السكنية وبعيداً عن أي مصدر للماء. سيحترق الجزء القابل للاشتعال من النفايات في درجة حرارة أقل من ٤٠٠ درجة مئوية، وسينصهر الجزء المتبقي. وعموماً، لا يُوصى بالحرق في درجة حرارة منخفضة لعدة أسباب: أن المواد البلاستيكية والصيدلانية تطلق غازات سامة عند احتراقها، مما يؤدي إلى إطلاق ملوثات في الهواء: لذلك ينبغي أن يكون الإحراق في برميل أو حفرة هو الخيار الأخير لحرق نفايات برنامج الأمراض المدارية المهملة. وينبغي للموظفين المعيَّنين الإشراف على عملية الحرق. وبعد انطفاء الحريق، يُغطى الرماد والمواد المتبقية بالتربة، على النحو المبين أعلاه، من أجل التحضير لعملية الإحراق والدفن التالية. **لا يجوز بتاتاً إزالة أو تحريك الرماد الموجود في حفرة الحرق والدفن.**
الثاني	إعادة الاستخدام	احفظ الزجاجات بغرض الاستخدام الشخصي بعد تنظيفها بشكل سليم وطمس البيانات المدونة عليها باستخدام ولاعة أو قلم دائم. وعادة ما تكون البطاقة الملصقة على أدوية الأمراض المدارية المهملة محكمة الالتصاق ولا يمكن نزعها بسهولة (*انظر الشكل* ١,١٠، صور *المثال باء*).
الثالث	إعادة التدوير	إن كانت الزجاجات لن يعاد استخدامها، أرسلها إلى مرفق لإعادة التدوير، إن وُجد في البلد.

الجدول ٢,١٠ وثائق إدارة النفايات الصيدلانية العادية وتدمير هذه النفايات

ينبغي اتباع إحدى الطرق التالية للتخلص من الأدوية التالفة أو المنتهية الصلاحية، مع الالتزام بالسياسة الوطنية لإدارة النفايات.

مستوى الأولوية	طريقة التخلص	الطريقة
الأول	التخلص	كما هو مبين في *الجدول* ١,١٠
الثاني	طريقة التخلص الموصى بها من المصنِّع	يُضاف الماء إلى المنتج لتبليله بحيث لا يكون صالحاً للاستعمال، ثم يُحرق على النحو المبين في *الجدول* ١,١٠، *المثال ألف*.
الثالث	المبادئ التوجيهية للمنظمة	بالنسبة للأقراص الصلبة، فيما يلي الطرق المناسبة للتخلص منها: ▪ وضع النفايات في حاوية محكمة الغلق من الخرسانة أو الصلب غير القابل للتفاعل أو البلاستيك، ودفنها؛ ▪ الترميد على درجة حرارة متوسطة أو عالية (فرن احتراق أسمنتي؛ انظر *الجدول* ١,١٠، *والشكل* ١,١٠، *المثال ألف*) بالنسبة للمحاليل الفموية الخاصة للأطفال أو الأدوية السائلة الأخرى: ▪ تُخفف بالماء، ثم تُترك عدة أسابيع ثم تفرغ في الصرف الصحي.

١١. التنبؤ والتقدير الكمي

١,١١ الغرض من إجراء التشغيل الموحد هذا ونطاقه

يبين هذا الإجراء العملية السنوية للتقدير الدقيق لكميات أدوية العلاج الكيميائي الوقائي اللازمة للسكان المستهدفين وتحقيق التغطية في البلد، في عام الطلب. ويغطي هذا الإجراء أدوية العلاج الكيميائي الوقائي التي تشكل جزءاً من برنامج المنظمة العالمي للتبرع بأدوية الأمراض المدارية المهملة للبلدان التي تتوطنها هذه الأمراض.

ويشكل التقدير الكمي الخطوة الأولى في عملية التنبؤ.

٢,١١ الاعتبارات الرئيسية

ينبغي أن ينفذ هذه العملية البرنامج الوطني للأمراض المدارية المهملة وأن يخطر بها المكتب الإقليمي للمنظمة. يقوم مكتب المنظمة الإقليمي والمقر الرئيسي للمنظمة، بعد ذلك، بمراجعة التوقعات واستكمالها. ويقوم المقر الرئيسي للمنظمة بإبلاغ المعلومات المتوقعة إلى شركات الأدوية المتبرعة لمساعدتها في خططها الإنتاجية.

تُعد التنبؤات الدقيقة وفي الوقت المناسب بالغة الأهمية في توفير الأدوية المتبرع بها للأمراض المدارية المهملة القابلة للعلاج الكيميائي الوقائي. وتطلب المنظمة التنبؤات القصيرة الأجل من البرامج القطرية من أجل التوفيق بين عمليات التخطيط والإنتاج ووقت الشحن من جانب الشركات المتبرعة بالأدوية لكي تلبي الاحتياجات السنوية من الإنتاج. وتُقدم هذه التنبؤات في سياق الطلب السنوي للأدوية في حزمة الطلبات المشتركة للعام التالي، التي تبين توقعات العامين القادمين.

وتشمل مسؤوليات برنامج الأمراض المدارية المهملة ما يلي:

- جمع وتحليل البيانات الوبائية؛
- تأمين الالتزامات المتعلقة بالتمويل الحكومي و / أو التمويل المقدم من الجهات المانحة، والموارد، والدعم المقدم من الشركاء المنفذين؛
- التحقق من الأهلية للحصول على الأدوية المتبرع بها، والحصول على بيانات دقيقة عن المخزون المتاح، والتخطيط لشراء الأدوية عند الحاجة إليها؛
- ضمان توفر القدرات التقنية والبرنامجية على توزيع الأدوية في البلد.

ويُقدر عدد الأقراص المتوقع وفقاً للمعايير المبينة في *الجدول* ١,١١.

الجدول ١,١١ معايير التنبؤ بالتقدير الكمي للأدوية المتبرع بها للعلاج الكيميائي الوقائي

المعيار	المصدر (المصادر)	الاستخدام
١. مستوى التوطن الراهن في وحدات التنفيذ باستخدام نتائج أحدث استقصاء وبائي (مثلاً، استقصاءات رسم الخرائط الصحية، ونتائج استقصاءات تقدير انتقال المرض، واستقصاءات تقييم الأثر)	التقرير القطري باستخدام نموذج الإبلاغ الوبائي. المنشورات الرسمية وغير الرسمية وتقارير الاستقصاءات أو عروض الاستقصاءات.	قد تشير هذه المعلومات الوبائية إلى أن جزءاً من البلد سيوقف أو يوسع نطاق المعالجة الجموعية في العام التالي. يُقدر عدد الأشخاص المؤهلين لتلقي المعالجة الجموعية بناءً على أحدث البيانات السكانية وانتشار المرض بحسب المقاطعة أو وحدة التنفيذ.
٢. التحقق من وجود خطة لشراء أو تلقي تبرعات من الأدوية من مصادر أخرى.	معلومات من جهات مانحة أخرى أو خطة المشتريات الحكومية	يُطرح المبلغ الملتزم به من التوقعات أو يُحدد المبلغ والمصدر بحيث لا يؤخذ في الحسبان في خطة التبرع بالأدوية الخاصة بالمانحين.
٣. معلومات عن التزام الشركاء الممولين أو المنفذين بدعم البلد	مبلغ التمويل الملتزم به (الدعم المحلي أو المقدم من المانحين) اتفاق قطري مع المانح مذكرة تفاهم رسمية أو معلومات غير رسمية عن المانحين بشأن التمويل المتوقع في العامين القادمين	تشير المعلومات المتعلقة بالالتزام إلى أن جزءاً من البلد سيواصل أو سيوسع أو سيوقف المعالجة الجموعية في العام التالي.
٤. معلومات عن قدرة البلد على توزيع الدواء (القدرة التقنية و/ أو المالية)	بيانات مستمدة من التنفيذ السابق. توافر الموارد البشرية والبنية التحتية للبلد (مثلاً، برنامج الأمراض المدارية المهملة، ودعم الشركاء المنفذين)	تشير المعلومات المتعلقة بالقدرة إلى أن جزءاً من البلد سيواصل أو سيوسع أو سيوقف المعالجة الجموعية في العام التالي.
٥. عدد دورات المعالجة الجموعية اللازمة لكل مرض من أجل مكافحته أو التخلص منه وفقاً للوبائيات الخاصة بالمرض	المبادئ التوجيهية المتعلقة بالعلاج الكيميائي الوقائي ومكافحة انتقال المرض	وفقا لانتشار المرض، قد يختلف تواتر دورات المعالجة الجموعية السنوية والعدد الكلي لهذه الدورات بحسب المرض (مثلاً، البلهارسيات، الديدان الطفيلية المنقولة بالتربة، التراخوما).
٦. النظر في الفئة السكانية المستهدفة، وتقدير الاحتياجات من الجرعات بحسب العمر	المبادئ التوجيهية المتعلقة بالعلاج الكيميائي الوقائي ومكافحة انتقال المرض	يجب حساب متوسط كمية الأدوية من أجل التقدير الكمي لإجمالي الاحتياجات. مثلاً، متوسط الكمية اللازمة من دواء سترات ثنائي ايثيل كاربامازين هو ٢,٥ قرص، ومن دواء ألبيندازول وميبيندازول هو قرص واحد.
٧. العدد التقديري الكلي للأقراص اللازمة في البلد	السكان الذين يحتاجون إلى العلاج الكيميائي الوقائي على أساس ما سبق مضروباً في عدد الأقراص في الجرعة المتوسطة. البيانات الديمغرافية (أعداد السكان والنمو السكاني والاتجاهات الديمغرافية) على مستوى وحدة التنفيذ	يوفر ذلك الحد الأعلى للتبرع. إن كان ذلك لا يتوافق مع طلب البلد، ينبغي للبلد أن يطلب تحديثاً لقاعدة بيانات المنظمة الخاصة بالعلاج الكيميائي الوقائي.

٣,١١ إجراء التشغيل الموحد

الوظائف المحددة، وأدوارها، والخطوات التي يجب اتخاذها في هذا الإجراء هي أمثلة توضيحية وينبغي تعديلها بما يناسب السياق السائد في كل بلد.

١,٣,١١ استكمال الطلب المشترك للحصول على أدوية مختارة: قبل ١٢ شهراً على الأقل من المعالجة الجموعية

متى	من	ماذا	كيف
قبل ١٢ شهراً على الأقل من المعالجة الجموعية	▪ مدير برنامج الأمراض المدارية المهملة ▪ مديرو برامج مكافحة أمراض محددة ▪ مدير الخدمات اللوجستية	▪ جمع وتحليل البيانات ▪ التنبؤ والتقدير الكمي ▪ تقديم طلب مشترك دقيق ومستكمل، موقَّع من وزارة الصحة	١. الاتصال بالجهات صاحبة المصلحة لكي تقدم بيانات لغرض التحليل. ٢. تنزيل واستكمال متطلبات الطلب المشترك. ٣. توقيع الطلب المشترك وتقديمه إلى المقر الرئيسي للمنظمة والمكتب الإقليمي للمنظمة.

المهمة	التعليمات	المسؤولية	المراجع
١.	**جمع كل البيانات اللازمة لإدراجها في الطلب المشترك (على النحو المبين في الجدول ١,١١).**	▪ مدير برنامج الأمراض المدارية المهملة ▪ مدير الخدمات اللوجستية ▪ الشركاء المنفذون لبرامج الأمراض المدارية المهملة ▪ مديرو برامج مكافحة أمراض محددة ▪ المنسق الوطني لبرامج المنظمة	انظر : المعلومات الديمغرافية بيانات رسم خرائط الأمراض نظام المعلومات الالكتروني الوطني لإدارة اللوجستيات (أو النظام المكافئ له الذي يسجل مخزون أدوية العلاج الكيميائي الوقائي للأمراض المدارية المهملة في البلد) مصادر أخرى للأدوية، إن وُجدت في البلد معلومات الاتصال في المكتب الإقليمي للمنظمة
	١,١ تُطلب البيانات المطلوبة من جميع مديري البرامج الخاصة بأمراض محددة ومن الشركاء المنفذين. وينبغي أن تتضمن البيانات (على سبيل المثال لا الحصر) ما يلي: ▪ مستوى التوطن الراهن في وحدات التنفيذ باستخدام نتائج أحدث استقصاء وبائي (مثلاً، استقصاءات رسم الخرائط الصحية، ونتائج استقصاءات تقدير انتقال المرض، واستقصاء تقييم الأثر) ▪ عدد دورات المعالجة الجموعية اللازمة لكل مرض لأغراض مكافحة المرض / التخلص منه، وفقاً للوبائيات الخاصة بكل مرض. ▪ السكان المستهدفون والاحتياجات من الجرعة بحسب العمر .		
	٢,١ تطلب بيانات المخزون المتاح من المخازن الطبية المركزية وجميع المخازن الطبية دون الوطنية الأخرى التي تُخزن بها أدوية العلاج الكيميائي الوقائي للأمراض المدارية المهملة. وينبغي تسجيل بيانات مخزون الأدوية المتبقية في نظام المعلومات الإلكتروني لإدارة اللوجستيات و / أو الحصول عليها من جميع المستويات من موظفي الاتصال المعنيين بالأمراض المدارية المهملة.		انظر الفصل ١: حزمة الطلبات المشتركة انظر الفصل ٥: إدارة المخزون انظر الفصل ٨: الدورة العكسية للخدمات اللوجستية
	٣,١ الدعوة إلى عقد اجتماع مع الجهات المعنية من أجل مراجعة البيانات.		
٢.	**استكمال العملية السنوية للتنبؤ بطلب البلدان والتقدير الكمي له**	▪ مدير برنامج الأمراض المدارية المهملة ▪ مدير الخدمات اللوجستية	انظر تقرير / نتائج التقدير الكمي انظر الفصل ١: حزمة الطلبات المشتركة
	١,٢ قم بتنزيل نموذج الطلب المشترك المناسب (نموذج Microsoft Excel) من موقع المنظمة الشبكي، أي النموذج المتوافق مع لغتك المحلية ومستوى توطن الأمراض المدارية المهملة في بلدك.		
	٢,٢ استكمل النموذج بأحدث البيانات الوبائية وأحدث بيانات مخزون الأدوية في بلدك.		
	٣,٢ قم بإعداد التوقعات السنوية لكمية الأدوية المطلوبة لكل مرض، بالتعاون مع نقاط الاتصال المعنيين بالأمراض في المكتب الإقليمي للمنظمة.		
	٤,٢ أكمل معلومات المرسل إليه في علامة التبويب الخاصة بالشحنة		
	٥,٢ الحصول على توقيع ممثل وزارة الصحة المختص مع تسجيل التاريخ على النموذج		

المهمة	التعليمات	المسؤولية	المراجع
٣.	**تقديم النموذج المستكمل والموقَّع إلى المقر الرئيسي للمنظمة، والمكتب الإقليمي للمنظمة، مع تقديم نسخة إلى الممثل القطري للمنظمة** ١,٣ التأكد من أن الطلب المشترك يتضمن نموذج الإبلاغ المشترك ونموذج إبلاغ البيانات الوبائية. ٢,٣ التأكد من أن المرسل إليه والمخزن الطبي المركزي على علم بالوثائق المقدمة وعلى استعداد لاستلام الأدوية عند وصولها	▪ مدير برنامج الأمراض المدارية المهملة ▪ المنسق الوطني لبرامج المنظمة	انظر الفصل ١: حزمة الطلبات المشتركة انظر الفصل ٦: التخزين
٤.	**حفظ وتحديث السجلات من أجل عمليات التقديم المستقبلية** ١,٤ احفظ التوقعات (لمدة ٢ – ٣ سنوات) محلياً، وحدِّثها سنوياً كجزء من عملية تقديم حزمة الطلبات المشتركة	▪ مدير برنامج الأمراض المدارية المهملة	انظر الفصل ١: حزمة الطلبات المشتركة

الملحق ١. فهرس المصطلحات والمختصرات الرئيسية

يقدم هذا الفهرس تعريفات موجزة للمصطلحات والمختصرات المستخدمة في الوثيقة؛ وقد تكون لها معانٍ مختلفة في سياقات أخرى.

خطة العمل السنوية

النموذج الذي يقدم معلومات عن العلاج الكيميائي الرئيسي والأنشطة الجانبية الرئيسية من جانب وزارات الصحة لأغراض التخطيط (انظر **حزمة الطلبات المشتركة**).

رقم التشغيلة أو رقم المراقبة أو رقم الدفعة

أي مزيج مميز من الحروف أو الأرقام أو الرموز، أو أي مزيج من كل ذلك، يمكن منها تحديد التاريخ الكامل لإنتاج ومعالجة وتعبئة وتداول وتوزيع أي تشغيلة أو دفعة من منتج طبي أو مادة أخرى (١). ويُسجل هذا الرقم في قائمة التعبئة والفاتورة وعلى لوح التحميل.

تالفة DAM ("أدوية تالفة")

تدوينة على بطاقة المخزون لتسجيل المخزون التالف أو غير الصالح للاستعمال

مذكرة تأكيد التسليم

وثيقة تصاحب شحنة البضائع وتنص على قائمة المنتجات وكمية البضائع المدرجة في عملية التسليم

غرامة التأخير

الرسوم اليومية المقدرة على الحاويات الموجودة في الميناء إلى حين التخليص الجمركي على الشحنة واستلامها من قِبَل المرسل إليه. وتُتاح للشحنة فترة سماح (إعفاء) محددة للتخزين في الميناء دون دفع رسوم، تُحسب بالأيام، قبل بدء فرض الرسوم. وتعتمد فترة السماح هذه على شركة الشحن ونقطة الدخول (في الولايات المتحدة، مثلاً، تُحدد مدة الإعفاء بأربعة أيام بالنسبة للحاويات الجافة ويومين للحاويات المبرَّدة).

رسوم الناقل الداخلي للحاويات الفارغة

الرسوم المقدرة على الوقت المحسوب بالساعات الذي ينتظره السائق لتفريغ البضاعة في مستودع. تُتاح للشحنة مدة سماح محدودة مقدرة بالساعات قبل تقدير الرسوم المفروضة. وتعتمد مدة السماح على شركة الشحن البحري ونقطة الدخول.

رسوم شركة الشحن البحري للحاويات الفارغة

الرسوم اليومية المفروضة على الحاويات خارج الميناء إلى حين إعادة الحاوية من قِبَل الناقل الداخلي إلى شركة النقل البحري. وتُتاح للشحنة مدة سماح محدودة مقدرة بالأيام قبل تقدير الرسوم. وتعتمد مدة السماح على شركة الشحن البحري ونقطة الدخول.

تجميع الأدوية

عملية جمع الأدوية المتبقية من نفس المستوى (مثلاً، من نقاط توزيع متعددة لغرض المعالجة الجموعية)، وتجميعها في حزم وحصر عددها ثم نقل الحزم إلى المرحلة التالية في عملية إعادة الأدوية.

جدول توزيع الأدوية

الجدول الذي يتضمن خطة نقل الأدوية على أساس الكميات المطلوبة من الإقليم والمقاطعة.

عملية إعادة الأدوية

نقل الأدوية من نقطة التوزيع (أدنى مستوى) إلى التخزين الطويل الأجل أو نقطة التدمير (أعلى مستوى)

تحويل (نقل) الأدوية

نقل الأدوية بين المرافق من نفس المستوى (مثلاً، بين نقاط التوزيع أثناء المعالجة الجموعية).

نظام المعلومات الالكتروني لإدارة اللوجستيات (eLMTS)

نظام المعلومات الإلكتروني لإدارة اللوجستيات، المستخدم لإدارة نظم سلاسل الإمداد الحكومية في البلد.

نموذج الإبلاغ الوبائي

نموذج يساعد البلدان في إبلاغ المعلومات الوبائية، بما في ذلك التوزيع المنسق للأدوية (انظر **حزمة الطلبات المشتركة**).

منتهية الصلاحية EXP ("الأدوية المنتهية الصلاحية")

تدوينة على بطاقة المخزون لتسجيل المخزون المنتهي الصلاحية.

ما تنتهي صلاحيته أولاً يُصرف أولاً

الطريقة المتبعة لتنظيم المخزون، بما في ذلك الأدوية، بحسب تاريخ انتهاء الصلاحية وصرف المخزون الأقرب في تاريخ انتهاء صلاحيته بغض النظر عن تاريخ الاستلام. وتختلف هذه العملية عن عملية "الوارد أولاً يُصرف أولاً"، لأن الأدوية المتبقية قد تُعاد من الميدان وتخزن لغرض المعالجة الدوائية الجموعية في المستقبل؛ وقد تكون لهذه الأدوية تواريخ انتهاء صلاحية أحدث من المخزون المستلم أو المنقول مؤخراً. فالذي يُعتد به هو تاريخ انتهاء الصلاحية لا تاريخ الاستلام.

الوارد أولاً يُصرف أولاً

الطريقة المتبعة لضمان أن يكون المخزون الذي يدخل المخازن الطبية أو الصيدليات أولاً هو الذي يُباع أولاً. ولا تأخذ هذه الطريقة في الاعتبار عمر المنتج أو المدة التي قضاها في البلد. وبالنسبة للأمراض المدارية المهملة، فإن النهج القياسي هو ما تنتهي صلاحيته أولاً يصرف أولاً.

مثال: إذا استلم مرفق تخزين (على أي مستوى) في ١ نيسان / أبريل شحنة ألبيندازول تنتهي صلاحيتها في أيلول / سبتمبر ٢٠٢٣، ينبغي تخزين هذه الشحنة خلف ألبيندازول المتبقي الذي ورد من الميدان في ٣٠ حزيران / يونيه وتنتهي صلاحيته في أيلول / سبتمبر ٢٠٢٢. فالمخزون الذي وصل في ٣٠ حزيران / يونيه ورد في وقت لاحق ولكن تنتهي صلاحيته في وقت أسبق. وينبغي دائماً تخزين المخزون الذي تنتهي صلاحيته في وقت لاحق خلف المخزون من نفس المنتج الذي تنتهي صلاحيته في وقت أسبق.

الوارد أولاً يُصرف آخراً

الإجراء الذي بموجبه يجري تحميل الطلب الأخير أولاً، ثم الطلب قبل الأخير، وهكذا، على أن يوضع الطلب الذي سيُسلم أولاً في الجزء الخلفي من الشاحنة.

إدارة المخزون

عملية طلب المخزون وتخزينه واستخدامه، وكذلك حفظ هذه البنود في المستودعات ومعالجتها.

الفاتورة

وثيقة تجارية مختومة الوقت تحدد وتسجل بنود الصفقة وتسجلها.

حزمة الطلبات المشتركة

نظام تقوده منظمة الصحة العالمية تطلب البلدان من خلاله الأدوية المتبرع بها من شركات الأدوية لعلاج الأمراض المدارية المهملة القابلة للعلاج الكيميائي الوقائي. وتشمل الحزمة أربعة نماذج، هي: نموذج الطلب المشترك لأدوية مختارة، ونموذج الإبلاغ المشترك، ونموذج الإبلاغ الوبائي، وخطة العمل السنوية.

نموذج الإبلاغ المشترك

نموذج لمساعدة البلدان في الإبلاغ عن التقدم السنوي المحرز في التوزيع المتكامل والمنسق للأدوية التي تعالج أدوية مختلفة في سنة الإبلاغ في شكل موحد (انظر **حزمة الطلبات المشتركة**).

الطلب المشترك لأدوية مختارة

نموذج لمساعدة البلدان في طلب الحصول على ألبيندازول، وسترات ثنائي ايثيل كاربامازين، وميبيندازول، وإيفرمكتين، وبرازيكوانتيل، لاستعمالها في السنة التالية لسنة تقديم الطلب (**انظر حزمة الطلبات المشتركة**)

المعالجة الدوائية الجموعية (المعالجة الجموعية)

توزيع الأدوية على جميع سكان مكان إداري معين (مثلاً، ولاية أو منطقة أو محافظة أو مقاطعة أو مقاطعة فرعية أو قرية). وفي هذه الوثيقة، يُستخدم مصطلح المعالجة الدوائية الجموعية ومصطلح العلاج الكيميائي الوقائي بشكل تبادلي.

الأدوية المفقودة (MIS)

تدوينة لتسجيل الأدوية المفقودة من المخزون.

الأمراض المدارية المهملة

مجموعة متنوعة من ٢٠ مرضاً ومجموعة مرضية تؤثر بشكل غير متناسب على الفئات السكانية التي تعاني من الفقر، لاسيما التي تعيش في المناطق المدارية ودون المدارية. وهي تفرض عبئاً إنسانياً واجتماعياً واقتصادياً مدمراً على أكثر من مليار شخص في العالم. وتشمل هذه الأمراض قرحة بوروليِ؛ ومرض شاغاس؛ وحمى الدنك والشيكونغونيا؛ وداء التنينات؛ وداء المشوكات؛ وداء الديدان المثقوبة المنقولة بالأغذية؛ وداء المثقبيات الأفريقي البشري؛ وداء الليشمانيات؛ والجذام؛ والفيلاريات اللمفية؛ والورم الفطري؛ وداء الفطريات الاصطباغية وغيرها من الأمراض الفطرية العميقة؛ وداء كلابية الذنب؛ وداء الكَلَب؛ والجَرَب والأمراض الطفيلية البرَّانية الأخرى؛ والبلهارسيات؛ والتسمم الناجم عن لدغ الثعابين؛ والديدان الطفيلية المنقولة بالتربة؛ وداء الشريطيات وداء الكيسات المذنبَّة؛ والتراخوما؛ والداء العليقي.

الزجاجات المفتوحة

محتويات الزجاجات التي لم تستعمل بكاملها في نهاية المعالجة الدوائية الجموعية. ويكون لكل دواء عمر تخزيني مختلف بمجرد فتح الزجاجة، وينبغي معاملتها على أساس كل دواء وفقاً لتوصيات الشركة المصنِّعة وتاريخ فتح الزجاجة المدون بوضوح على الزجاجة / الحاوية.

الجرد الدوري

جرد المخزون بشكل شهري أو ربع سنوي أو نصف سنوي أو سنوي بحسب الممارسة المعتادة على مستوى مستودعات محددة في البلد.

الجرد المادي

عملية حصر المخزون ومطابقة سجلات المخزون.

نموذج الجرد المادي

نموذج تسجيل نتائج عملية مطابقة المخزون، وتسجيل الاختلاف في الكميات، وأسباب ذلك.

العلاج الكيميائي الوقائي

الاستخدام الواسع النطاق للأدوية، إما منفردة أو مجتمعة، في سياق تدخلات الصحة العمومية. وتعد المعالجة الدوائية الجموعية شكلاً من أشكال العلاج الكيميائي الوقائي؛ وقد تقتصر الأشكال الأخرى على فئات سكانية معينة، كالأطفال في سن المدرسة والنساء في سن الإنجاب. وفي هذه الوثيقة، يُستخدم مصطلح العلاج الكيميائي الوقائي ومصطلح المعالجة الدوائية الجموعية بشكل تبادلي.

إثبات التسليم

الوثيقة الموقعة من المستلم لتأكيد تسليم الشحنة في حالة جيدة.

قسيمة الاستلام

وثيقة المعاملات التي تشكل سجلاً دائماً للأدوية المستلمة من المخزن الطبي المركزي أو الإقليمي.

حفظ السجلات

يُسجل الجرد المادي للمخزون على نموذجين مهمين، هما: بطاقات المخزون ونماذج التحويل. وينبغي لمرافق التخزين استخدام كلا النموذجين لتسجيل المخزون الحالي وتاريخ جميع المعاملات أو التسويات (أي الاستلام والصرف والتوزيع ومطابقة المخزون).

الدورة العكسية للخدمات اللوجستية

عملية إعادة الإمدادات الفائضة القابلة للاستخدام، بما في ذلك الأدوية و/ أو الإمدادات المنتهية الصلاحية أو التالفة من المستويات الدنيا إلى المستوى التالي في سلسلة الإمداد، لتسهيل إعادة التوزيع إلى الأماكن المحتاجة إلى الأدوية أو التي ينبغي التخلص فيها من الأدوية إن كانت تالفة و/ أو منتهية الصلاحية.

استراتيجية الجراحة والمضادات الحيوية ونظافة الوجه وتحسين البيئة (SAFE)

الجراحة والمضادات الحيوية ونظافة الوجه وتحسين البيئة من أجل القضاء على التراخوما كمشكلة صحية عمومية.

العمر التخزيني

الفترة الزمنية التي يمكن تخزين المادة في حدودها مع احتفاظها بخصائص صلاحية استخدامها.

بطاقة المخزون

البطاقة التي تُسجل فيها تحديداً عمليات استلام وصرف وتسوية الأدوية المخزنة في موقع معين، وذلك عموماً لتتبع أرصدة الأدوية المخزنة.

بطاقة دفتر الموازنة الخاص بالمخزون

تُعرف أيضاً باسم "بطاقة الموازنة"، وهي البطاقة التي تُسجل بها جميع عمليات استلام وصرف المخزون من مخزن الصيدلية / إدارة المخازن.

تقرير الاختلاف (التباين) في الكميات الموردة

أداة للإبلاغ عن الاختلاف في الكميات المشحونة أو المعبأة، الذي يُعزى إلى الشاحن (بما في ذلك مصادر حكومة الولايات المتحدة والمقاولون / المصنعّون / البائعون)، ولتقديم استجابات وحلول مناسبة، منها الإجراءات المالية عند الاقتضاء. والغرض من تبادل تقرير الاختلاف في الكمية الموردة هو تحديد سبب هذا الاختلاف، واتخاذ الإجراء التصحيحي، ومنع تكرار ذلك.

نموذج رصد التخلص من التراخوما

نموذج صممته المبادرة الدولية لمكافحة التراخوما لمساعدة البلدان في طلب الحصول على أزيثروميسين (Zithromax®) ولرصد التقدم المحرز نحو القضاء على التراخوما كمشكلة صحية عمومية.

نموذج التحويل (النقل)

نموذج لتسجيل تفاصيل حركات المخزون من موقع إلى آخر.

استقصاء تقييم انتقال العدوى

استقصاء مصمم لقياس ما إذا كانت وحدات التقييم خفضت معدل انتشار العدوى الفيلارية إلى مستوى يُستبعد معه تكرار حدوث العدوى، ولو في غياب تدخلات المعالجة الدوائية الجموعية.

بوليصة الشحن

الوثيقة التي يعدها ناقل شحنة من البضائع، والتي تتضمن تفاصيل الشحنة والمسار والرسوم.

المراجع

١. قوانين اللوائح الفيدراليه حسب التحديث الأخير فيما بعد Oct 17, 2023. https://www.ecfr.gov/current/title-21

الملحق ٢. نموذج قائمة الاتصال

صحيفة الاتصال بشأن [اسم الدواء]

جهات الاتصال الصيدلانية بشأن الشحن:

تضاف الأسماء المناسبة بحسب الاقتضاء. تُؤكد قائمة الاتصال مع المنظمة.

المعلومات المبدئية

تضاف الأسماء المناسبة بحسب الاقتضاء. تُؤكد قائمة الاتصال مع المنظمة.

معلومات الاتصال / التسليم:

تُرسل إلى / تُسلم إلى:

المستورد المسجل:

المسار / الإخطار:

الملحق ٣. القائمة التفقدية (المرجعية) لبنود الإجراءات والضوء الأخضر

الإجراء	المسؤول
١. مراجعة قائمة الاتصال للتأكد من دقتها واكتمالها.	
٢. تأكيد صحة متطلبات وثائق الشحن.	
٣. مراجعة بنود القائمة التفقدية للضوء الأخضر ألف وباء وجيم. أجب بـ "نعم" عندما تكون مستعداً.	

القائمة التفقدية للضوء الأخضر لشحن الأدوية		المسؤول	نعم / لا
ألف. الاتصال	هل موظفو الجمارك على علم بالشحنة وكميتها؟		
باء. الإعفاء من الرسوم الجمركية	هل تم الإعداد للإعفاء من الرسوم الجمركية؟		
جيم. التخليص الجمركي وتكاليف المناولة	هل تتوفر الأموال لدفع تكاليف التخليص الجمركي والمناولة للشحنة الواردة؟		
دال. مساحة المستودع	هل تتوفر في المخزن الطبي المركزي مساحة لاستلام الشحنة؟		
هاء. التوزيع	هل البلد مستعد لتوزيع الأدوية؟		

الملحق ٤. نموذج تحويل (نقل) المخزون

عينة نموذج نقل المخزون

نموذج نقل المخزون

الرقم التسلسلي للنموذج: _____
التاريخ: _____

المنشأ:
الوجهة: _____

اسم وعنوان الناقل / الشخص المسؤول:

_____

_____

قائمة بنود النقل: (تُستكمل في المنشأ)

البند	عدد الكرتونات	عدد الزجاجات	الكمية الكلية المشحونة في حالة جيدة (بعدد الزجاجات)
[أدخل اسم الدواء]			
[أدخل اسم الدواء]			

القائم بالصرف: الناقل:

(ينبغي استكمال القسم التالي في الوجهة المقصودة)

قائمة الكمية المستلمة في حالة جيدة:

البند	عدد الكرتونات	عدد الزجاجات	الكمية الكلية المشحونة في حالة جيدة (بعدد الزجاجات)	التالفة / المفقودة (بعدد الزجاجات)	الكمية الكلية المستلمة في حالة جيدة (بعدد الزجاجات)
[أدخل اسم الدواء]					
[أدخل اسم الدواء]					

ملاحظة بشأن الكمية التالفة / المفقودة (إن وُجدت)

القائم بالصرف: الناقل:

الملحق ٥. نموذج بطاقة المخزون

اسم الدواء :

بطاقة المخزون

موقع التخزين:

وحدة التخزين:

التاريخ (اليوم/ الشهر/ السنة)	الرقم التسلسلي لنموذج النقل	المنشأ / الوجهة	الكمية المستلمة (بالزجاجات)	الكمية المنصرفة (بالزجاجات)	الفاقد / التسويات (بالزجاجات)	الكمية المتاحة (بالزجاجات)	ملاحظات	توقيع مسؤول المخزن

الملحق ٦. نموذج استمارة جرد المخزون الفعلي

عينة نموذج جرد المخزون الفعلي

نموذج جرد المخزون الفعلي

رقم الصحيفة:		التاريخ:	
القائم بالجرد:		الإدارة:	

رقم بند المخزون	وصف البند	ثمن الشراء	الكمية	الموقع

التوقيع	
توقيعك	

الملحق ٧. نموذج بطاقة دفتر الموازنة الخاص بالمخزون

البند:	حجم الوحدة / العبوة:	رقم البطاقة:
التركيز / الحجم:		الرمز:
المستوى الأقصى:	مستوى المخزون الاحتياطى:	المهلة:
المستوى الأدنى:	كمية الطلب:	

التاريخ	ورد من / منصرف إلى	العدد الوارد	العدد المنصرف	الرصيد الجديد	ملاحظات	التوقيع

المصدر: شراء وإدارة اللوازم والمعدات In: Kaur M, Hall S. Medical supplies and equipment for primary health care. Surrey (UK): ECHO International Health Services Ltd; 2001:13–28 (http://www.frankshospitalworkshop.com/organisation/management_documents/Medical%20Supplies%20and%20Equipment%20for%20Primary%20Health%20Care%20-%20ECHO.pdf, accessed 18 March 2022).

الملحق ٨. نموذج استمارة إعادة / نقل الأدوية

النص الوارد بالأحمر لغرض التوضيح

الخطوة	الإجراء	نقطة البيانات
١.	**الولاية / الإقليم /المقاطعة التي ينشأ منها النقل**	
٢.	**نقطة توزيع أدوية المعالجة الجموعية في المقاطعة التي ينشأ منها النقل**	
٣.	**المرفق المتلقي للأدوية:** اكتب اسم المرفق الذي ستعاد / ستنقل إليه الأدوية في هذه المرحلة	**المرفق المتلقي للأدوية:** المرفق الصحي في الخط الأمامي / المنطقة الحكومية المحلية / المخزن الطبي المركزي في الولاية
٤.	**المرفق الذي يعيد / ينقل الأدوية:** اكتب اسم المرفق الذي يعيد أو ينقل الأدوية	**المرفق الذي يعيد / ينقل الأدوية:** مثلاً، مركز الصحة العامة في مدينة Ibeto، أو المخزن الطبي في مقاطعة Kontagro، أو المخزن الطبي المركزي
لكل دواء يجرى إعادته أو نقله:		
٥.	**وصف البند، وتركيز وشكل الجرعة:** اكتب اسم ووصف الدواء.	**وصف البند، وتركيز وشكل الجرعة:** أقراص زيثروماكس ٢٥٠ مغم
٦.	**الوحدة:** اكتب أصغر وحدة قياس للدواء.	**الوحدة:** قرص ، كبسولة، زجاجة، أنبوبة، وما إلى ذلك
٧.	**رقم التشغيلة:** اكتب رقم تشغيلة الدواء الذي تجرى إعادته / نقله.	**رقم التشغيلة:** EPA22221
٨.	**تاريخ انتهاء الصلاحية:** اكتب تاريخ انتهاء صلاحية الأدوية التي تجري إعادتها / نقلها.	**تاريخ انتهاء الصلاحية:** كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٢٤ أو ٢٠٢٤/١٢

الخطوة	الإجراء	نقطة البيانات
.٩	**الكمية التي تجرى إعادتها / نقلها:** اكتب كمية الأدوية التي تجرى إعادتها / نقلها.	**الكمية التي تجرى إعادتها / نقلها:** ٦٠٠ قرص أو كبسولة أو أنبوبة أو زجاجة
.١٠	**سبب الإعادة / النقل:** اكتب سبب إعادة المنتج.	**سبب الإعادة / النقل:** تالف أو انتهت صلاحيته أو غير مستخدم أو لإعادة التوزيع
.١١	**المسؤول عن إعادة / نقل البنود:** يسجل الشخص المسؤول عن إعادة / نقل الأدوية اسمه وتوقيعه ورقم هاتفه المحمول والتاريخ.	محمد أمين، ,٠٨٠xxxxxxxxxx ، ٢٠١٩/١١/١٦
.١٢	**الموظف الذي يوافق على إعادة / نقل البنود:** يسجل الشخص الذي يوافق على إعادة / نقل البنود اسمه وتوقيعه ورقم هاتفه المحمول والتاريخ.	موسى يعقوب،,٠٨٣xxxxxxxxxxx ، ٢٠١٩/١١/١٦
.١٣	**الناقل:** يسجل السائق الذي ينقل الأدوية اسمه وتوقيعه ورقم هاتفه المحمول والتاريخ ورقم تسجيل السيارة.	ناثان ياو،,٠٦٠xxxxxxxxxxx ، ٢٠١٩/١١/١٦، BDG 114 XY
.١٤	**المرفق المستلم للأدوية:** يسجل الشخص الذي يتسلم الأدوية المعادة / المنقولة اسمه وتوقيعه ورقم هاتفه المحمول والتاريخ.	آمي إيدو،,٠٩٠xxxxxxxxxxx ، ٢٠١٥/١١/١٧
.١٥	**الشاهد على الاستلام:** يسجل الشخص الشاهد على استلام الأدوية المعادة / المنقولة اسمه وتوقيعه ورقم هاتفه المحمول والتاريخ.	جاسمين ريوتا،، ,٠٨٩xxxxxxxxxxx ٢٠١٥/١١/١٩
.١٦	**ملاحظات:** يسجلها الموظف المستلم للأدوية للإقرار بكمية وحالة الأدوية المعادة.	مثلاً، كاملة، غير كاملة، دون بطاقة البيانات، معبأة بشكل غير سليم

الملحق ٩. الأدوات المساعدة على استكمال نموذج إعادة / نقل الأدوية

يمكن استخدام هذه الأدوات المساعدة على العمل في استكمال نموذج إعادة أو نقل أدوية الأمراض المدارية المهملة من مستوى إلى آخر.

وهذا النموذج هو بمثابة سجل معاملات ينبغي استكماله في أربعة نسخ. ولدى استكمال هذا النشاط، تُوزع النسخ على النحو التالي:

- النسخة البيضاء إلى مرفق الاستلام؛
- النسخة الصفراء إلى مرفق إعادة / نقل الأدوية؛
- النسخة الخضراء إلى الناقل؛
- النسخة الزرقاء يحتفظ بها مرفق إعادة / نقل الأدوية.

الأدوات المساعدة على العمل

المهمة: استكمال نموذج إعادة / نقل أدوية الأمراض المدارية المهملة

تُستكمل من قِبَل:

- الموظف المسؤول على مستوى توزيع أدوية الأمراض المدارية المهملة / في المجتمع المسؤول عن إعادة أو نقل الأدوية؛
- الموظف الذي يوافق على إعادة أو نقل الأدوية؛
- الشخص المسؤول عن نقل الأدوية؛
- الشخص الذي يتسلم الأدوية؛
- الشخص الشاهد على المعاملة.

الغرض: تتبع عملية إعادة أو نقل أدوية الأمراض المدارية المهملة.

متى تؤدى هذه المهمة: في كل مرة تعاد أو تنقل فيها أدوية الأمراض المدارية المهملة من أي مستوى.

المواد / الأدوات اللازمة: نموذج فارغ خاص بإعادة / نقل أدوية الأمراض المدارية المهملة، وآلة حاسبة، ومسطرة مترية، وقلم.

وتكتمل هذه المهمة عندما:

- تكتمل عملية تسجيل أسماء مرافق الولاية أو المقاطعة أو المرفق الصحي التي أُرسلت إليها الأدوية والمرفق الذي أعاد أو نقل الأدوية؛
- يتم التوصيف الكامل للدواء المعاد أو المنقول برقم التشغيلة، وتاريخ انتهاء الصلاحية، وتسجيل الكمية المعادة / المنقولة، وذكر سبب / أسباب المعاملة؛
- يوقع الشخص الذي أعاد الأدوية أو نقلها على النموذج؛
- يوقع الناقل على النموذج؛
- يوقع الموظف الذي له صلاحية الموافقة على النموذج؛
- يوقع الشاهد على المعاملة على النموذج؛
- يوقع الموظف المستلم للأدوية على النموذج؛
- تُعاد نسخة موقعة من النموذج إلى المرفق الذي أعاد أو نقل الأدوية.

الملحق ١٠. تقرير / سجل الجرد

تاريخ الجرد:	الخدمة / القسم:	التوقيع:
اسم المسؤول:	اللقب:	التوقيع:
اسم الشاهد:	اللقب:	التوقيع:

وصف البند	السجل		ملاحظات (مثلاً، الإجراء المطلوب، والإجراء المتخذ)
	الوظيفي	غير الوظيفي	

المصدر: شراء وإدارة اللوازم والمعدات. In: Kaur M, Hall S. Medical supplies and equipment for primary health care. Surrey (UK): ECHO International Health Services Ltd; 2001:13–28 (http://www.frankshospitalworkshop.com/organisation/management_documents/Medical%20Supplies%20and%20Equipment%20for%20Primary%20Health%20Care%20-%20ECHO.pdf, accessed 18 March 2022).

الملحق ١١. نموذج طلب تعديل المخزون

الرقم التسلسلي للنموذج: _____

التاريخ (اليوم / الشهر / السنة): _____

المنشأ: _____

الوجهة: _____

اسم وعنوان الشخص المسؤول:

قائمة تعديل المخزون:

الرقم	رمز المخزون	نوع المخزون	الكمية الأصلية	الكمية المخفضة	ملاحظات
١					
٢					
٣					
٤					
٥					
٦					
٧					

الرقم	رمز المخزون	نوع المخزون	الكمية الأصلية	الكمية المخفضة	ملاحظات
٨					
٩					
١٠					

الإدارة: _____

بطلب من _____ بموافقة من: _____

التوقيع: _____ التوقيع: _____

الاسم: _____ الاسم: _____

التاريخ (اليوم / الشهر / السنة) _____ التاريخ (اليوم / الشهر / السنة) _____

الملحق ١٢. أمثلة وثائق النفايات الصيدلانية وتدمير هذه النفايات

أ. ١٢,١ النفايات الصيدلانية لغرض التخلص منها أو تدميرها – سجل موزع الأدوية في المجتمع

(تصاحب مواد النفايات التي جمعت لغرض التخلص منها أو تدميرها)

موقع المعالجة الجموعية		نوع تخزين النفايات (مثلاً، في أكياس بلاستيكية)	
اسم موزع الأدوية في المجتمع / العامل الصحي		ايصال من نقطة الاتصال في المركز الصحي موقع ومؤرخ (اليوم / الشهر / السنة)	
التاريخ			

اسم البند	نوع التعبئة	تاريخ انتهاء الصلاحية	العدد / الكمية المعادة	تعليق
(مثال) زجاجة بها ٥٠٠ قرص ألبيندازول	زجاجة	٢٠٢٠/١٢/٢١	٥	تم تنظيف الزجاجات وفقاً للإرشادات المناسبة وحفظها من قبل العاملين الصحيين المجتمعيين

أ ٢,١٢ النفايات الصيدلانية لغرض التخلص منها / تدميرها – سجل المركز الصحي

موقع المركز الصحي		نوع تخزين النفايات (مثلاً، أكياس بلاستيكية)	
اسم نقطة الاتصال		ايصال من نقطة الاتصال في المركز الصحي موقع ومؤرخ (اليوم / الشهر / السنة)	
التاريخ (اليوم / الشهر / السنة)			

اسم البند	نوع التعبئة	تاريخ انتهاء الصلاحية (اليوم / الشهر / السنة)	العدد / الكمية المعادة	التعليق
(مثال) أقراص ألبيندازول تالفة	زجاجة	٢٠٢٠/١٢/٢١	٢١٥ قرصاً	

أ ٣,١٢ النفايات الصيدلانية لغرض التخلص منها أو تدميرها – سجل المرفق الصحي في المقاطعة

المرفق الصحي في المقاطعة		نوع تخزين النفايات (مثلاً، في أكياس بلاستيكية)	
اسم نقطة الاتصال		إيصال من المرفق الصحي الإقليمي موقع ومؤرخ (اليوم / الشهر / السنة)	
التاريخ (اليوم / الشهر / السنة)			

اسم البند	نوع التعبئة	تاريخ انتهاء الصلاحية (اليوم / الشهر / السنة)	العدد / الكمية المعادة	شكل وتاريخ التخلص (اليوم / الشهر / السنة)	التعليق
(مثال) أقراص ألبيندازول تالفة	زجاجة	٢٠٢٠/١٢/٢١	٢١٥ قرصاً		أُرسلت إلى المرفق الصحي الإقليمي

أ ٤,١٢ النفايات الصيدلانية لغرض التخلص منها أو تدميرها – سجل المرفق الصحي الإقليمي

المرفق الصحي الإقليمي		نوع تخزين النفايات (مثلاً، كيس بلاستيكي)	
اسم نقطة الاتصال		إيصال من المرفق الصحي الوطني موقع ومؤرخ (اليوم / الشهر / السنة)	
التاريخ (اليوم / الشهر / السنة)		الصيدلي المشرف على تدمير النفايات	

اسم البند	نوع التعبئة	تاريخ انتهاء الصلاحية (اليوم / الشهر / السنة)	العدد / الكمية المعادة	شكل وتاريخ التخلص (اليوم / الشهر / السنة)	التعليق
(مثال) أقراص ألبيندازول تالفة	زجاجة	٢٠٢٠/١٢/٢١	٢١٥ قرصاً	الترميد (٢٠٢١/١/٢١)	تم الترميد في فرن مصنع أسمنت XXXX

أ ٥,١٢ النفايات الصيدلانية لغرض التخلص منها أو تدميرها – سجل المرفق الصحي الوطني

المرفق الصحي الوطني		نوع تخزين النفايات (مثلاً، كيس بلاستيكي)	
اسم نقطة الاتصال		إيصال من المرفق الصحي الوطني موقع ومؤرخ	
التاريخ (اليوم / الشهر / السنة)		الصيدلي المشرف على تدمير النفايات:	

المقاطعة	اسم البند	نوع التعبئة	تاريخ انتهاء الصلاحية (اليوم / الشهر / السنة)	العدد / الكمية المعادة	شكل وتاريخ التخلص (اليوم / الشهر / السنة)	التعليق
	(مثال) أقراص ألبيندازول منتهية الصلاحية	زجاجة	٢٠٢٠/١٢/٢١	١٧٠ قرصاً	الترميد (٢٠٢١/١/١٢)	


9789240082045
9 789240 082045